

Buku Referensi

KEPERAWATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL

Asuhan Klinis Komprehensif Sepanjang Rentang Kehidupan

Nasrun Pakaya • Marita Kumala Dewi • Kurniawati
Awaliyah Muslimah Suwetty • Yanti Apriyanti
Osep Yasier Almunsiri • Mihrawaty S. Antu



BUKU REFERENSI

KEPERAWATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL

ASUHAN KLINIS KOMPREHENSIF

SEPANJANG RENTANG KEHIDUPAN

Penulis:

Dr. Nasrun Pakaya, S.Kep., Ns., M.Kep.

Marita Kumala Dewi, S.Kep., Ns., MAN.

Kurniawati, S.Kep., Ns., M.Kep.

Awaliyah Muslimah Suwetty, S.Kep., Ns., M.Kep.

Yanti Apriyanti, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.J.

Osep Yasier Almunsiri, S.Kep., Ners., M.Kep.

Mihrawaty S. Antu, S.Kep., Ns., M.Kep.



Buku Referensi Keperawatan Jiwa dan Psikososial Asuhan Klinis Komprehensif Sepanjang Rentang Kehidupan

Penulis:

Dr. Nasrun Pakaya, S.Kep., Ns., M.Kep.
Marita Kumala Dewi, S.Kep., Ns., MAN.
Kurniawati, S.Kep., Ns., M.Kep.
Awaliyah Muslimah Suwetty, S.Kep., Ns., M.Kep.
Yanti Apriyanti, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.J.
Osep Yasier Almunsiri, S.Kep., Ners., M.Kep.
Mihrawaty S. Antu, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-01-5

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku referensi yang berjudul *Keperawatan Jiwa dan Psikososial: Asuhan Klinis Komprehensif Sepanjang Rentang Kehidupan* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya pada bidang keperawatan jiwa dan psikososial yang memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mental individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh. Seseorang tidak hanya dikatakan sehat apabila terbebas dari penyakit fisik, tetapi juga mampu berpikir secara jernih, mengelola emosi, menjalin hubungan sosial yang sehat, beradaptasi dengan perubahan, serta menjalankan peran kehidupan secara produktif. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan tekanan, perubahan sosial, tuntutan ekonomi, perkembangan teknologi, serta berbagai tantangan psikososial, kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan jiwa semakin meningkat dan menjadi perhatian penting dalam sistem pelayanan kesehatan.

Keperawatan jiwa dan psikososial memiliki cakupan yang luas karena berhubungan dengan respons manusia terhadap masalah kesehatan mental, gangguan jiwa, stres, krisis, trauma, perubahan perkembangan, serta berbagai kondisi psikososial yang dapat terjadi pada setiap tahap kehidupan. Asuhan keperawatan jiwa tidak hanya diberikan kepada individu yang mengalami gangguan mental berat, tetapi juga kepada individu yang menghadapi kecemasan, depresi, kehilangan, konflik keluarga, masalah adaptasi, penyalahgunaan zat, kekerasan, isolasi sosial, hingga gangguan perilaku pada anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.

Buku referensi ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar keperawatan jiwa dan psikososial, proses asuhan keperawatan, komunikasi terapeutik, pengkajian status mental, intervensi keperawatan jiwa, serta pendekatan klinis terhadap berbagai masalah psikososial sepanjang rentang kehidupan. Pembahasan dalam buku ini juga menekankan pentingnya pelayanan yang holistik, humanis, berpusat pada pasien, serta memperhatikan aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, budaya, dan lingkungan.

Dalam praktik keperawatan jiwa, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan profesional yang tidak hanya mencakup pengetahuan klinis, tetapi juga keterampilan komunikasi, empati, pengendalian diri, kemampuan membangun hubungan saling percaya, serta kepekaan terhadap kondisi emosional pasien dan keluarga. Perawat juga berperan dalam promosi kesehatan jiwa, pencegahan gangguan mental, deteksi dini masalah psikososial, pendampingan pasien, edukasi keluarga, rehabilitasi psikososial, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan kesejahteraan mental.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kesehatan jiwa dan psikososial. Melalui penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan mampu membantu pembaca memahami teori, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan jiwa secara lebih mendalam, baik dalam konteks pendidikan maupun praktik klinis di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Penyusunan buku ini juga dilandasi oleh pentingnya pendekatan sepanjang rentang kehidupan dalam pelayanan keperawatan jiwa. Setiap tahap kehidupan memiliki karakteristik perkembangan, kebutuhan psikologis, risiko masalah mental, serta bentuk dukungan yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebutuhan kesehatan jiwa pada anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia menjadi sangat penting agar perawat mampu memberikan asuhan yang sesuai, tepat, dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi, keluasan pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku referensi Keperawatan Jiwa dan Psikososial: Asuhan Klinis Komprehensif Sepanjang Rentang Kehidupan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu keperawatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Semoga buku ini juga dapat menjadi salah satu rujukan yang mendukung lahirnya perawat yang profesional, empatik, berintegritas, serta mampu memberikan asuhan keperawatan jiwa yang aman, bermartabat, dan berorientasi pada pemulihan serta kualitas hidup pasien.

Penulis

Mei, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

BAB I KONSEP DASAR KEPERAWATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL..... 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Paradigma Sehat-Jiwa.....	2
C. Etika	7
D. Budaya	11
B. Keselamatan.....	14
C. Perlindungan Hak Pasien	15
D. Penutup	16
Referensi.....	19

BAB II PENGKAJIAN STATUS MENTAL DAN RESIKO.....21

A. Pendahuluan.....	21
B. Konsep Dasar Pengkajian Status Mental dan Risiko.....	22
C. Pemeriksaan Status Mental (Mental Status Examination - MSE)	23
D. Skrining Depresi dan Ansietas	26
E. Resiko bunuh diri.....	27
F. Resiko Kekerasan	29
G. Faktor Protektif.....	31
H. Penutup	33
Referensi.....	34

BAB III KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN HUBUNGAN PERAWAT-KLIEN PADA PASIEN DENGAN MASALAH PSIKOSOSIAL DAN GANGGUAN

JIWA 35

E. Pendahuluan.....	35
F. Dasar Konsep Komunikasi Terapeutik Dalam Keperawatan Jiwa.....	35
B. Tahapan Hubungan Perawat - Klien dalam konteks keperawatan jiwa.....	38
C. Teknik Wawancara dalam Keperawatan Jiwa	40
D. Empati Dalam Hubungan Terapeutik	42
E. Batas Profesional dalam Hubungan Terapeutik	43

F. Manajemen Perilaku Pasien dalam Keperawatan Jiwa.....	45
G. Aplikasi Komunikasi Terapeutik Pada Masalah Psikososial dan Gangguan Jiwa.....	47
Refrensi	49
BAB IV ASUHAN KEPERAWATAN PADA GANGGUAN JIWA UMUM.....	53
A. Pendahuluan.....	53
B. Asuhan Keperawatan pada Skizoprenia	54
C. Asuhan Keperawatan Gangguan Mood	58
D. Asuhan Keperawatan Ansietas.....	61
E. Asuhan Keperawatan <i>Post Trauma Distress Syndrome</i> (PTSD).....	65
F. Asuhan Keperawatan Pada Gangguan Kepribadian	69
G. Asuhan Keperawatan Penyalahgunaan Zat.....	73
H. Penutup	76
Referensi.....	77
BAB V INTERVENSI KEPERAWATAN PSIKOSOSIAL BERBASIS BUKTI (PSIKOEDUKASI, CBT DASAR, TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK, MANAJEMEN STRES, RELAKSASI, DAN COPING SKILLS).....	81
A. Pendahuluan.....	81
B. Pentingnya Intervensi Psikososial Berbasis Bukti dalam Keperawatan	82
C. Konsep Psikoedukasi untuk Memberdayakan Pasien dan Keluarga.....	83
D. Prinsip Dasar Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dalam Mengubah Pola Pikir	84
E. Membangun Kemandirian melalui Terapi Aktivitas Kelompok (TAK).....	85
F. Tahapan Pelaksanaan Terapi Kelompok yang Efektif di Lapangan	86
G. Manajemen Stres melalui Berbagai Teknik Relaksasi Mandiri	87
H. Pengembangan Strategi Koping Adaptif untuk Menghadapi Masalah.....	88
I. Implementasi Intervensi Psikososial bagi Pasien di Berbagai Rentang Usia	89
J. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Asuhan Keperawatan Psikososial.....	90
K. Penutup	91
Referensi.....	92

BAB VI KRISIS PSIKOLOGIS DAN KEGAWATDARURATAN PSIKIATRI	95
A. Pendahuluan.....	95
B. Krisis Psikologis	95
C. Kegawatdaruratan Psikiatri.....	96
D. Agitasi	97
E. Delirium	98
F. Intoksikasi/Putus Zat	99
G. Self Harm	100
H. Stabilisasi Awal.....	101
I. Rujukan.....	101
J. Penutup	101
Referensi.....	102

BAB VII PEMULIHAN, REHABILITASI, DAN KEPERAWATAN JIWA	
KOMUNITAS	103
A. Pendahuluan.....	103
B. Pemulihan.....	103
C. Rehabilitasi	103
D. Keperawatan Jiwa Komunitas.....	104
E. Recovery Oriented Care.....	105
F. Dukungan Keluarga	105
G. Stigma	106
H. Kepatuhan Terapi.....	106
I. Follow Up.....	107
J. Kolaborasi Lintas Sektor	107
Referensi.....	108

PROFIL PENULIS	109
-----------------------------	------------

BAB I

KONSEP DASAR KEPERAWATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL

A. Pendahuluan

Komponen esensial dalam kesehatan secara menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fisik dan sosial yaitu kesehatan jiwa. World Health Organization menegaskan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi sejahtera di mana individu mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari, bekerja secara produktif, serta berkontribusi dalam masyarakat (WHO, 2025). Kesehatan jiwa bukan sekadar tidak ada gangguan mental, tetapi mencakup kemampuan adaptasi dan fungsi optimal individu dalam kehidupan sehari-hari.

Secara global, masalah kesehatan jiwa menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem kesehatan. Laporan WHO menunjukkan bahwa gangguan mental berkontribusi signifikan terhadap beban penyakit global, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan psikotik (WHO, 2022). Selain itu, peningkatan stres akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi turut memperbesar risiko gangguan kesehatan mental pada berbagai kelompok usia. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada individu.

Di Indonesia, kesehatan jiwa juga menjadi isu strategis dalam pembangunan kesehatan. Masih terdapat berbagai tantangan seperti stigma terhadap gangguan mental, keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa, serta praktik yang melanggar hak pasien seperti pemasungan (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Selain itu, faktor budaya dan sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi masyarakat terhadap kesehatan jiwa dan perilaku pencarian pertolongan.

Keperawatan jiwa dan psikososial hadir sebagai bagian penting dalam menjawab tantangan tersebut. Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan yang tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, dan budaya pasien. Dalam praktiknya, perawat berperan sebagai pemberi asuhan, edukator, konselor, advokat, serta fasilitator dalam meningkatkan kesehatan mental individu dan masyarakat (Keynejad et al., 2021).

Perkembangan ilmu keperawatan jiwa menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penyakit menuju pendekatan berbasis

kesehatan dan pemulihan (recovery-oriented care). Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan pasien, partisipasi aktif dalam proses perawatan, serta penghargaan terhadap pengalaman subjektif individu (Lim et al., 2024). Selain itu, pendekatan *person-centered care* terbukti meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien dalam praktik keperawatan jiwa modern (Isler et al., 2025).

Dalam konteks pendidikan dan praktik profesional, pemahaman terhadap konsep dasar keperawatan jiwa dan psikososial menjadi sangat penting sebagai landasan dalam memberikan asuhan yang efektif, etis, dan aman. Konsep-konsep tersebut mencakup paradigma sehat-jiwa, etika, budaya, keselamatan pasien, serta perlindungan hak pasien. Kelima aspek ini saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja dalam praktik keperawatan jiwa yang komprehensif.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar keperawatan jiwa dan psikososial sebagai fondasi dalam praktik profesional. Dengan memahami konsep-konsep ini, diharapkan perawat mampu memberikan asuhan yang holistik, berpusat pada pasien, serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap intervensi keperawatan.

B. Paradigma Sehat-Jiwa

Keperawatan jiwa dan psikososial merupakan bagian integral dari paradigma sehat-jiwa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mental individu secara menyeluruh. Perawat memiliki peran strategis dalam membantu individu menghadapi krisis, mengatasi gangguan mental, serta mencapai kehidupan yang bermakna dalam berbagai konteks kehidupan.

Paradigma merupakan fondasi utama dalam keperawatan jiwa dan psikososial untuk menentukan cara pandang perawat dalam memahami kondisi mental individu serta merancang intervensi keperawatan. Paradigma mengalami transformasi dari pendekatan yang berorientasi pada penyakit (*illness-oriented*) menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berpusat pada kesejahteraan (*wellness-oriented*). Perubahan ini mencerminkan pemahaman bahwa kesehatan jiwa tidak hanya berkaitan dengan tidak adanya gangguan mental, tetapi mencakup kemampuan individu untuk menjalani kehidupan secara produktif, bermakna, dan adaptif.

World Health Organization mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai kondisi di mana individu mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi stres kehidupan, bekerja secara produktif, dan berkontribusi dalam masyarakat (WHO, 2025). Definisi ini menekankan bahwa kesehatan jiwa mencakup kemampuan individu dalam menjalankan fungsi kehidupan secara optimal. Oleh karena itu, konsep sehat-jiwa bersifat multidimensional, melibatkan aspek emosional, psikologis, sosial, dan spiritual.

Dalam berbagai setting klinis (Moreno-poyato et al., 2017), perawat sering kali berhadapan dengan individu yang sedang mengalami berbagai bentuk krisis kehidupan. Krisis tersebut dapat bersumber dari gangguan fisik, tekanan psikologis, masalah mental, maupun distress spiritual. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup individu secara keseluruhan. Banyak individu dalam kehidupan sehari-hari menghadapi situasi sulit yang memerlukan dukungan tidak hanya secara medis, tetapi juga secara emosional dan sosial. Dalam konteks ini, keperawatan jiwa dan psikososial hadir sebagai bidang praktik yang memberikan kontribusi penting dalam membantu individu mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Pengalaman praktik keperawatan jiwa memberikan kesempatan bagi perawat untuk memahami secara lebih mendalam pengalaman individu yang mengalami perubahan atau gangguan kesehatan mental. Proses ini tidak hanya meningkatkan kemampuan profesional, tetapi juga dapat memperluas wawasan dan refleksi diri perawat terhadap kondisi psikologisnya sendiri (Odeyemi et al., 2018).

Keperawatan jiwa dan kesehatan mental merupakan salah satu spesialisasi dalam ilmu keperawatan yang berfokus pada upaya meningkatkan kesehatan mental melalui proses pengkajian, diagnosis, dan penatalaksanaan masalah perilaku, gangguan mental, serta kondisi komorbid sepanjang rentang kehidupan. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh American Nurses Association (ANA) yang menegaskan bahwa perawat jiwa memiliki peran dalam memberikan asuhan kepada individu dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia (Halter, 2018).

Keterkaitan antara keperawatan jiwa dan paradigma sehat-jiwa sangat erat. Paradigma sehat-jiwa menekankan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kehidupan. Oleh karena itu, perawat jiwa harus mampu memahami individu secara holistik serta memberikan asuhan yang tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi juga pada konteks kehidupan pasien secara menyeluruh (Santangelo et al., 2018).

Dalam kerangka paradigma sehat-jiwa, peran perawat tidak hanya sebagai pemberi asuhan klinis, tetapi juga sebagai edukator, konselor, advokat, dan fasilitator. Perawat membantu individu mengembangkan mekanisme koping yang adaptif, meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap stres, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *person-centered care* dan *recovery-oriented care* yang menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan (Gabrielsson et al., 2020).

1. Kontinum Kesehatan Jiwa

Kesehatan mental dalam paradigma kesehatan jiwa modern tidak lagi dipandang secara dikotomis sebagai “sehat” atau “sakit”, tetapi berada dalam suatu rentang yang bersifat dinamis. Konsep ini dikenal sebagai *mental health continuum* atau kontinum kesehatan mental. Melalui pendekatan ini, kondisi mental individu dipahami berada pada suatu spektrum yang bergerak dari kesehatan mental optimal hingga gangguan jiwa yang berat.

Pada salah satu ujung kontinum terdapat kesehatan mental (*mental health*) yang ditandai dengan kondisi kesejahteraan psikologis (*well-being*). Individu pada kategori ini menunjukkan fungsi yang adekuat hingga optimal dalam kehidupan sehari-hari (Coronel-santos & Rodríguez-macías, 2022). Meskipun demikian, mereka tetap dapat mengalami stres, ketidaknyamanan, atau tekanan akibat permasalahan kehidupan sehari-hari. Namun, kondisi tersebut tidak menimbulkan gangguan yang bermakna terhadap fungsi sosial, pekerjaan, maupun aktivitas harian.

Sebagai contoh, seseorang dapat mengalami hari-hari yang dipenuhi keraguan diri setelah gagal dalam ujian, mengalami malam tanpa tidur karena kekhawatiran terhadap masalah ringan, atau merasakan kesedihan mendalam sementara setelah kehilangan orang yang dicintai. Pada kondisi tersebut, individu masih memiliki kesadaran bahwa fungsi dirinya sedang tidak optimal. Dengan dukungan strategi koping adaptif seperti istirahat yang cukup, aktivitas fisik, pola makan seimbang, interaksi sosial, serta kemampuan reframing kognitif, kondisi tersebut umumnya dapat membaik secara bertahap.

Pada bagian tengah kontinum terdapat kondisi yang dapat disebut sebagai masalah kesehatan mental atau distress psikologis ringan hingga sedang. Individu pada kelompok ini mulai mengalami gangguan emosional yang ditandai dengan ketidaknyamanan psikologis, seperti kecemasan, suasana hati yang menurun, atau stres yang menetap. Pada tahap ini, dapat muncul gangguan fungsi ringan seperti kesulitan tidur (*insomnia*), penurunan konsentrasi, mudah lelah, atau penurunan nafsu makan. Meskipun demikian, fungsi sehari-hari masih relatif dapat dipertahankan.

Jika kondisi ini berlangsung lebih lama atau semakin berat, individu biasanya mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Kondisi dalam kategori ini bersifat sementara dan sering dijumpai pada gangguan seperti depresi ringan, gangguan kecemasan umum (*generalized anxiety disorder*), atau gangguan pemusatan perhatian (*attention-deficit disorder*) dalam derajat ringan hingga sedang.

Pada ujung lainnya dari kontinum terdapat kondisi gangguan jiwa (*mental illness*) yang lebih berat. Individu pada kategori ini mengalami gangguan yang

signifikan pada proses berpikir, suasana perasaan (*mood*), dan perilaku. Gangguan tersebut dapat mencakup berbagai diagnosis klinis, mulai dari depresi berat dan gangguan kecemasan berat hingga gangguan psikotik seperti skizofrenia.

Ciri utama dari kondisi ini adalah adanya gangguan fungsi yang bersifat kronis atau jangka panjang dengan tingkat keparahan dari sedang hingga berat, yang berdampak signifikan terhadap kemampuan individu dalam menjalankan peran sosial, pekerjaan, dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada kondisi ini, diperlukan intervensi profesional kesehatan jiwa yang komprehensif, termasuk terapi farmakologis, psikoterapi, serta dukungan rehabilitasi psikososial (Townsend & Morgan, 2018).

Penting untuk dipahami bahwa setiap individu dapat berada pada titik yang berbeda dalam kontinum kesehatan mental ini, dan posisi tersebut dapat berubah secara perlahan maupun tiba-tiba tergantung pada berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial. Sebagian besar individu mungkin tidak pernah mencapai tahap gangguan jiwa berat, namun sebagian lainnya dapat mengalaminya dalam perjalanan hidup.

Individu yang berada pada tingkat gangguan berat tetap memiliki peluang untuk pulih (*recovery*). Proses pemulihan ini dapat bervariasi, mulai dari peningkatan fungsi secara bertahap hingga kemampuan untuk kembali menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif.

Dengan demikian, paradigma sehat-jiwa menekankan bahwa kesehatan mental bukan kondisi statis, melainkan suatu spektrum dinamis yang dapat berubah. Pendekatan ini memperkuat pentingnya promosi kesehatan mental, pencegahan gangguan jiwa, deteksi dini, serta intervensi yang tepat untuk mendukung individu bergerak menuju kondisi kesejahteraan psikologis yang optimal.

2. Faktor Risiko

Kondisi kesehatan mental individu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat berperan sebagai faktor risiko (*risk factors*) maupun faktor protektif (*protective factors*). Faktor-faktor ini memengaruhi tingkat keparahan, perjalanan, serta prognosis gangguan jiwa, termasuk juga kondisi kesehatan mental individu yang tidak mengalami gangguan jiwa. Menurut WHO (2012), kesehatan mental dipengaruhi oleh karakteristik individu, kondisi sosial ekonomi, serta lingkungan tempat individu berada.

a. Karakteristik dan Perilaku Individu

Karakteristik individu mencakup aspek bawaan (*inborn*) maupun yang dipelajari (*learned*), yang membentuk keunikan setiap individu dalam berpikir,

merasakan, dan berperilaku. Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam mengelola pikiran, emosi, serta menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk merespons isyarat sosial dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial juga berpengaruh terhadap konsep diri dan bagaimana individu dipersepsikan oleh orang lain.

Faktor biologis dan genetik juga memiliki peran penting dalam kesehatan mental. Contohnya, paparan alkohol pada masa prenatal atau kondisi kekurangan oksigen saat persalinan dapat memengaruhi perkembangan otak dan fungsi psikologis. Faktor genetik juga diketahui berkontribusi besar terhadap berbagai gangguan jiwa, karena hampir seluruh gangguan psikiatri memiliki komponen hereditas yang signifikan.

Salah satu faktor protektif penting adalah resiliensi, yaitu kemampuan individu untuk bertahan dan bangkit kembali dari tekanan, trauma, kehilangan, atau kesulitan hidup. Resiliensi mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengakses sumber daya internal maupun eksternal yang mendukung kesejahteraan psikologisnya. Misalnya, anak yang hidup dalam kondisi kemiskinan atau kekerasan dapat menunjukkan resiliensi ketika ia mampu mencari dukungan dari orang dewasa yang dipercaya, sehingga tetap dapat berkembang secara adaptif.

Namun, resiliensi bukan berarti individu tidak mengalami dampak stres. Individu yang resilien tetap dapat mengalami stres, tetapi mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatur emosi dan tidak mudah terjebak dalam pola pikir negatif yang merusak diri. Kemampuan regulasi emosi ini menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan mental.

b. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Lingkungan sosial terdekat, terutama keluarga, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kesehatan mental individu. Keluarga dapat menjadi sumber dukungan yang membangun rasa percaya diri dan kemampuan koping, namun juga dapat menjadi sumber kecemasan dan perasaan tidak adekuat jika lingkungan tidak kondusif.

Selain keluarga, lingkungan sekolah dan kelompok teman sebaya juga berperan penting. Lingkungan ini dapat memberikan dampak positif melalui dukungan sosial, maupun dampak negatif seperti tekanan teman sebaya (peer pressure) dan bullying.

Status sosial ekonomi juga sangat menentukan kualitas kesehatan mental seseorang. Individu dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya mendukung

stabilitas psikologis. Pendidikan juga merupakan faktor protektif penting karena memberikan peluang kerja yang lebih baik, stabilitas ekonomi, serta rasa kontrol terhadap masa depan.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dalam kesehatan mental mencakup aspek politik, budaya, serta sistem sosial yang lebih luas. Akses terhadap kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, air bersih, keamanan, dan sistem transportasi yang memadai memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan mental masyarakat.

Kebijakan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, nasional, maupun global juga memengaruhi kesehatan mental. Sebagai contoh, peningkatan kebijakan pembiayaan layanan kesehatan jiwa dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan profesional, sehingga membantu deteksi dini dan penanganan gangguan mental.

C. Etika

Etika dalam keperawatan jiwa dan psikososial merupakan komponen esensial yang tidak terpisahkan dari praktik profesional. Dalam konteks keperawatan kesehatan jiwa, perawat dihadapkan pada situasi klinis yang kompleks, di mana gangguan proses pikir, persepsi, maupun penilaian realitas pada pasien dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, pendekatan etik dalam keperawatan jiwa selalu berkaitan erat dengan pertimbangan legal dan standar praktik profesional berbasis evidensi.

Dalam kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Townsend (2018), prinsip bioetika menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis. Prinsip utama yang menjadi dasar praktik keperawatan jiwa meliputi:

1. *Autonomy* (Otonomi)

Menghargai hak pasien dalam membuat keputusan terkait perawatan dirinya.

2. *Beneficence* (Berbuat Baik)

Memberikan intervensi yang menguntungkan pasien.

3. *Non-maleficence* (Tidak Merugikan)

Menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien, baik fisik maupun psikologis.

4. *Justice* (Keadilan)

Memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi.

5. *Veracity* (Kejujuran)

Menyampaikan informasi secara benar dan transparan.

6. *Fidelity* (Kesetiaan)

Menjaga kepercayaan pasien dan komitmen profesional.

Dalam praktik keperawatan jiwa, aspek legal memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip etika. Perawat tidak hanya dituntut untuk bertindak sesuai nilai moral, tetapi juga harus memahami kerangka hukum yang mengatur pelayanan kesehatan jiwa. Townsend menekankan bahwa pemahaman terhadap aspek legal sangat penting untuk melindungi hak pasien sekaligus menjaga keamanan praktik profesional.

Berikut adalah isu legal dalam Keperawatan Jiwa dan Kesehatan Mental:

1. *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan)

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan pasien setelah menerima informasi yang lengkap dan dapat dipahami terkait tindakan yang akan dilakukan. Secara hukum, setiap individu memiliki hak untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak suatu tindakan medis. Jika tenaga kesehatan memberikan tindakan tanpa persetujuan pasien, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, seperti *assault* (penyerangan) atau tindakan tanpa izin, meskipun tindakan tersebut bertujuan menyelamatkan nyawa (Guido, 2014). Prinsip dasar informed consent adalah melindungi dan mempertahankan otonomi individu dalam menentukan apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Contoh tindakan dalam keperawatan jiwa yang memerlukan informed consent adalah Terapi elektrokonvulsif (ECT).

2. *Right to Refuse Treatment* (Hak Menolak Pengobatan)

Setiap pasien memiliki hak untuk menolak tindakan medis sebagai bagian dari prinsip otonomi, yaitu hak individu untuk menentukan tindakan yang akan atau tidak akan dilakukan terhadap dirinya. Dalam konteks keperawatan jiwa, setiap pasien pada dasarnya memiliki hak untuk menerima atau menolak intervensi medis setelah mendapatkan informasi yang memadai. Hak ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan individu dalam mengambil keputusan terkait kesehatannya. Namun demikian, dalam praktik keperawatan jiwa, penerapan hak ini tidak selalu bersifat absolut. Terdapat kondisi tertentu di mana hak menolak pengobatan dapat dibatasi, terutama saat pasien dinilai tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengambil keputusan atau ketika penolakan tersebut berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, pasien dengan gangguan psikotik berat atau risiko bunuh diri mungkin tidak mampu membuat keputusan rasional, sehingga intervensi tetap dapat dilakukan demi keselamatan. Perawat memiliki peran penting dalam menghadapi situasi ini, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap alasan penolakan, menilai kapasitas pengambilan keputusan pasien, serta memberikan edukasi yang jelas dan

empatik. Selain itu, perawat juga harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip etik, ketentuan hukum, dan keselamatan pasien. Dengan demikian, keseimbangan antara penghormatan terhadap hak pasien dan perlindungan terhadap keselamatan dapat tetap terjaga.

3. *Confidentiality and Right to Privacy* (Kerahasiaan dan Hak atas Privasi)

Kerahasiaan merupakan prinsip utama dalam hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Hak atas privasi merupakan hak dasar setiap individu yang dilindungi oleh hukum. Dalam konteks pelayanan kesehatan, termasuk keperawatan jiwa, perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan informasi pasien menjadi prinsip yang sangat penting dalam membangun hubungan terapeutik. Sebagian besar sistem hukum menetapkan bahwa catatan medis dan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan bersifat rahasia. Oleh karena itu, perawat harus memahami bahwa hanya individu yang terlibat langsung dalam perawatan pasien yang berhak untuk mengakses informasi medis pasien, mengamati kondisi pasien secara langsung, dan terlibat dalam diskusi terkait perawatan pasien. Penyebarluasan informasi kesehatan kepada pihak di luar tim perawatan hanya dapat dilakukan apabila pasien memberikan persetujuan tertulis dan terdapat ketentuan hukum yang mengharuskan (misalnya risiko bahaya). Dengan demikian, perawat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien sekaligus memahami batasan-batasan hukum terkait penggunaan informasi tersebut.

4. *Restraints and Seclusion* (Restrain dan Seklusi)

Restrain dan seklusi merupakan tindakan pembatasan yang digunakan dalam keperawatan jiwa untuk menjaga keselamatan pasien dan orang lain, namun hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Setiap pasien pada dasarnya memiliki hak atas kebebasan, privasi, dan keamanan, sehingga penggunaan tindakan ini harus sangat dibatasi dan menjadi pilihan terakhir. Penggunaan restrain dan seklusi bersifat kontroversial karena selain berpotensi menimbulkan cedera fisik, juga dapat menyebabkan dampak psikologis seperti trauma dan hilangnya kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan restrain, intervensi yang kurang restriktif harus diupayakan terlebih dahulu, seperti komunikasi terapeutik, pendekatan verbal (*talking down*), dan pemberian obat penenang. Restrain mencakup berbagai metode pembatasan gerak, baik secara mekanik, manual, maupun kimia, sedangkan seklusi adalah penempatan pasien secara terpisah dalam ruangan khusus yang aman. Penting untuk ditegaskan bahwa tindakan ini tidak boleh digunakan sebagai hukuman atau untuk kenyamanan staf, melainkan semata-mata untuk

keselamatan, dengan pengawasan ketat dan pertimbangan etik serta legal yang matang.

Dalam praktik keperawatan, khususnya keperawatan jiwa dan psikososial, perawat sering dihadapkan pada situasi yang kompleks yang dikenal sebagai dilema etik. Dilema etik merupakan suatu kondisi yang mengharuskan perawat untuk memilih di antara dua alternatif tindakan yang sama-sama tidak menguntungkan. Pada situasi ini, terdapat bukti atau alasan yang dapat mendukung baik “kebenaran moral” maupun “ketidakbenaran moral” dari masing-masing pilihan Tindakan (Catalano, 2015). Kondisi tersebut menimbulkan konflik batin yang disadari oleh individu yang harus mengambil keputusan.

Perlu dipahami bahwa tidak semua masalah etik merupakan dilema etik. Dilema etik muncul ketika tidak terdapat alasan yang jelas untuk memilih satu tindakan dibandingkan tindakan lainnya. Dalam situasi ini, kedua pilihan yang tersedia sering kali memiliki nilai yang sama-sama penting, sehingga masing-masing tindakan dapat dipandang benar dalam satu sisi, tetapi juga memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan di sisi lain. Oleh karena itu, dilema etik sering menimbulkan tekanan emosional yang signifikan bagi perawat.

Dalam banyak kasus, alasan yang mendukung masing-masing pilihan tindakan bersifat logis dan dapat diterima secara profesional. Tindakan yang dipilih mungkin memberikan manfaat tertentu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian. Sebaliknya, tindakan alternatif juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan secara cermat. Bahkan, dalam beberapa situasi, tidak mengambil tindakan pun dianggap sebagai suatu bentuk keputusan yang memiliki konsekuensi etik.

Sebagai contoh, seorang pasien menolak untuk mengonsumsi obat jantung yang diresepkan karena merasa tidak membutuhkannya. Dalam kondisi normal, pasien memiliki hak untuk menolak pengobatan sebagai bagian dari prinsip otonomi. Namun, jika pasien tersebut diketahui mengalami depresi dan memiliki kecenderungan bunuh diri, maka penolakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk perilaku menyakiti diri sendiri. Dalam situasi ini, perawat dihadapkan pada dilema antara menghormati hak pasien dan melindungi keselamatan pasien. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah tindakan apa yang paling tepat untuk diambil dalam kondisi tersebut.

Untuk membantu menghadapi dilema etik, banyak institusi pelayanan kesehatan telah menetapkan pedoman atau prosedur yang dapat digunakan sebagai acuan. Rumah sakit umumnya memiliki komite etik yang berfungsi untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan etik dari berbagai sudut pandang, baik klinis, hukum, maupun moral. Keterlibatan dalam diskusi bersama tim interdisipliner

dan komite etik dapat membantu perawat dalam memperoleh kejelasan serta dukungan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, perawat dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penilaian klinis dengan mengidentifikasi masalah etik secara dini dan melakukan eksplorasi secara kolaboratif. Pendekatan ini sejalan dengan praktik keperawatan berbasis evidensi, di mana keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga pada data klinis, prinsip etik, serta standar profesional yang berlaku.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai dilema etik menjadi sangat penting dalam keperawatan jiwa. Hal ini tidak hanya membantu perawat dalam mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga dalam menjaga kualitas asuhan, keselamatan pasien, serta integritas profesional dalam praktik keperawatan.

D. Budaya

Budaya merupakan determinan penting dalam kesehatan jiwa yang memengaruhi cara individu memahami, mengekspresikan, dan merespons gangguan mental. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Townsend (2018), aspek budaya menjadi bagian integral dalam proses keperawatan, khususnya dalam pengkajian, diagnosis, dan intervensi keperawatan yang berpusat pada pasien.

Budaya merupakan sistem nilai, kepercayaan, norma, dan praktik yang dipelajari serta diwariskan dalam suatu kelompok masyarakat, yang memengaruhi cara individu berpikir, berperilaku, dan merespons pengalaman hidup, termasuk kesehatan dan penyakit. Dalam keperawatan jiwa, pemahaman tentang budaya menjadi sangat penting karena budaya memengaruhi bagaimana individu menafsirkan gejala psikologis, mencari bantuan, serta merespons intervensi yang diberikan.

Selain budaya, konsep lain yang sering terkait adalah ras (*race*) dan etnisitas (*ethnicity*). Ras sering dikaitkan dengan karakteristik fisik, meskipun secara ilmiah konsep ini masih menjadi perdebatan. Sementara itu, etnisitas lebih mengacu pada kesamaan budaya, bahasa, nilai, dan asal-usul kelompok. Pengetahuan tentang budaya dan etnisitas penting karena faktor-faktor tersebut memengaruhi perilaku manusia, interpretasi terhadap kondisi kesehatan, serta respons terhadap tindakan keperawatan (Giger, 2017).

Budaya membentuk persepsi individu tentang apa yang dianggap sebagai perilaku normal dan abnormal. Selain itu, budaya juga memengaruhi cara individu mengekspresikan distress psikologis. Dalam beberapa kelompok budaya, gangguan emosional lebih sering diekspresikan dalam bentuk keluhan fisik (*somatisasi*), sedangkan pada budaya lain dapat diekspresikan secara verbal atau melalui perilaku

tertentu. Oleh karena itu, perawat perlu memahami bahwa manifestasi klinis gangguan jiwa tidak selalu universal, melainkan dipengaruhi oleh konteks budaya (Sue & Sue, 2016).

Budaya juga bersifat dinamis dan memiliki variasi internal yang disebut subkultur. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, agama, atau lingkungan tempat tinggal. Selain itu, individu dapat mengalami proses akulturasi (mengadopsi sebagian budaya lain) atau asimilasi (mengadopsi sebagian besar budaya dominan). Oleh karena itu, perawat harus menghargai keunikan setiap individu dalam konteks budaya dan spiritualnya.

Penting pula memahami *cultural-bound syndromes*, yaitu pola gejala yang khas pada kelompok budaya tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa diagnosis gangguan jiwa harus mempertimbangkan konteks budaya agar tidak terjadi kesalahan interpretasi terhadap perilaku pasien. Pemahaman ini menjadi sangat penting dalam praktik keperawatan jiwa di masyarakat multikultural.

Konsep *cultural competence* menjadi dasar dalam pemberian asuhan keperawatan yang sensitif budaya. *Cultural competence* mencakup kesadaran perawat terhadap nilai dan bias pribadi (*cultural awareness*), pengetahuan tentang budaya pasien (*cultural knowledge*), keterampilan dalam melakukan pengkajian budaya (*cultural skill*), serta kemauan untuk berinteraksi secara efektif dengan pasien dari berbagai latar belakang (*cultural encounter*). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip asuhan keperawatan yang holistik dan berpusat pada pasien.

Pengkajian budaya merupakan langkah penting dalam proses keperawatan jiwa. Pengkajian harus mencakup identitas budaya, bahasa yang digunakan, keyakinan tentang kesehatan dan penyakit, praktik pengobatan tradisional, serta peran keluarga dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak budaya, keluarga memiliki peran sentral dalam menentukan keputusan terkait perawatan, sehingga keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dalam intervensi keperawatan.

Namun demikian, praktik keperawatan lintas budaya tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti hambatan bahasa, stereotip, serta bias yang mungkin dimiliki oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perawat harus mengembangkan sikap terbuka, reflektif, dan tidak menghakimi dalam menghadapi perbedaan budaya. Pendekatan komunikasi terapeutik harus disesuaikan dengan nilai dan norma budaya pasien agar tercipta hubungan saling percaya.

Dalam konteks ini, perawat berperan sebagai *cultural broker*, yaitu penghubung antara sistem pelayanan kesehatan dengan budaya pasien. Perawat juga berperan sebagai edukator yang memberikan informasi kesehatan dengan cara yang dapat diterima oleh pasien sesuai dengan latar belakang budayanya. Selain itu,

perawat bertindak sebagai advokat yang memastikan bahwa pasien tidak mengalami diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.

Integrasi aspek budaya dalam keperawatan jiwa memungkinkan perawat memberikan asuhan yang lebih efektif, aman, dan bermakna bagi pasien. Dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, perawat dapat meningkatkan kualitas hubungan terapeutik serta mencapai hasil kesehatan yang optimal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keperawatan berbasis evidensi yang menempatkan pasien sebagai pusat dari setiap intervensi yang dilakukan.

Menurut Giger (2017), terdapat enam fenomena budaya utama yang perlu dipahami oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang sensitif budaya:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi mencakup seluruh perilaku verbal dan nonverbal dalam interaksi dengan orang lain. Budaya memengaruhi cara seseorang berbicara, menggunakan bahasa tubuh, intonasi suara, serta makna dari pesan yang disampaikan. Komponen komunikasi:

- a. Bahasa (lisan dan tulisan)
- b. Parabahasa (intonasi, kecepatan, nada suara)
- c. Nonverbal (ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh)

Perawat harus memahami cara komunikasi pasien sesuai budayanya. Jika terdapat perbedaan bahasa, penggunaan penerjemah dapat membantu, tetapi tetap memerlukan sensitivitas budaya agar pesan tidak disalahartikan.

2. Ruang (*Space*)

Ruang berkaitan dengan cara individu menggunakan dan memaknai jarak dalam interaksi sosial. Konsep utama:

- a. Teritorialitas: kebutuhan individu untuk memiliki dan mengontrol ruang
- b. Kepadatan (*density*): jumlah orang dalam suatu ruang
- c. Jarak (*distance*):
 - 1) Intim
 - 2) Personal
 - 3) Sosial

Perbedaan budaya memengaruhi kenyamanan seseorang terhadap jarak fisik saat berinteraksi.

3. Organisasi Sosial (*Social Organization*)

Organisasi sosial berkaitan dengan struktur sosial tempat individu belajar nilai dan norma budaya. Contohnya yaitu keluarga, kelompok agama, kelompok etnis. Nilai dan perilaku budaya dipelajari melalui proses sosialisasi (*enculturation*), terutama sejak masa kanak-kanak.

4. Waktu (*Time*)

Persepsi terhadap waktu berbeda antar budaya. Variasi orientasi waktu:

- a. Berorientasi masa kini (*present-oriented*)
- b. Berorientasi masa depan (*future-oriented*)

Beberapa budaya sangat menghargai ketepatan waktu, sementara budaya lain lebih fleksibel terhadap waktu.

5. Kontrol Lingkungan (*Environmental Control*)

Mengacu pada sejauh mana individu merasa mampu mengendalikan lingkungan dan kondisi hidupnya. Pengaruh budaya:

- a. Keyakinan tentang kesehatan dan penyakit
- b. Respons terhadap pengobatan
- c. Peran spiritualitas

Perawat perlu memahami bagaimana keyakinan budaya memengaruhi cara pasien menghadapi kondisi kesehatannya.

6. Variasi Biologis (*Biological Variations*)

Perbedaan biologis antar kelompok dapat memengaruhi respons terhadap intervensi kesehatan. Contoh struktur tubuh, warna kulit, respons terhadap obat, kerentanan terhadap penyakit, dan pola nutrisi. Pemahaman ini penting agar perawat dapat memberikan asuhan yang aman dan efektif.

B. Keselamatan

Keselamatan merupakan komponen fundamental dalam keperawatan jiwa yang bertujuan melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan dari risiko cedera fisik maupun psikologis. Lingkungan yang aman menjadi prasyarat utama dalam pelayanan rawat inap, mengingat pasien dengan gangguan jiwa memiliki kerentanan terhadap perilaku membahayakan seperti bunuh diri, agresivitas, maupun ketidakmampuan merawat diri.

Upaya keselamatan dimulai sejak pasien masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui identifikasi kebutuhan keselamatan dan pengkajian risiko secara komprehensif. Pemeriksaan terhadap barang pribadi pasien dilakukan untuk mencegah masuknya benda berbahaya seperti obat-obatan, alkohol, atau benda tajam. Selain itu, perawat memiliki peran penting dalam menilai risiko bunuh diri melalui wawancara dan observasi klinis yang sistematis.

Pemantauan terhadap pasien dilakukan secara berkala atau kontinu sesuai tingkat risiko. Pada pasien dengan ide bunuh diri aktif, pengawasan langsung secara terus-menerus sangat penting, karena tindakan bunuh diri dapat terjadi dalam waktu singkat dan tidak selalu dapat dicegah dengan observasi berkala setiap 15 menit. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya prosedur administratif,

tetapi merupakan proses dinamis yang membutuhkan kewaspadaan tinggi dari perawat.

Keselamatan pasien juga dipengaruhi oleh pengawasan terhadap lingkungan dan interaksi sosial. Kunjungan dapat memberikan dukungan, tetapi juga berpotensi membawa risiko, sehingga barang bawaan pengunjung harus diperiksa. Bahkan makanan dari luar perlu diawasi karena dapat tidak sesuai dengan kondisi medis atau terapi pasien. Hubungan intim antar pasien tidak diperbolehkan karena berisiko menimbulkan masalah kesehatan dan psikologis, terutama pada pasien yang sedang dalam kondisi rentan.

Keselamatan merupakan prioritas utama dalam keperawatan jiwa. Perawat harus mampu mengidentifikasi risiko secara dini, melakukan pengawasan yang tepat, serta menciptakan lingkungan yang aman tanpa mengabaikan aspek terapeutik.

C. Perlindungan Hak Pasien

Perlindungan hak pasien merupakan aspek penting dalam keperawatan jiwa yang berlandaskan pada prinsip etik dan hukum. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, serta diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Hak pasien menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis dan harus dihormati dalam setiap intervensi keperawatan.

Perlindungan hak pasien dalam keperawatan jiwa menekankan bagaimana hak-hak tersebut diimplementasikan dalam praktik klinis. Fokusnya bukan pada aspek hukum semata, tetapi pada bagaimana perawat memastikan pasien tetap dihormati, aman, dan bermartabat selama proses perawatan. Dalam konteks keperawatan jiwa, perlindungan hak pasien menjadi lebih kompleks karena adanya kondisi gangguan kognitif, emosi, atau persepsi yang dapat memengaruhi kemampuan pasien dalam mengambil keputusan.

Perlindungan hak pasien dalam keperawatan jiwa tidak hanya bersifat konseptual, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata dalam praktik sehari-hari. Perawat dituntut untuk mampu menerjemahkan prinsip-prinsip hak pasien ke dalam perilaku profesional yang menghargai martabat, menjaga privasi, serta mendukung otonomi pasien sesuai kondisi klinisnya.

Salah satu bentuk implementasi utama adalah menjaga martabat pasien dan memberikan perlakuan yang humanis. Perawat harus menghindari segala bentuk stigma dan diskriminasi terhadap pasien dengan gangguan jiwa, serta menghargai setiap pasien sebagai individu yang unik dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Pendekatan ini diwujudkan melalui komunikasi yang empatik,

penggunaan bahasa yang tidak merendahkan, serta sikap yang menghormati pasien sebagai manusia yang memiliki nilai dan hak yang sama.

Selain itu, menjaga privasi pasien menjadi bagian penting dalam perlindungan hak pasien. Dalam praktiknya, perawat harus memastikan bahwa tindakan keperawatan dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan dan kerahasiaan pasien, misalnya dengan menutup tirai saat melakukan tindakan, membatasi pembahasan kondisi pasien di ruang terbuka, serta mengontrol siapa saja yang memiliki akses untuk berinteraksi dengan pasien. Upaya ini bertujuan untuk melindungi informasi pribadi dan menjaga rasa aman pasien selama menjalani perawatan.

Perawat juga berperan dalam mendampingi pasien dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami sesuai dengan kemampuan kognitif pasien. Dalam kondisi tertentu, keluarga dapat dilibatkan sebagai pendukung dalam proses tersebut. Perawat perlu memastikan bahwa pasien memahami pilihan yang tersedia serta konsekuensi dari setiap keputusan, sehingga hak pasien untuk berpartisipasi dalam perawatan tetap terjaga.

Selanjutnya, dalam situasi tertentu yang memerlukan tindakan pembatasan, perawat harus melakukan pengawasan terhadap tindakan restriktif seperti restrain dan seklusi secara ketat. Tindakan ini hanya boleh dilakukan berdasarkan indikasi yang jelas dan sebagai pilihan terakhir. Selama tindakan berlangsung, perawat wajib melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap kondisi fisik dan psikologis pasien, serta mendokumentasikan seluruh prosedur secara lengkap dan akurat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan standar keselamatan dan tidak melanggar hak pasien.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hak pasien dalam keperawatan jiwa menuntut perawat untuk mengintegrasikan aspek etik, komunikasi terapeutik, serta pengambilan keputusan klinis secara tepat. Pendekatan ini memastikan bahwa pasien tetap mendapatkan perawatan yang aman, manusiawi, dan berpusat pada kebutuhan individu.

D. Penutup

Konsep dasar keperawatan jiwa dan psikososial merupakan fondasi utama dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif sepanjang rentang kehidupan. Pemahaman yang mendalam terhadap paradigma sehat–jiwa, prinsip etika, sensitivitas budaya, aspek keselamatan, serta perlindungan hak pasien menjadi landasan penting dalam praktik keperawatan jiwa yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pasien.

Paradigma sehat–jiwa menempatkan kesehatan mental sebagai kondisi yang dinamis dan berada dalam suatu kontinum, yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini menuntut perawat untuk tidak hanya berfokus pada gejala atau diagnosis, tetapi juga pada kemampuan individu dalam beradaptasi, mempertahankan fungsi, serta mencapai kualitas hidup yang optimal. Dengan demikian, asuhan keperawatan jiwa harus bersifat holistik, berkelanjutan, dan berpusat pada individu sebagai makhluk yang utuh.

Selain itu, penerapan prinsip etika dalam keperawatan jiwa menjadi sangat penting mengingat kerentanan pasien dalam aspek pengambilan keputusan dan perlindungan diri. Perawat dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai seperti penghormatan terhadap otonomi pasien, berbuat baik (beneficence), tidak merugikan (non-maleficence), keadilan (justice), kejujuran (veracity), dan kesetiaan (fidelity). Dalam situasi klinis yang kompleks, perawat harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pasien, keselamatan, serta aspek hukum dan profesional.

Aspek budaya juga memiliki peran yang signifikan dalam keperawatan jiwa. Setiap individu memiliki latar belakang budaya yang memengaruhi cara mereka memahami, mengekspresikan, dan merespons gangguan mental. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki kompetensi budaya agar mampu memberikan asuhan yang sensitif, relevan, dan dapat diterima oleh pasien serta keluarganya. Pendekatan yang menghargai nilai dan kepercayaan pasien akan memperkuat hubungan terapeutik serta meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan.

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan keperawatan jiwa. Risiko cedera diri, bunuh diri, maupun perilaku agresif menuntut perawat untuk memiliki kemampuan dalam melakukan pengkajian risiko secara akurat serta mengambil tindakan yang tepat dan cepat. Upaya menjaga keselamatan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga keselamatan psikologis dan emosional pasien. Hal ini menegaskan bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama dalam sistem pelayanan kesehatan.

Perlindungan hak pasien menjadi aspek fundamental dalam keperawatan jiwa yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia. Pasien dengan gangguan mental berhak mendapatkan pelayanan yang adil, manusiawi, dan bebas dari diskriminasi. Perawat memiliki peran sebagai advokat yang memastikan bahwa hak-hak pasien dihormati, termasuk hak atas informasi, privasi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatan.

Dalam perkembangan pelayanan kesehatan modern, keperawatan jiwa juga mengadopsi pendekatan person-centered care dan recovery-oriented care yang

menekankan pada pemberdayaan individu, partisipasi aktif pasien, serta pencapaian kehidupan yang bermakna. Pendekatan ini memperluas peran perawat tidak hanya sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai fasilitator, edukator, konselor, dan mitra dalam proses pemulihan pasien.

Dengan mengintegrasikan seluruh konsep tersebut, keperawatan jiwa dan psikososial diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan mental individu, keluarga, dan masyarakat. Perawat sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan kompetensi, meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan pasien, serta beradaptasi dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan jiwa.

Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dasar keperawatan jiwa dan psikososial tidak hanya menjadi bekal dalam praktik klinis, tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan ilmu, penelitian, serta kebijakan kesehatan mental di masa depan. Dengan demikian, perawat diharapkan mampu berperan aktif dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Referensi

- Catalano, J. T. (2015). *Nursing Now! Today's Issues, Tomorrow's Trends* (7th ed.). F.A. Davis.
- Coronel-santos, M. A., & Rodríguez-macías, J. C. (2022). Integral Definition and Conceptual Model of Mental Health: Proposal From A Systematic Review of Different Paradigms. *Frontiers in Sociology*. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.978804>
- Gabrielsson, S., Tuveesson, H., Gustin, L. W., Jormfeldt, H., & Care, H. (2020). Positioning Psychiatric and Mental Health Nursing as a Transformative Force in Health Care. *Issues in Mental Health Nursing*, 41(11), 976–984. <https://doi.org/10.1080/01612840.2020.1756009>
- Giger, J. N. (2017). *Transcultural Nursing: Assessment and Intervention* (7th ed.). MO: Mosby.
- Guido, G. W. (2014). *Legal and Ethical Issues in Nursing* (6th ed.). NJ: Pearson.
- Halter, M. J. (2018). Varcarolis' Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing A clinical Approach. *Varcarolis' Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach*, 1–1500.
- Isler, C., Maddigan, J., Moralejo, D., Gaudine, A., Burry, R., Deeb, A., & Mariathas, H. (2025). The Person-Centred Care Practices of Mental Health Nurses: A Cross-Sectional Study. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 32(6), 1392–1403. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jpm.70033>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*. KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
- Keynejad, R., Spagnolo, J., & Thornicroft, G. (2021). WHO mental health gap action programme (mhGAP) intervention guide: updated systematic review on evidence and impact. *BMJ*, 124–130. <https://doi.org/10.1136/ebmental-2021-300254>
- Lim, E., Wynaden, D., & Heslop, K. (2024). Mental health nurses ' attitudes towards mental illness and recovery-oriented practice in acute inpatient psychiatric units : A non-participant observation study *International Journal of Mental Health Nursing*. *International Journal of Mental Health Nursing*, 33(1), 189–191. <https://doi.org/10.1111/inm.13224>
- Moreno-poyato, A. R., Delgado-hito, P., Suárez-pérez, R., Leyva-moral, J. M., Aceña-

- domínguez, R., Carreras-salvador, R., Roldán-merino, J. F., & Lluch-canut, T. (2017). Implementation of Evidence on The Nurse- Patient Relationship in Psychiatric Wards Through a Mixed Method Design: study protocol. *BMC Nursing*, 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12912-016-0197-8>
- Odeyemi, C., Morrissey, J., & Donohue, G. (2018). Factors affecting mental health nurses working with clients with first-episode psychosis: A qualitative study. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 25(7), 423–431. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jpm.12489>
- Santangelo, P., Procter, N., & Fassett, D. (2018). Mental health nursing: Daring to be different, special and leading recovery-focused care? *International Journal of Mental Health Nursing*, 27(1), 258–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/inm.12316>
- Sue, D. W., & Sue, D. (2016). *Counseling the Culturally Diverse*. NJ: Wiley.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2018). *Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-based* (9th ed.). F. A. Davis Company.
- WHO. (2022). *World mental health report Transforming mental health for all*. World Health Organization.
- WHO. (2025). *Mental Health*. Geneva. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>

BAB II

PENGKAJIAN STATUS MENTAL DAN RESIKO

A. Pendahuluan

Kesehatan mental merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan yang memengaruhi cara individu berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan kesehatan mental seperti depresi dan ansietas menjadi masalah global yang terus meningkat dan berdampak signifikan terhadap kualitas hidup, produktivitas, serta risiko morbiditas dan mortalitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam melakukan pengkajian untuk mendeteksi dini masalah kesehatan mental dan potensi risiko yang menyertainya.

Pengkajian status mental merupakan langkah awal yang krusial dalam proses asuhan keperawatan jiwa. Pemeriksaan status mental dilakukan untuk mengevaluasi fungsi psikologis individu secara menyeluruh, meliputi aspek penampilan umum, perilaku, proses pikir, isi pikir, suasana perasaan, persepsi, kognisi, serta wawasan dan penilaian. Hasil dari pemeriksaan ini memberikan gambaran objektif mengenai kondisi mental pasien saat itu, yang menjadi dasar dalam penegakan diagnosis dan perencanaan intervensi.

Selain pemeriksaan status mental, skrining terhadap depresi dan ansietas juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi gangguan emosional yang sering kali tidak terdeteksi secara klinis. Penggunaan instrumen skrining yang valid dan reliabel memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat waktu dan efektif.

Pengkajian risiko merupakan komponen penting lainnya dalam evaluasi kesehatan mental, khususnya dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan individu maupun orang lain. Risiko bunuh diri menjadi perhatian utama, mengingat tingginya angka kejadian serta dampaknya yang fatal. Selain itu, risiko perilaku kekerasan juga perlu diidentifikasi untuk mencegah terjadinya tindakan agresif yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Di sisi lain, pengkajian tidak hanya berfokus pada faktor risiko, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor protektif yang dimiliki individu. Faktor protektif seperti dukungan sosial, keyakinan spiritual, kemampuan koping yang adaptif, serta akses

terhadap layanan kesehatan dapat menjadi penyangga terhadap stresor dan menurunkan kemungkinan terjadinya gangguan mental maupun perilaku berisiko.

Dengan demikian, pengkajian status mental dan risiko yang komprehensif menjadi dasar penting dalam pemberian asuhan keperawatan yang holistik, aman, dan berpusat pada pasien. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada, tetapi juga dalam merancang intervensi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mental individu serta mencegah komplikasi yang lebih serius.

B. Konsep Dasar Pengkajian Status Mental dan Risiko

Kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan di mana individu mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi stres kehidupan, bekerja secara produktif, serta berkontribusi terhadap komunitasnya. World Health Organization mendefinisikan kesehatan mental sebagai bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan yang tidak terpisahkan dari kesehatan fisik (WHO, 2022). Gangguan kesehatan mental seperti depresi dan ansietas merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan karena berkontribusi terhadap beban penyakit global dan penurunan kualitas hidup (WHO, 2022).

Dalam konteks keperawatan, kesehatan mental dipandang sebagai hasil interaksi antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pendekatan pengkajian harus dilakukan secara holistik dan komprehensif.

Pengkajian status mental dan risiko merupakan bagian integral dalam asuhan keperawatan jiwa yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi psikologis individu serta potensi risiko yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pengkajian ini bersifat holistik karena tidak hanya menilai fungsi mental saat ini, tetapi juga mempertimbangkan faktor risiko dan faktor protektif yang memengaruhi kondisi pasien.

Pendekatan yang sistematis dan komprehensif sangat diperlukan agar tenaga kesehatan mampu melakukan deteksi dini terhadap gangguan mental, mencegah komplikasi, serta menentukan intervensi yang tepat dan aman.

Pengkajian status mental dan risiko merupakan komponen krusial dalam keperawatan jiwa yang mencakup pemeriksaan status mental, skrining depresi dan ansietas, serta identifikasi risiko bunuh diri dan kekerasan. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi dini, mencegah komplikasi, serta memberikan intervensi yang tepat. Selain itu, penguatan faktor protektif menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan mental individu secara berkelanjutan.

C. Pemeriksaan Status Mental (Mental Status Examination - MSE)

Pemeriksaan Status Mental (*Mental Status Examination/MSE*) merupakan metode sistematis yang digunakan untuk menilai fungsi mental individu pada saat pemeriksaan berlangsung (*current mental state*) melalui observasi dan wawancara (Varcarolis, 2021). MSE menjadi komponen penting dalam evaluasi psikiatri dan keperawatan jiwa karena memberikan gambaran objektif kondisi psikologis pasien. Menurut American Psychiatric Association (2022), komponen utama MSE meliputi:

1. Penampilan umum: kebersihan, kerapian, ekspresi wajah
2. Perilaku dan aktivitas psikomotor: agitasi, retardasi, respons terhadap lingkungan
3. Pembicaraan: kecepatan, volume, artikulasi
4. Mood dan afek: keadaan emosional subjektif dan ekspresi objektif
5. Proses pikir: alur berpikir logis atau tidak
6. Isi pikir: waham, obsesi, ide bunuh diri
7. Persepsi: halusinasi atau ilusi
8. Fungsi kognitif: orientasi, memori, perhatian
9. Insight dan judgment: kesadaran diri dan kemampuan mengambil keputusan

Adapun Tujuan Pemeriksaan Status Mental meliputi:

1. Mengidentifikasi adanya gangguan mental
2. Menilai tingkat keparahan kondisi psikologis
3. Menentukan kebutuhan intervensi segera
4. Membantu penegakan diagnosis
5. Mengevaluasi respons terhadap terapi

Pelaksanaan MSE harus memperhatikan beberapa prinsip:

1. Sistematis dan terstruktur: mengikuti urutan komponen pemeriksaan
2. Objektif dan akurat: berdasarkan observasi nyata, bukan asumsi
3. Komunikasi terapeutik: empati, tidak menghakimi
4. Sensitif budaya: mempertimbangkan nilai dan norma pasien
5. Kerahasiaan: menjaga privasi pasien

Komponen Pengkajian Status Mental

1. Penampilan Umum (General Appearance)

Kategori ini menggambarkan penampilan fisik pasien selama observasi, penampilan dapat ditentukan dalam beberapa detik pertama pengenalan dan dicatat selama wawancara. Detail yang perlu disertakan adalah apakah mereka tampak lebih tua atau lebih muda dari usia yang dinyatakan, pakaian mereka, perawatan dan kebersihan mereka dan keberadaan tato atau bekas luka. Jika pasien tampak lebih muda dari usia yang dinyatakan, hal itu mungkin disebabkan oleh keterlambatan perkembangan atau berpakaian yang tidak sesuai usia. Pasien yang lebih tua dari usia mungkin memiliki kondisi

medis yang mendasarinya. perawatan dan kebersihan memberikan wawasan tentang tingkat fungsional pasien tapi harus dilihat dalam konteks riwayat pasien. Tato dan bekas luka dapat memberikan wawasan tentang riwayat kepridaian dan perilaku pasien atau dapat menunjukkan selera gaya pribadi. Makna klinis yang dapat diperoleh adalah Penampilan tidak terawat dapat mengindikasikan depresi berat atau gangguan psikotik.

2. Perilaku dan Aktivitas Psikomotor

Deskripsi ini diperoleh dengan mengamati perilaku pasien selama wawancara. jika pasien merasa tertekan, ini mungkin disebabkan oleh masalah medis yang mendasarinya sehingga menyebabkan ketidaknyamanan atau tingkat keparahan tanda dan gejala akut.

Observasi dilakukan terhadap Tingkat aktivitas (hipoaktif/hiperaktif), Gerakan abnormal (agitasi, tremor, katatonía), Sikap terhadap pemeriksa Makna klinis: Agitasi sering ditemukan pada ansietas atau mania, sedangkan retardasi psikomotor pada depresi

- ## 3. Pembicaraan (Speech) Meliputi Kecepatan (lambat/cepat), volume (pelan/keras) Koherensi. Laju bicara yang cepat dapat mengindikasikan intoksikasi zat akut atau pasien dengan mengalami episode maniak. Waktu respon bicara yang tertunda juga dapat mengindikasikan gangguan neurokognitif atau pasien mengalami gangguan proses berpikir yang diamati pada kasus psikosis. Irama bicara dapat memberikan beberapa petunjuk misalnya bicara cadel dapat mengindikasikan intoksikasi, Disartria dapat mengindikasikan kemungkinan disfungsi motorik saat berbicara, volume suara lebih rendah jika pasien depresi atau menarik diri atau keras jika gelisah. Beberapa pasien memiliki gangguan neurokognitif atau kesulitan pendengaran yang mungkin membuat mereka tidak dapat mengontrol volume suara mereka. terakhir nada suara mengindikasikan suasana hati pasien.

Makna klinis: Bicara cepat mania dan Bicara lambat depresi

4. Mood dan Afek

Mood atau suasana hati adalah deskripsi subjektif pasien tentang perasaan mereka dengan kata kata mereka sendiri. Suasana hati ditentukan dengan memintapatient secara langsung untuk menggambarkan perasaan mereka dengan kata kata mereka sendiri. Sedangkan afek digambarkan sebagai interpretasi klinis terhadap ekspresi pasien yang diamati melalui bahasa nonverbal mereka. istilah yang sering digunakan adalah euthymik, bahagia, sedih, jengkel, marah, gelisah, terbatas, tumpul, datar, luas, aneh, penuh, labil, cerah, gembira dan euforia. Observasi dilakukan dengan memperhatikan Mood: perasaan subjektif pasien dan Afek: ekspresi emosional yang tampak. Aspek yang

dinilai: Kesesuaian ,Rentang (luas, terbatas, datar) ,Stabilitas Makna klinis: Afek datar sering ditemukan pada gangguan skizofrenia.

5. Proses Pikir (Thought Process) dengan Menilai alur berpikir berupa Logis atau tidak ,Koheren atau inkoheren ,Adanya gangguan seperti: *Flight of ideas* ,*Tangentiality* ,*Thought blocking* **Makna klinis:** Flight of ideas mania Blocking gangguan psikotik
6. Isi Pikir (Thought Content)

Kategori ini pada dasarnya adalah pokok bahasan dari pikiran Mengidentifikasi: Waham (delusi) ,Obsesi , Ide bunuh diri atau membahayakan orang lain Makna klinis: Ide bunuh diri merupakan kondisi darurat yang membutuhkan intervensi segera.
7. Persepsi (Perception) Menilai adanya gangguan persepsi: Halusinasi (auditorik, visual, dll.) dan Ilusi Makna klinis: Halusinasi auditorik sering ditemukan pada gangguan psikotik.
8. Fungsi Kognitif Meliputi: Orientasi (waktu, tempat, orang) ,Memori (jangka pendek & panjang) ,Perhatian dan konsentrasi ,Kemampuan berhitung sederhana Makna klinis: Gangguan kognitif dapat mengarah pada delirium atau demensia.
9. Insight (Wawasan) berupa Kemampuan pasien memahami kondisi dirinya ,Insight baik: menyadari sakit ,Insight buruk: menyangkal kondisi
10. Judgment (Penilaian) Kemampuan membuat keputusan yang tepat: Dinilai melalui respons terhadap situasi hipotetik .Makna klinis: Judgment buruk meningkatkan risiko perilaku berbahaya.

Teknik Pengumpulan Data dalam MSE berupa Observasi langsung: penampilan, perilaku Wawancara: eksplorasi mood, isi pikir , Pemeriksaan kognitif sederhana: orientasi, memori Kombinasi ketiga teknik ini meningkatkan validitas hasil pengkajian.

Dalam praktik keperawatan jiwa, MSE berfungsi sebagai Dasar penentuan diagnosis keperawatan (SDKI), Acuan perencanaan intervensi (SIKI) ,Evaluasi luaran (SLKI) dan Deteksi dini kondisi kegawatdaruratan psikiatri .MSE memiliki implikasi penting dalam praktik klinis, antara lain: Membantu deteksi dini gangguan mental .Mengidentifikasi risiko (bunuh diri/kekerasan) ,Menentukan prioritas tindakan keperawatan ,Meningkatkan keselamatan pasien

Pengkajian Status Mental (Mental Status Examination/MSE) merupakan komponen esensial dalam keperawatan jiwa yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi psikologis individu. Dengan pendekatan yang sistematis, objektif, dan berbasis komunikasi terapeutik, MSE membantu tenaga

kesehatan dalam menegakkan diagnosis, menentukan intervensi, serta mencegah risiko yang dapat membahayakan pasien maupun lingkungan.

D. Skrining Depresi dan Ansietas

Depresi merupakan salah satu gangguan suasana perasaan (*mood disorder*) yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan, serta penurunan energi yang berdampak pada fungsi sehari-hari. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR), depresi mayor didiagnosis apabila individu mengalami sedikitnya lima gejala selama dua minggu, termasuk suasana hati depresif atau kehilangan minat (American Psychiatric Association, 2022). Menurut World Health Organization (2022), depresi merupakan salah satu penyebab utama disabilitas di dunia dan berkontribusi besar terhadap beban penyakit global. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi aspek emosional, tetapi juga kognitif, fisik, dan sosial individu.

Sedangkan Ansietas adalah respons emosional terhadap ancaman yang ditandai dengan perasaan khawatir, tegang, dan gejala fisiologis seperti peningkatan denyut jantung dan pernapasan. Ansietas dapat bersifat adaptif dalam kondisi tertentu, tetapi menjadi patologis apabila berlebihan dan mengganggu fungsi individu (Stuart, 2020).

Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR) (APA, 2022), gangguan ansietas mencakup berbagai kondisi seperti *generalized anxiety disorder*, panic disorder, dan phobia, yang ditandai dengan kecemasan persisten dan tidak proporsional terhadap situasi.

Skrining merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi gangguan emosional yang sering tidak terdeteksi secara klinis. Depresi dan ansietas adalah dua kondisi yang paling sering ditemukan di masyarakat dan memiliki dampak signifikan terhadap fungsi individu.

Instrumen yang umum digunakan antara lain :

1. PHQ-9 (*Patient Health Questionnaire*): Digunakan untuk screening depresi yang terdiri dari 9 pertanyaan yang sesuai DSM dengan menilai frekwensi gejala dalam 2 minggu terakhir dengan skor yang menunjukkan tingkat keparahan dari ringan sampai berat
2. GAD-7 (*Generalized Anxiety Disorder Scale*) digunakan untuk screening ansietas terdiri dari 7 item pertanyaan dengan mengukur tingkat kecemasan dalam 2 minggu terakhir.
3. HADS (*Hospital Anxiety and Depression Scale*) digunakan untuk mengukur depresi dan ansietas sekaligus, alat ini sering digunakan di fasilitas kesehatan.

Instrumen-instrumen ini telah banyak digunakan secara global dan memiliki validitas serta reliabilitas yang baik dalam berbagai populasi.

Adapun tujuan pelaksanaan skrining adalah Deteksi dini gangguan mental, Menentukan tingkat keparahan, Menjadi dasar intervensi awal. Pelaksanaan skrining harus dilakukan secara sistematis dan etis dengan memperhatikan beberapa hal berupa Lingkungan yang nyaman dan privat, Komunikasi terapeutik (empati dan non-judgmental), Persetujuan pasien (*informed consent*), Kerahasiaan data.

Hasil skrining digunakan sebagai dasar untuk evaluasi lebih lanjut, bukan sebagai diagnosis definitif (Varcarolis, 2021). Hasil skrining harus diikuti dengan tindakan yang sesuai, antara lain: Edukasi kesehatan mental, Intervensi keperawatan (manajemen stres, relaksasi), Konseling atau psikoterapi, Rujukan ke tenaga profesional (psikolog/psikiater). Jika ditemukan skor tinggi atau adanya ide bunuh diri, diperlukan penanganan segera dan intensif.

Dalam praktik keperawatan jiwa, skrining memiliki peran penting sebagai Bagian dari pengkajian awal, Dasar penentuan diagnosis keperawatan, Panduan dalam penyusunan intervensi dan Alat evaluasi perkembangan pasien. Skrining juga mendukung upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan mental.

Beberapa hambatan dalam implementasi skrining meliputi Stigma terhadap gangguan mental, Keterbatasan waktu di layanan primer, Kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, Ketidakjujuran pasien dalam menjawab. Upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan edukasi masyarakat diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Screening depresi dan ansietas memiliki implikasi penting dalam deteksi dini antara lain meningkatkan deteksi dini gangguan mental, mengurangi beban mental di masyarakat, mencegah komplikasi seperti bunuh diri dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

E. Resiko bunuh diri

Bunuh diri merupakan tindakan mengakhiri hidup secara sengaja yang terjadi melalui suatu proses bertahap, mulai dari munculnya ide bunuh diri (*suicidal ideation*), perencanaan (*suicidal plan*), percobaan (*suicide attempt*), hingga bunuh diri yang selesai (*completed suicide*). Menurut World Health Organization, bunuh diri merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dengan lebih dari 700.000 kematian setiap tahun (WHO, 2023). Bunuh diri tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif sangat diperlukan dalam upaya pencegahan. Faktor risiko bunuh diri adalah kondisi yang meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan bunuh diri. Menurut

Centers for Disease Control and Prevention (2022), faktor risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Faktor Individu berupa Riwayat gangguan mental (terutama depresi, skizofrenia), Riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya, Penyalahgunaan alkohol atau zat, Penyakit kronis atau nyeri berkepanjangan.
2. Faktor Psikologis berupa Perasaan putus asa (*hopelessness*), Harga diri rendah, Kesulitan koping terhadap stres
3. Faktor Sosial berupa Isolasi sosial, Konflik keluarga, Kehilangan orang terdekat, Masalah ekonomi

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2022), riwayat percobaan bunuh diri merupakan prediktor terkuat terhadap kejadian bunuh diri berikutnya. Individu dengan risiko bunuh diri dapat menunjukkan tanda-tanda berikut:

1. Tanda Verbal berupa mengungkapkan keinginan untuk mati dan pernyataan putus asa (“hidup tidak ada artinya”)
2. Tanda Perilaku berupa Menarik diri dari lingkungan, Memberikan barang berharga, Mencari cara untuk bunuh diri
3. Tanda Emosional berupa Depresi berat, Ansietas tinggi, Perubahan mood ekstrem.

Pengkajian risiko bunuh diri merupakan bagian penting dalam keperawatan jiwa dan harus dilakukan secara langsung, terbuka, serta empatik. Adapun Aspek yang dikaji adalah:

1. Ide bunuh diri: apakah pasien memiliki keinginan untuk mati
2. Rencana: apakah pasien memiliki metode atau cara
3. Akses: ketersediaan alat untuk bunuh diri
4. Niat (intent): seberapa kuat keinginan tersebut
5. Riwayat sebelumnya: percobaan bunuh diri

Pendekatan ini membantu mengklasifikasikan tingkat risiko Risiko rendah: ide tanpa rencana, Risiko sedang: ide dengan rencana, Risiko tinggi: rencana jelas dan akses tersedia.

Faktor Faktor yang dapat menurunkan risiko bunuh diri, antara lain Dukungan keluarga dan sosial, Keyakinan agama/spiritual, Keterampilan koping adaptif, Akses layanan kesehatan, Tanggung jawab terhadap keluarga. Intervensi Keperawatan pada Risiko Bunuh Diri berupa:

1. Intervensi Keamanan berupa Pengawasan ketat (observasi kontinu), Menghilangkan benda berbahaya, Lingkungan yang aman
2. Intervensi Psikologis berupa Komunikasi terapeutik, Validasi perasaan pasien, Meningkatkan harapan (instilling hope)

3. Intervensi Kolaboratif berupa Rujukan ke psikiater/psikolog, Terapi farmakologis jika diperlukan, Terapi psikososial
4. Edukasi berupa Edukasi pasien dan keluarga, Pengenalan tanda bahaya, Strategi koping

Perawat mempunyai peranan penting dalam pencegahan bunuh diri melalui deteksi dini melalui pengkajian, memberikan dukungan emosional, menjaga keselamatan pasien, koordinasi dengan tim kesehatan dan edukasi keluarga. Pendekatan yang empatik dan non-judgmental sangat penting dalam membangun hubungan terapeutik dengan pasien. Risiko bunuh diri merupakan kondisi serius yang memerlukan pengkajian komprehensif dan intervensi segera. Dengan memahami faktor risiko, tanda peringatan, serta faktor protektif, tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi dini dan pencegahan secara efektif. Peran perawat sangat penting dalam memberikan asuhan yang aman, empatik, dan berpusat pada pasien.

F. Risiko Kekerasan

Risiko kekerasan adalah potensi individu untuk melakukan perilaku agresif yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Perilaku kekerasan dapat berupa tindakan verbal (ancaman, kata-kata kasar) maupun fisik (memukul, merusak, menyerang). Menurut American Psychiatric Association, perilaku kekerasan sering dikaitkan dengan gangguan mental tertentu seperti skizofrenia, gangguan bipolar (fase mania), gangguan penggunaan zat, serta gangguan kepribadian (APA, 2022). Namun demikian, tidak semua individu dengan gangguan mental bersifat agresif; faktor lingkungan dan situasional juga berperan besar. Risiko kekerasan bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial.

1. Faktor Individu: Riwayat perilaku agresif sebelumnya, Gangguan mental (psikotik, mania), Penyalahgunaan alkohol dan zat, Impulsivitas tinggi
2. Faktor Psikologis: Frustrasi dan kemarahan yang tidak terkontrol, Mekanisme koping maladaptif, Harga diri rendah
3. Faktor Sosial dan Lingkungan: Konflik keluarga, Lingkungan yang penuh kekerasan, Stres sosial ekonomi, Kurangnya dukungan sosial

Faktor-faktor ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku agresif, terutama jika tidak ditangani secara tepat. Identifikasi dini sangat penting untuk mencegah eskalasi perilaku kekerasan. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai meliputi:

1. Tanda Verbal berupa Berbicara dengan nada tinggi, Mengancam atau menggunakan kata-kata kasar,
2. Tanda Perilaku berupa Gelisah, mondar-mandir, Mengepalkan tangan, Postur tubuh tegang, Perilaku destruktif

3. Tanda Emosional berupa Marah berlebihan, Mudah tersinggung, Kehilangan kontrol emosi.

Perubahan perilaku yang tiba-tiba juga perlu menjadi perhatian sebagai indikator peningkatan risiko. Pengkajian dilakukan secara sistematis untuk menilai tingkat risiko dan menentukan intervensi yang tepat. Aspek yang dikaji meliputi

1. Riwayat kekerasan: kejadian sebelumnya
2. Status mental: adanya halusinasi, waham, atau gangguan kontrol impuls
3. Kondisi emosional: kemarahan, frustrasi
4. Penggunaan zat
5. Faktor pencetus (trigger)

Berdasarkan hasil pengkajian, risiko kekerasan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Risiko rendah jika tidak ada riwayat atau tanda agresi
2. Risiko sedang jika ada riwayat atau tanda awal
3. Risiko tinggi jika ancaman nyata atau perilaku agresif aktif

Intervensi keperawatan yang dilakukan adalah:

1. Intervensi Preventif berupa Identifikasi dini tanda agresi, Membangun hubungan terapeutik, Edukasi manajemen emosi
2. Teknik De-eskalasi berupa Berbicara dengan tenang dan jelas, Menjaga jarak aman, Menghindari konfrontasi, Memberikan pilihan kepada pasien
3. Intervensi Keamanan berupa Mengamankan lingkungan, Menghindari benda berbahaya, Pengawasan ketat
4. Intervensi Kolaboratif berupa Rujukan ke psikiater, Terapi farmakologis (misalnya sedatif jika diperlukan), Terapi perilaku.

Perawat memiliki peranan penting dalam penanganan resiko kekerasan dengan melakukan pengkajian secara komprehensif, mengidentifikasi tanda dini agresi, menerapkan teknik komunikasi terapeutik, menjaga keselamatan pasien dan lingkungan dan berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Pendekatan empatik dan profesional sangat penting untuk mengurangi resiko konflik.

Pengkajian dan penanganan resiko kekerasan memiliki implikasi penting dalam mencegah cedera dan insiden kekerasan, meningkatkan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan mendukung pemulihan pasien. Pengkajian risiko kekerasan dapat dijelaskan melalui pendekatan biopsikososial yang menekankan bahwa perilaku agresif merupakan hasil interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Model ini mendukung pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan jiwa.

Beberapa kendala yang sering dihadapi adalah Kurangnya pelatihan de-eskalasi, Stigma terhadap pasien gangguan mental, Keterbatasan fasilitas keamanan, Beban kerja tenaga kesehatan yang cukup tinggi.

Risiko kekerasan merupakan kondisi yang memerlukan perhatian serius dalam keperawatan jiwa. Dengan pengkajian yang tepat, identifikasi dini tanda-tanda agresi, serta intervensi yang komprehensif, perilaku kekerasan dapat dicegah dan dikendalikan. Perawat memiliki peran kunci dalam menjaga keselamatan serta memberikan asuhan yang empatik dan profesional.

G. Faktor Protektif

Faktor protektif adalah kondisi atau karakteristik individu, keluarga, maupun lingkungan yang dapat mengurangi risiko terjadinya gangguan mental atau perilaku berbahaya, serta meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap stres. Menurut World Health Organization, faktor protektif berperan penting dalam meningkatkan ketahanan (*resilience*) individu terhadap tekanan psikososial dan mencegah terjadinya masalah kesehatan mental (WHO, 2022). Faktor protektif memiliki beberapa fungsi utama yaitu Menurunkan risiko depresi dan ansietas, Mencegah perilaku bunuh diri dan kekerasan, Meningkatkan kemampuan coping, Mempercepat pemulihan dari gangguan mental dan Meningkatkan kualitas hidup individu.

Dalam pendekatan keperawatan jiwa modern, faktor protektif menjadi dasar dalam pendekatan **strength-based** (berbasis kekuatan). Faktor protektif terdiri dari:

1. Faktor Individu yaitu Faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri berupa Harga diri yang baik, Kepercayaan diri, Kemampuan problem solving, Regulasi emosi yang baik, Keterampilan coping adaptif dan Optimisme dan harapan. Individu dengan kemampuan coping yang baik cenderung lebih mampu menghadapi stres tanpa mengalami gangguan mental.
2. Faktor Keluarga. Keluarga merupakan sistem pendukung utama berupa Dukungan emosional keluarga, Hubungan yang harmonis, Pola asuh yang positif dan komunikasi yang terbuka. Keluarga yang suportif dapat menjadi pelindung kuat terhadap risiko bunuh diri dan perilaku kekerasan.
3. Faktor Sosial. Lingkungan sosial juga berperan penting berupa Dukungan teman sebaya, Keterlibatan dalam komunitas, Hubungan interpersonal yang sehat, Lingkungan yang aman. Dukungan sosial terbukti dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.
4. Faktor Spiritual berupa Keyakinan agama, Praktik ibadah dan Makna hidup (*meaning of life*). Spiritualitas sering menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi krisis dan mengurangi keinginan bunuh diri.

5. Faktor Akses Layanan kesehatan berupa Ketersediaan layanan kesehatan mental, Akses terhadap tenaga profesional dan Edukasi kesehatan mental. Akses layanan yang baik memungkinkan deteksi dini dan penanganan yang tepat.

Individu dengan faktor protektif kuat cenderung memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap stres berat.

Faktor protektif pada depresi dan ansietas berperan dalam menurunkan risiko terjadinya depresi dan ansietas. Individu dengan dukungan sosial yang kuat dan kemampuan koping yang baik cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah serta mampu beradaptasi dengan perubahan (Stuart, 2020). Selain itu, keterlibatan dalam aktivitas sosial dan spiritual juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan psikologis.

Adapun Faktor protektif pada Risiko Bunuh Diri adalah Dukungan sosial yang kuat, Tanggung jawab terhadap keluarga, Keyakinan moral atau agama, Hubungan interpersonal yang bermakna dan Akses terhadap bantuan profesional. Individu dengan faktor protektif kuat cenderung memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap stres berat.

Sedangkan faktor protektif pada resiko kekerasan adalah Kemampuan mengelola emosi, Kontrol impuls yang baik, Lingkungan yang kondusif, Pendidikan dan keterampilan sosial, Dukungan keluarga.

Pengkajian faktor protektif dilakukan bersamaan dengan pengkajian risiko untuk mendapatkan gambaran yang seimbang. **Aspek yang dikaji berupa** Dukungan sosial yang dimiliki, Keyakinan spiritual, Kemampuan koping, Hubungan keluarga, Akses layanan kesehatan. Pendekatan ini membantu perawat dalam merancang intervensi yang lebih efektif.

Perawat dapat meningkatkan faktor protektif melalui edukasi kesehatan mental, pelatihan koping dan manajemen stress, penguatan dukungan keluarga, fasilitas dukungan sosial dan pendekatan spiritual care. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

Faktor protektif dapat dijelaskan melalui pendekatan **biopsikososial**, yang menyatakan bahwa kesehatan mental dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Model ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengkajian dan intervensi keperawatan.

Faktor Protektif memiliki implikasi penting untuk menjadi dasar dalam perencanaan intervensi, meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi kekambuhan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Faktor protektif merupakan elemen penting dalam pengkajian kesehatan mental yang berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan mental dan perilaku berisiko. Dengan mengidentifikasi dan

memperkuat faktor protektif, tenaga kesehatan dapat meningkatkan ketahanan individu, mencegah komplikasi, serta mendukung proses pemulihan secara optimal.

H. Penutup

Pengkajian status mental dan risiko merupakan komponen fundamental dalam keperawatan jiwa yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi psikologis individu serta potensi bahaya yang mungkin terjadi. Pemeriksaan status mental (*Mental Status Examination/MSE*) memberikan informasi objektif mengenai fungsi mental pasien, sedangkan skrining depresi dan ansietas memungkinkan deteksi dini gangguan emosional yang sering tidak teridentifikasi.

Selain itu, pengkajian risiko bunuh diri dan kekerasan menjadi aspek krusial dalam menjamin keselamatan pasien dan lingkungan. Risiko tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan sistematis sangat diperlukan dalam proses pengkajian.

Di sisi lain, faktor protektif memiliki peran penting sebagai penyangga terhadap stres dan risiko gangguan mental. Dukungan sosial, kemampuan coping adaptif, serta nilai spiritual merupakan komponen utama yang dapat meningkatkan ketahanan individu (*resilience*) dan mempercepat proses pemulihan.

Secara keseluruhan, integrasi antara pengkajian status mental, skrining gangguan emosional, identifikasi risiko, dan penguatan faktor protektif menjadi landasan utama dalam pemberian asuhan keperawatan jiwa yang holistik, aman, dan berpusat pada pasien.

Referensi

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR)*. American Psychiatric Publishing.
- Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. *Annual Review of Psychology*, 53, 27–51.
- Carpenito, L. J. (2017). *Nursing diagnosis: Application to clinical practice* (15th ed.). Wolters Kluwer.
- Hawton, K., & Williams, K. (2001). *The effectiveness of interventions for deliberate self-harm*. Oxford University Press.
- Joiner, T. (2005). *Why people die by suicide*. Harvard University Press.
- Kaplan, H. I., Sadock, B. J., & Ruiz, P. (2015). *Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9), 606–613.
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097.
- Stuart, G. W. (2020). *Principles and practice of psychiatric nursing* (11th ed.). Elsevier.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2021). *Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice* (10th ed.). F.A. Davis Company.
- Varcarolis, E. M. (2021). *Foundations of psychiatric-mental health nursing: A clinical approach* (9th ed.). Elsevier.
- World Health Organization. (2022). *Mental health and substance use*. <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2023). *Suicide worldwide in the 21st century*. WHO Press.
- Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983). The hospital anxiety and depression scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 67(6), 361–370.

BAB III

KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN HUBUNGAN PERAWAT–KLIEN PADA PASIEN DENGAN MASALAH PSIKOSOSIAL DAN GANGGUAN JIWA

E. Pendahuluan

Komunikasi terapeutik merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan jiwa karena berfungsi sebagai cara intervensi yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga membangun kepercayaan antara perawat dan pasien. Dalam kasus pasien yang menghadapi masalah psikososial dan gangguan mental, komunikasi berperan sebagai alat untuk membantu mereka mengekspresikan emosi, memahami pemikiran, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi stress (Almadina Rakhmaniar, 2023)

Metode komunikasi yang tepat memungkinkan perawat lebih memahami kebutuhan emosional dan psikologis pasien, sehingga langkah intervensi yang diberikan menjadi lebih efektif dan berfokus pada pasien, sebaliknya komunikasi yang kurang baik dapat menyebabkan berbagai efek negatif, baik untuk pasien maupun proses perawatan (Ulfah *et al.*, 2022). Pasien dengan gangguan mental sering kali mengalami distorsi dalam persepsi, kesulitan berpikir, dan perubahan emosi, sehingga kesalahan dalam berkomunikasi dapat memperburuk keadaan seperti kecemasan, perilaku agresif, atau isolasi. Selain itu, kegagalan dalam menciptakan hubungan terapeutik dapat berujung pada turunnya kepercayaan pasien terhadap tenaga medis, penolakan untuk menjalani terapi, hingga meningkatnya risiko kekambuhan. Oleh sebab itu, kemampuan komunikasi dalam terapi menjadi keterampilan penting yang harus dikuasai perawat untuk menyediakan perawatan jiwa yang aman dan efektif (Vethabothagam, Article and Nadu, 2024).

F. Dasar Konsep Komunikasi Terapeutik Dalam Keperawatan Jiwa

1. Pengertian

Komunikasi terapeutik adalah sebuah proses interaksi antar pribadi yang dirancang secara sistematis, bertujuan, dan terfokus pada kebutuhan klien demi meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan social (Awaliyah M.Suwetty,

2024) Dalam konteks keperawatan jiwa, komunikasi tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menyampaikan informasi, melainkan sebagai intervensi utama yang memiliki dampak langsung pada kondisi psikologis pasien. Ini berbeda dari praktik keperawatan umum, di mana komunikasi sering kali dianggap sebagai tambahan dari tindakan medis. Dalam keperawatan jiwa, komunikasi berfungsi sebagai alat terapi yang esensial dalam membangun hubungan, mengenali masalah, dan memfasilitasi perubahan dalam perilaku serta pemikiran klien (Melinda, annalia, Raziansyah, Lucia, Yohana, Widya, Ikhsan, 2022).

Konsep komunikasi terapeutik berlandaskan pada teori hubungan antarpribadi yang menyoroti pentingnya interaksi antara perawat dan klien sebagai sarana penyembuhan. Pendekatan ini menggabungkan aspek empati, penerimaan tanpa syarat, serta keterampilan mendengarkan secara aktif. Dalam pelaksanaannya, komunikasi terapeutik mencakup penggunaan teknik tertentu seperti refleksi, klarifikasi, eksplorasi, dan validasi untuk membantu klien mengenal dirinya dengan lebih baik (Niu *et al.*, 2025). Dengan cara ini, komunikasi terapeutik tidak hanya bersifat memberikan informasi, tetapi juga memiliki sifat transformatif karena mampu mengubah pola pikir dan reaksi emosional klien terhadap permasalahan yang dihadapi (Ulfah *et al.*, 2022). Penelitian oleh (Wantong Xue, 2021) menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik merupakan komponen penting dalam hubungan perawat – pasien karena membantu membangun kepercayaan, meningkatkan keterlibatan dalam perawatan dan mendukung proses pemulihan pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Hal ini memperkuat bahwa komunikasi terapeutik bukan sekadar keterampilan tambahan, melainkan kompetensi penting yang menentukan keberhasilan dalam asuhan keperawatan jiwa.

2. Tujuan Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan Jiwa

Komunikasi terapeutik dalam penanganan masalah kejiwaan tidak lebih dari sekedar transfer informasi namun juga menyentuh dimensi psikologis dan sosial demi memulihkan kondisi pasien. Esensi utamanya adalah mendorong pasien agar berani mengungkapkan isi hati dan pemikiran yang mungkin selama ini terpendam (Almadina Rakhmaniar, 2023). Tak sedikit orang yang bergulat dengan masalah mental, merasa sulit mengenali dan menyuarakan emosinya, sehingga komunikasi terapeutik hadir sebagai wadah aman untuk mengekspresikan diri. Selain itu, komunikasi terapeutik dirancang untuk mempertajam pemahaman pasien terhadap realitas yang mereka jalani, Dibimbing oleh perawat, pasien bisa mulai menyadari pola pikir yang keliru, memahami akar penyebab stres, serta menemukan jurus - jurus baru untuk mengatasi masalah (Naveen P. Sharma; Vikas Gupta., 2023) Di sini, perawat

bertindak sebagai mitra pendukung yang memfasilitasi pencarian solusi, bukan sebagai figur otoriter yang mendikte atau memutuskan bagi pasien (Sitorus, 2024)

Aspek krusial lainnya adalah memupuk jalinan kepercayaan antara perawat dan pasien, fondasi mutlak setiap upaya pemulihan kejiwaan. Tanpa rasa percaya, pasien sering menarik diri, enggan menjalani pengobatan, bahkan bisa jadi dilindungi.

Laporan terkini dari National Institute of Mental Health mengindikasikan bahwa hubungan terapeutik yang kokoh mampu menurunkan tingkat kecemasan hingga 35% dan mendorong keteraturan pasien dalam menjalani terapi bagi mereka yang memiliki tantangan kesehatan mental jangka Panjang (Apriliyanti, Sptyasari and Puspa, 2021). Di samping itu, komunikasi terapeutik juga berupaya mewujudkan kemandirian pasien dalam mengelola kehidupan hidupnya (Resman Humolungo, 2023) Keberhasilan jangka panjang komunikasi diukur dari kapasitas pasien untuk mengambil keputusan secara mandiri, mengendalikan gejala emosi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik memegang peranan esensial dalam upaya pemulihan psikososial (Nur Hidaayah *et al.*, 2024)

3. Prinsip Komunikasi Terapeutik dalam keperawatan Jiwa

Komunikasi terapeutik berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami dan diterapkan oleh perawat dengan konsisten (Widiyanto and Umar, 2024)

- a. Prinsip pertama adalah empati, yang merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dialami klien dari perspektif mereka tanpa kehilangan sikap profesional. Dengan empati, perawat dapat menciptakan hubungan emosional yang baik tanpa terlibat secara berlebihan.
- b. Prinsip kedua adalah keaslian, yang berarti bersikap jujur, terbuka, dan tulus saat berinteraksi dengan klien. Klien dengan masalah kesehatan mental sering kali sangat peka terhadap ketidakkonsistenan, sehingga keaslian menjadi kunci dalam menciptakan kepercayaan.
- c. Prinsip ketiga adalah menghargai klien sebagai individu yang memiliki nilai dan martabat. Ini mencakup penerimaan terhadap klien tanpa menghakimi, walaupun perilaku mereka mungkin tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan humanistik dalam perawatan kesehatan jiwa yang menempatkan klien di pusat layanan.
- d. Prinsip keempat adalah prinsip kerahasiaan yang merupakan hal penting dalam komunikasi terapeutik. Informasi yang diperoleh dari klien harus dilindungi dengan baik untuk menjaga privasi dan hak-hak mereka.

Pelanggaran atas prinsip ini dapat merusak hubungan terapeutik dan mengurangi kepercayaan klien.

Royal College of Nursing menjelaskan penerapan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik secara konsisten terbukti meningkatkan kualitas hubungan antara perawat dan klien serta efektivitas intervensi dalam keperawatan jiwa (Ernstmeyer K, 2025).

4. Karakteristik Komunikasi Terapeutik Yang Efektif

Karakteristik komunikasi yang dijalankan dalam aspek terapi mempunyai karakteristik unik yang membedakannya dari percakapan biasa.

1. Alur komunikasinya dibuat secara terencana dan memiliki sasaran yang jelas, yaitu untuk membawa klien ke kondisi mental yang lebih positif.
2. Fokusnya adalah pada klien itu sendiri, yang berarti seluruh percakapan berpusat pada apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dipikirkan oleh klien
3. Penggunaan berbagai metode spesifik dalam komunikasi terapeutik, seperti mengulang kata, memperjelas, menggali lebih dalam, dan membenarkan perasaan. Dengan cara seperti ini, perawat dapat menggali informasi lebih mendalam dan membantu klien memahami diri mereka sendiri.
4. Keselarasan antara apa yang diucapkan dan bahasa tubuh sangatlah krusial. Gerak tubuh, raut muka, serta cara bicara harus selaras dengan pesan yang disampaikan agar klien tidak merasa bingung.

Sifat lainnya adalah adanya evaluasi terhadap tanggapan klien. Perawat perlu terus-menerus mengamati apakah cara berkomunikasi yang dipakai benar-benar membantu klien. Penilaian ini penting untuk menyesuaikan strategi komunikasi dengan kebutuhan klien yang bisa berubah-ubah (Carballedo-pulido, Farrés-tarafa and Roldán-merino, 2026)

Sebuah penelitian terkini yang dimuat di jurnal bereputasi (Scopus) mengungkapkan bahwa komunikasi terapeutik yang efektif berkontribusi pada peningkatan kepuasan pasien, penurunan tindakan agresif, serta peningkatannya hubungan antara terapis dan pasien (Carballedo-pulido, Farrés-tarafa and Roldán-merino, 2026). Hal ini menegaskan bahwa komunikasi bukan sekedar bertukar kata, melainkan juga cerminan dari mutu layanan yang diberikan.

B. Tahapan Hubungan Perawat - Klien dalam konteks keperawatan jiwa

Koneksi antara perawat dan orang yang dirawat memegang peranan krusial dalam penanganan kesehatan mental. Proses ini terbagi menjadi tahapan empat: pra-interaksi, orientasi, kerja, dan penutup. Setiap tahapan memiliki sasaran, alur, dan cara berkomunikasi khusus yang diperlukan demi tercapainya kesembuhan yang optimal (MA Syaripudin, 2023) Penguasaan terhadap tahapan ini sangat

penting bagi tenaga medis untuk membangun ikatan profesional, menjaga batasan yang sehat dan meningkatkan pelayanan bersama .

Tahap pra-interaksi, perawat mempersiapkan diri sebelum tatap muka dengan pasien. Walaupun kontak belum ada langsung, tahapan ini sangat mempengaruhi kesiapan perawat. Perawat perlu meningkatkan introspeksi diri, mengendalikan perasaan, serta menyadari keyakinan diri yang dapat berdampak pada hubungan dengan pasien. Data awal mengenai kondisi pasien juga dikumpulkan guna menunjang interaksi yang lebih focus

Tahap orientasi merupakan momen pertama kali perawat dan pasien bersua. Poin utamanya adalah menumbuhkan keyakinan serta menciptakan suasana yang nyaman. Pada saat ini, perawat memperkenalkan diri, memaparkan sekaligus menyusun kesepakatan terapi demi menciptakan struktur dan kejelasan. Pada fase ini, empati dari perawat sangatlah dibutuhkan.

Fase kerja, yang merupakan inti dari hubungan profesional, di mana perawat membantu pasien menggali perasaan dan pemikirannya seputar masalah yang dihadapi. Berbagai bentuk penanganan terapi diterapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien. Tahap ini menuntut perawat untuk lihai mengelola interaksi yang terjadi dengan sikap profesional.

Tahapan terakhir adalah penutup atau evaluasi, di mana hasil dari terapi dievaluasi. Tujuannya adalah membekali pasien agar mampu mandiri setelah menjalani perawatan. Memberikan masukan dan rencana langkah selanjutnya sangatlah penting pada fase ini, yang harus dijalankan secara profesional untuk mencegah timbulnya episode emosional.

Tabel 3.1 Perbandingan tiap fase dan indicator keberhasilan

Fase	Fokus Utama	Aktivitas Perawat	Respon Klien yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
Pra-interaksi	Persiapan sebelum bertemu klien	• Melakukan self-awareness • Mengidentifikasi perasaan/prasangka • Mengumpulkan data klien (rekam medis, laporan tim) • Menyiapkan rencana interaksi	Belum ada interaksi langsung	• Perawat siap secara emosional & kognitif • Tidak ada bias/prasangka yang mengganggu • Data awal klien lengkap & relevan

Fase	Fokus Utama	Aktivitas Perawat	Respon Klien yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
Orientasi	Membangun hubungan saling percaya (trust)	• Perkenalan diri & peran- • Menjelaskan tujuan interaksi • Membuat kontrak (waktu, tempat, durasi) • Menggali masalah awal klien	• Klien mulai terbuka • Klien merasa aman • Klien menunjukkan respon verbal/nonverbal positif	• Terbentuk rasa percaya • Klien bersedia berkomunikasi • Kontrak terapeutik disepakati
Kerja	Eksplorasi masalah & intervensi terapeutik	• Menggali perasaan, pikiran, perilaku • Menggunakan teknik komunikasi terapeutik (refleksi, klarifikasi, dll) • Memberikan intervensi (edukasi, coping, TAK) • Mengelola resistensi klien	• Klien mampu mengekspresikan masalah • Klien menunjukkan insight • Klien mulai berubah (sikap/perilaku)	• Masalah teridentifikasi dengan jelas • Klien menunjukkan peningkatan coping • Terjadi perubahan perilaku positif
Terminasi	Evaluasi & mengakhiri hubungan terapeutik	• Mengevaluasi pencapaian tujuan • Memberikan umpan balik- • Menyusun rencana tindak lanjut- • Melakukan perpisahan terapeutik	• Klien memahami perkembangan dirinya • Klien siap mandiri • Klien menerima akhir hubungan	• Tujuan tercapai sebagian/keseluruhannya • Klien mandiri dalam coping • Tidak ada ketergantungan emosional berlebihan

C. Teknik Wawancara dalam Keperawatan Jiwa

Wawancara terapeutik adalah komunikasi terencana antara perawat dan pasien untuk mengumpulkan informasi, memahami keadaan psikologis, dan membantu penyembuhan. Tujuannya termasuk mengumpulkan informasi tentang kondisi emosional, membantu pasien mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi masalah, dan membangun hubungan terapeutik. Penelitian menunjukkan teknik

wawancara yang tepat dapat memperbaiki hubungan dan mempercepat pemulihan pasien dengan gangguan jiwa (Carballedo-pulido, Farrés-tarafa and Roldán-merino, 2026)

Dalam wawancara terapeutik, terdapat dua jenis pertanyaan: pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka membantu pasien memberikan jawaban yang lebih mendalam misalnya perawat memulai dengan kata "bagaimana", "apa", atau "ceritakanlah" contoh "Ceritakanlah apa yang membuat Anda merasa cemas" sedangkan pertanyaan tertutup digunakan untuk memperoleh informasi singkat dan spesifik seperti ya dan tidak. Contoh penggunaan pertanyaan tertutup " Apakah Anda Sudah Makan".

Teknik komunikasi dalam wawancara terapeutik meliputi(Rahmawati and Sa'adah, 2022) :

1. Mendengarkan aktif

Mendengarkan aktif menunjukkan perhatian dan membuat pasien merasa dihargai.

2. Klarifikasi

Klarifikasi memastikan pemahaman informasi dari pasien. Contoh "Apa yang Anda maksud dengan merasa tidak nyaman? "

3. Refleksi

refleksi membantu pasien memahami emosinya. Contoh "Anda tampak sangat kecewa dengan situasi tersebut"

4. Parafrase

parafrase menunjukkan perhatian. Contoh "Jadi, Anda merasa kesepian setelah pindah ke tempat baru"

5. Diam terapeutik

Memberi ruang bagi pasien untuk berpikir. Sikap diam ini bukan berarti tidak aktif, tetapi merupakan bagian penting dari komunikasi yang memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan diam secara terapeutik dengan benar dapat memperdalam ekspresi emosi pada klien (Naveen P. Sharma; Vikas Gupta., 2023). Kesalahan umum dalam wawancara terapeutik oleh perawat meliputi penggunaan terlalu banyak pertanyaan tertutup, memberikan nasihat secara langsung, menghakimi, mengganggu pembicaraan, menggunakan istilah medis yang sulit, mengabaikan komunikasi nonverbal, dan menghindari topik sensitif. Kesalahan ini dapat menghalangi komunikasi terapeutik dan mengurangi efektivitas intervensi (Wantong Xue, 2021)

D. Empati Dalam Hubungan Terapeutik

Empati dalam hubungan terapeutik sangat penting untuk perawat dalam memahami dan merasakan perasaan serta pengalaman klien dari sudut pandang mereka, tanpa melanggar batas profesional. Empati berbeda dengan simpati; empati lebih berfokus pada pemahaman tanpa terjatuh dalam emosi klien. Simpati, meskipun positif, dapat mengganggu objektivitas perawat. Oleh karena itu, empati lebih diutamakan dalam keperawatan jiwa untuk membentuk hubungan yang profesional dan mendukung (Hojat *et al.*, 2023).

Empati terdiri dari tiga komponen utama: kognitif, afektif, dan perilaku. **Komponen kognitif** adalah kemampuan perawat untuk memahami pandangan klien secara intelektual. **Komponen afektif** adalah kemampuan perawat untuk merasakan emosi klien sambil tetap profesional. **Komponen perilaku** adalah tindakan nyata yang menunjukkan empati melalui komunikasi yang mendukung. Ketiga komponen ini berpengaruh besar terhadap kualitas hubungan terapeutik.

Strategi dalam meningkatkan empati pada perawat dapat ditingkatkan melalui berbagai cara antara lain 1) meningkatkan kesadaran diri 2) melakukan latihan mendengarkan aktif 3) refleksi pribadi 4) pelatihan komunikasi berbasis terapeutik, dan 5) pengalaman klinis yang berkelanjutan. Pelatihan empati dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan terapeutik dan mengurangi stres mental pada perawat. Penerapan empati termasuk memberikan respon yang memahami perasaan pasien tanpa menghakimi, seperti merespons pasien depresi atau pasien yang mengalami halusinasi. Respon empatik membantu pasien merasa dimengerti dan dapat meredakan ketegangan emosional (Nembhard *et al.*, 2023) Contoh Penerapan Empati dalam Kasus Gangguan Jiwa

Tabel 3.2 Contoh Respon empatik dan tidak empatik

Kasus	Respon Tidak Empatik	Respon Empatik
Pasien Depresi mengungkapkan, "Saya merasa hidup saya tidak berarti."	Jangan berpikir seperti itu, Anda harus lebih optimis. "	Anda merasakan hidup Anda tidak ada artinya, pasti ini sangat berat bagi Anda.",
Pasien Halusinasi Pasien mengungkapkan, "Saya mendengar suara yang memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu."	"Itu tidak ada, jangan percaya pada hal-hal seperti itu. "	"Suara itu terasa sangat nyata bagi Anda, dan mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman".

Pasien Agresif Pasien terlihat marah dan berteriak.	"Anda harus tenang sekarang! "	"Saya melihat Anda sangat marah, mungkin ada hal yang membuat Anda terganggu".
---	--------------------------------	--

E. Batas Profesional dalam Hubungan Terapeutik

1. Definisi Batas Profesional

Batas profesional adalah garis pemisah yang tegas antara hubungan terapeutik yang bersifat profesional dengan hubungan pribadi antara perawat dan pasien. Garis pemisah ini berfungsi untuk memastikan interaksi tetap berorientasi pada kebutuhan pasien, aman, etis, dan tidak menimbulkan eksploitasi atau ketergantungan yang tidak sehat. Dalam konteks perawatan jiwa, batas profesional sangat krusial karena hubungan terapeutik sering kali melibatkan keterbukaan emosional yang dalam, sehingga ada risiko keterlibatan berlebihan jika tidak dikelola dengan baik (Suryani *et al.*, 2023)

Batas profesional mencakup elemen emosional, sosial, fisik, dan bahkan digital, seperti komunikasi melalui media sosial. Perawat harus bisa menyeimbangkan antara rasa empati dan sikap objektif, serta memastikan semua tindakan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik pasien. Pelanggaran batas bisa merusak hubungan terapeutik, menurunkan kepercayaan, dan berdampak negatif terhadap proses penyembuhan.

2. Jenis Pelanggaran Batas Profesional

a. Pelanggaran Batas Ringan (*Boundary Crossing*)

Pelanggaran batas ringan adalah tindakan yang tidak terlalu serius, sementara, dan kadang-kadang bisa diterima jika bertujuan untuk kemanfaatan terapeutik pasien. Meski begitu, tindakan ini tetap memiliki risiko berkembang menjadi pelanggaran berat jika dibiarkan.

Contoh pelanggaran batas ringan 1) Memberikan perhatian lebih kepada pasien tertentu 2) Membagikan sedikit informasi pribadi 3) Menambah durasi interaksi di luar jadwal yang ditentukan

b. Pelanggaran Batas Berat (*Boundary Violation*)

Pelanggaran batas berat adalah tindakan yang serius dan tidak dapat dibenarkan menurut etika maupun hukum. Tindakan ini dapat merugikan pasien dan menyimpang dari tujuan terapeutik yang seharusnya. Contoh kasus yang termasuk dalam penyimpangan berat 1) Terlibat dalam hubungan romansa atau seksual dengan pasien 2) Eksploitasi secara finansial 3) Menggunakan pasien untuk kepentingan pribadi 4) Pelanggaran terhadap kerahasiaan pasien.

Pelanggaran batas berat bisa menyebabkan dampak psikologis negatif bagi pasien serta konsekuensi hukum dan profesional bagi perawat.

3. Strategi Menjaga Batas Profesional

Guna menghindari pelanggaran batas, perawat perlu melaksanakan beberapa strategi dalam melakukan pelayanan keperawatan khususnya pada aspek keperawatan jiwa. Strategi-strategi ini bertujuan untuk menjaga hubungan tetap bersifat terapeutik dan menghindari munculnya konflik kepentingan. Adapun strategi batas profesional perawat antara lain (Suryani *et al.*, 2023) :

Meningkatkan kesadaran diri b) Mengenali perasaan, kebutuhan, dan batasan pribadi c) Mematuhi kode etik profesi d) Mengacu pada standar praktik yang berlaku e) Mempertahankan komunikasi profesional f) Menghindari diskusi mengenai topik pribadi yang tidak relevan g) Membatasi interaksi di luar konteks klinik h) Termasuk dalam penggunaan media sosial i) Melakukan supervisi dan diskusi tim j) Membahas kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan dilema etis k) Dokumentasi yang baik l) Mencatat setiap interaksi penting dengan cara yang profesional

4. Dampak Pelanggaran terhadap Pasien dan Perawat

Pelanggaran batas profesi dalam hubungan komunikasi terapeutik, akan memberikan dampak baik kepada pasien maupun kepada perawat itu sendiri. Berbagai dampak yang diutarakan pada beberapa literatur dibagi menjadi 2 aspek yaitu dampak terhadap pasien dan dampak pada perawat (NSO, 2025)

a. Dampak terhadap Pasien

- 1) Kehilangan kepercayaan kepada tenaga kesehatan
- 2) Cedera psikologis
- 3) Ketergantungan emosional yang tidak sehat
- 4) Gangguan dalam proses penyembuhan

b. Pengaruh terhadap Perawat

- 1) Hukuman etika dan disiplin dalam profesi
- 2) Tuntutan hukum yang dapat muncul
- 3) Kehilangan izin praktik
- 4) Kerusakan reputasi dalam bidang profesional

Pelanggaran batasan profesional bisa memberikan dampak yang signifikan bagi lembaga kesehatan, termasuk berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemeliharaan batasan profesional adalah tanggung jawab yang sangat penting dalam praktik keperawatan jiwa (Jeanette Varpen Marit, 2025).

F. Manajemen Perilaku Pasien dalam Keperawatan Jiwa

1. Pengertian Manajemen Perilaku

Manajemen perilaku pasien adalah rangkaian tindakan yang diambil oleh perawat untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengubah perilaku klien agar lebih sesuai, aman, dan selaras dengan norma sosial. Dalam keperawatan jiwa, metode ini didasarkan pada prinsip terapi perilaku yang menyoroti bahwa perilaku dapat dipelajari, disesuaikan, dan diperkuat melalui interaksi dengan lingkungan (Daisiu and Kamaluddin, 2025)

Tujuan manajemen perilaku tidak hanya untuk mengurangi perilaku yang tidak tepat, seperti agresivitas atau penghindaran, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku positif seperti kemampuan mengatasi masalah, interaksi sosial, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Pendekatan ini harus dilakukan dengan cara yang terapeutik, konsisten, serta berfokus pada kebutuhan klien, sambil tetap menghormati martabat dan hak pasien

2. Teknik Manajemen Perilaku

a. Reinforcement (Penguatan)

Reinforcement adalah metode pemberian dorongan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku yang diinginkan. Tipe penguatan meliputi: Penguatan positif seperti memberikan penghargaan atau pujian "Bagus sekali Anda mau berbicara hari ini". Penguatan negatif dapat diberikan dengan menghilangkan rangsangan yang tidak menyenangkan setelah perilaku positif muncul seperti saat pasien mulai terlihat gelisah, perawat membimbing pasien ke ruang isolasi tenang/ruang terapi yang sepi dan tenang.

b. Limit Setting (Pembatasan Perilaku)

Limit setting adalah teknik yang menetapkan batasan jelas terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan membantu klien memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Prinsip yang harus dipegang perawat dalam pembatasan perilaku adalah 1) Disampaikan dengan jelas dan tegas 2) konsisten 3) Tanpa menghakimi 4) Fokus pada perilaku, bukan pada individu. Contoh: "Saya tidak akan membiarkan Anda berteriak. Jika Anda marah, mari kita bicarakan dengan cara yang tenang".

c. De-escalation Technique

De-escalation adalah metode untuk meredakan emosi atau perilaku agresif sebelum menjadi kekerasan. Teknik ini sangat penting dalam situasi krisis. Langkah-langkah penerapan Teknik De-Escalation: 1) Tetap tenang dan tidak bersikap konfrontatif 2) Gunakan nada suara yang lembut dan stabil 3) Berikan

ruang aman secara fisik 4) Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela
5) Hindari kontak fisik yang tidak diperlukan

Penelitian menunjukkan bahwa de-escalation berhasil mengurangi insiden kekerasan di ruang perawatan jiwa (Price *et al.*, 2024).

d. Distraksi

Distraksi adalah teknik yang digunakan untuk mengalihkan perhatian klien dari rangsangan yang membuat mereka berperilaku maladaptif ke aktivitas yang lebih positif. Teknik ini sering dilakukan oleh perawat. Beberapa tindakan yang dianggap efektif dilakukan antara lain 1) Mengajak klien melakukan kegiatan yang disukai 2) Mengubah topik pembicaraan 3) memberikan ruang diskusi yang menarik bersama pasien. Teknik ini sering dipakai pada pasien yang mengalami kecemasan, halusinasi, atau agitasi ringan

3. Penanganan Perilaku Khusus

Klien dengan gangguan jiwa perlu mendapatkan penanganan khusus dalam hal penanganan Perilaku. Tidak semua klien akan mendapatkan perilaku yang sama dalam penerapan terapi. Beberapa penelitian mengungkapkan penanganan perilaku khusus pada pasien gangguan jiwa harus didasarkan pada masalah yang dialami

a. Perilaku Agresif

Pasien yang menunjukkan perilaku agresif mungkin dapat memperlihatkan kemarahan baik secara verbal maupun fisik yang bisa membahayakan. Pendekatan terapeutik yang dapat diberikan 1) Terapkan de-escalation 2) Tetapkan batas perilaku (limit setting) 3) Jaga jarak yang aman 4) Libatkan tim jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kekerasan dan menjaga keamanan (Daisiu and Kamaluddin, 2025)

b. Halusinasi

Halusinasi adalah suatu persepsi yang muncul tanpa adanya rangsangan nyata, seperti mendengar suara. Pendekatan terapeutik yang dapat dilakukan 1) Validasi perasaan, bukan isi dari halusinasi 2) Alihkan perhatian (distraksi) 3) Ajarkan teknik kontrol (misalnya berbicara dengan orang lain) Contoh: "Saya tidak mendengar suara itu, tetapi saya mengerti jika itu mengganggu Anda"(Varcarolis, E. M., & Halter, 2022)

c. Menarik Diri (Isolasi Sosial)

Pasien sering kali cenderung menghindari interaksi sosial dan menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Pendekatan terapeutik yang dapat dilakukan. 1) Membangun hubungan secara bertahap 2) Menggunakan reinforcement untuk mendorong interaksi kecil 3) Memberikan aktivitas yang sederhana

Tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan sosial secara bertahap (Awaliyah M. Suwetty, 2021)

d. Perilaku Manipulatif

Pasien mungkin mencoba memanipulasi situasi untuk mencapai keuntungan tertentu. Pendekatan terapeutik yang dapat dilakukan 1) Konsisten dalam menerapkan aturan 2) Jauhi perundingan yang tidak mendukung kesehatan mental 3) Terapkan komunikasi yang tegas dan mudah dipahami

Contoh perilaku manipulative "Ketentuan ini berlaku untuk seluruh pasien, dan saya akan selalu mematuhi ketentuan ini" (Awaliyah M. Suwetty, 2024).

G. Aplikasi Komunikasi Terapeutik Pada Masalah Psikososial dan Gangguan Jiwa

1. Komunikasi Pada Pasien dengan berbagai kondisi

a. Pasien Depresi

Orang yang mengalami depresi sering menunjukkan tanda-tanda seperti perasaan sangat sedih, kehilangan minat pada aktivitas, merasa tidak berharga, dan cenderung menjauh dari interaksi sosial. Dalam berkomunikasi, perawat perlu menciptakan suasana yang aman dan mendukung, sehingga pasien dapat merasa dihargai (Syifa Fauziah, Rini Anjani, 2023).

Pendekatan komunikasi yang digunakan untuk pasien depresi 1) Ajukan pertanyaan terbuka 2) Luangkan waktu (jangan terburu-buru) 3) Tunjukkan rasa empati dan penerimaan tanpa menghakimi 4) Hindari memberikan nasihat langsung atau menyarankan untuk "berpikir positif". Contoh: "Mari Bercerita tentang kesulitan yang anda hadapi saat ini" (Cuma Çakmak, 2024)

Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa komunikasi dengan empati bisa menurunkan tingkat keparahan gejala depresi dan meningkatkan keterlibatan pasien dalam terapi (Annisa Salsabila Azis & Primatia Yogi Wulandari, 2025)

b. Pasien Skizofrenia

Orang dengan skizofrenia biasa mengalami gangguan dalam berpikir, mengalami halusinasi, dan memiliki pemikiran yang keliru, yang mempengaruhi cara mereka berkomunikasi (Nompo, 2023). Pendekatan komunikasi yang dapat diberikan 1) Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami 2) Tetap berfokus pada kenyataan tanpa berkonfrontasi secara langsung 3) Jangan memperkuat halusinasi atau delusi yang dialami 4) Terapkan teknik validasi perasaan Contoh "Saya mungkin tidak melihat atau merasakannya secara langsung, tapi saya mengerti hal ini terasa sangat nyata bagi anda" (Nur Hidaayah *et al.*, 2024) Pendekatan ini dapat membantu menjaga hubungan terapeutik tanpa mendukung ketidakbenaran tentang realitas

c. Pasien Gangguan Kecemasan

Pasien yang mengalami kecemasan biasanya merasakan ketegangan, rasa takut yang berlebihan, dan sulit untuk berkonsentrasi. Pendekatan komunikasi yang dapat diberikan : 1) Gunakan suara yang tenang dan menenangkan 2) Berikan informasi yang mudah dan jelas 3) Ajarkan teknik untuk relaksasi 4) Gunakan distraksi jika diperlukan. Contoh: duduk disamping pasien sambil sesekali mengelus Pundak pasien dan berkata "Tarik napas perlahan, saya akan menemani Anda disini". Komunikasi yang menenangkan telah terbukti efektif dalam mengurangi respons kecemasan yang mendalam (Akhmad, Bahfiarti and Fatimah, 2024)

d. Pasien Harga Diri Rendah

Pasien dengan harga diri yang rendah sering merasa tidak bernilai, tidak mampu dan kerap menyalahkan diri mereka sendiri. Pendekatan komunikasi pada pasien HDR memerlukan kesabaran dan ketelitian. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan perawat 1) Berikan pujian yang positif 2) Fokus pada kelebihan yang dimiliki pasien 3) Hindari memberikan kritik 4) Dorong pasien untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang sederhana. Contoh "Luar biasa Usaha yang anda lakukan, ini langkah yang sangat baik". Pendekatan ini berfungsi untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi pasien(Pereira *et al.*, 2024).

2. Adaptasi Teknik Komunikasi sesuai kondisi pasien

Tabel 3.3. Adaptasi teknik Komunikasi

Kondisi Pasien	Teknik Utama	Fokus Komunikasi
Depresi	Empati, silence, refleksi	Ekspresi emosi
Skizofrenia	Klarifikasi, validasi	Realitas & keamanan
Kecemasan	Reassurance, distraksi	Menenangkan
Harga diri rendah	Reinforcement, dukungan	Peningkatan percaya diri

Perawat harus flexibel saat menerapkan teknik komunikasi dan mampu membaca respons verbal dan nonverbal dari pasien. Penyesuaian yang tepat akan memperkuat efektivitas intervensi dan meningkatkan hubungan terapeutik (Afriani, Fajarica and Riyayanatasya, 2025)

Refrensi

- Afriani, N., Fajarica, D. and Riyayanatasya, W. (2025) 'Strategi Komunikasi Terapeutik Pada Pasien Skizofrenia (Studi Kualitatif Pada Psikoterapis Di Rsj Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Universitas Mataram*, 1(1).
- Akhmad, A.N., Bahfiarti, T. and Fatimah, J.M. (2024) 'Komunikasi Terapeutik dalam Mengurangi Tingkat Kecemasan: Literature Review', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, pp. 6194–6205.
- Almadina Rakhmaniar (2023) 'Komunikasi Terapeutik Pada Pasien Dengan Gangguan Mental (Studi Kualitatif Pada Psikoterapis) individu dengan gangguan mental , karena memfasilitasi pembentukan aliansi terapeutik yang verbal tetapi juga melibatkan isyarat non-verbal dan elemen sensorik', *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 1(2), pp. 292–306. Available at: <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.1120>.
- Annisa Salsabila Azis & Primatia Yogi Wulandari (2025) 'empati, depresi, emerging adulthood', *Fakultas Psikologi Universitas Airlangga*, 035(X). Available at: [https://repository.unair.ac.id/137973/1/Artikel Iliah_11211133002_Annisa Salsabila Azis.pdf](https://repository.unair.ac.id/137973/1/Artikel_Iliah_11211133002_Annisa_Salsabila_Azis.pdf).
- Apriliyanti, R., Saptyasari, A. and Puspa, R. (2021) 'Komunikasi Terapeutik Perawat untuk Meningkatkan Konsep Diri Pasien Skizofrenia', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), pp. 158–171.
- Awaliyah M. Suwetty (2021) *Konsep isolasi sosial dan aplikasi terapi*. Edited by S. Suhardin. Surabaya: Pustaka Saga.
- Awaliyah M. Suwetty (2024) 'Komunikasi Therapeutik dan Efektif pada pasien gangguan jiwa', in Arif Munandar (ed.) *Keperawatan Psikiatri dan Psikologi Kesehatan*. Bandung: Bunga Rampai.
- Carballedo-pulido, J., Farrés-tarafa, M. and Roldán-merino, J. (2026) 'Therapeutic communication in nursing students: A cross-sectional study of personal, educational, and contextual factors', *PLOS ONE*, pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0345109>.
- Cuma Çakmak, O.U." gurluo ~ glu (2024) 'The Effects of Patient-Centered Communication on Patient Engagement, Health-Related Quality of Life, Service Quality Perception and Patient Satisfaction in Patients with Cancer: A Cross-Sectional Study in Türkiye', *sage journal*, 31, pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.1177/10732748241236327>.

- Daisiu, C.P. and Kamaluddin, R. (2025) 'Manajemen agresi pasien di unit perawatan jiwa: A literature review', *Holistik Jurnal Kesehatan*, 19(6), pp. 1725–1733. Available at: file:///C:/Users/HP14s/Downloads/Manajemen_agresi_pasien_di_unit_perawatan_jiwa_A_l.pdf.
- Ernstmeyer K, C.E. (2025) 'Therapeutic Communication And The Nurse-Client Relationship', in E. Claire (ed.) *Mental Health and Community Concepts*. Chippewa Valley Technical College. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK617004/?utm_source.
- Hojat, M. et al. (2023) 'differences, erosion, enhancement, and healthcare outcomes', *Discover Health Systems*, 2(8). Available at: <https://doi.org/10.1007/s44250-023-00020-2>.
- Jeanette Varpen Marit, H.H. (2025) 'Nurse-patient relationship boundaries and power: A critical discursive analysis', *Nursing Ethics*, 32(6), pp. 1861–1872. Available at: <https://doi.org/10.1177/09697330251314093>.
- MA Syaripudin, A.M. (2023) 'Komunikasi Terapeutik Sebagai Sarana Efektif bagi Tindakan Keperawatan Yang Optimal', *Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 4(2), pp. 83–96. Available at: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/hikmah/article/view/5309/2213>.
- Melinda, annalia, Raziansyah, Lucia, Yohana, Widya, Ikhsan, A. (2022) *Komunikasi Terapeutik dalam Kesehatan*. Edited by Risnawati. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Naveen P. Sharma; Vikas Gupta. (2023) *Therapeutic Communication*. Florida: StatPearls Publishing LLC. Available at: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.
- Nembhard, I.M. et al. (2023) 'A systematic review of research on empathy in health care', *Health services research*, pp. 250–263. Available at: <https://doi.org/10.1111/1475-6773.14016>.
- Niu, Y. et al. (2025) 'The Critical Role and Effects of Patient-Centered Communication in Psychotherapy: A Narrative Review', *Psychology Research and Behavior Management*, 18(August), pp. 1657–1671.
- Nompo, R.S. (2023) 'Therapeutic Communication in Schizophrenic Patients: A Systematic Literature', *Scientia Psychiatrica*, 4(3), pp. 405–409.
- NSO (2025) 'Don't cross the line: respecting professional boundaries.', NSO Learning Center. Available at: <https://www.nso.com/Learning/Artifacts/Articles/Don-t-cross-the-line-respecting-professional-boundaries#:~:text=NCSBN>

- Nur Hidaayah et al. (2024) Buku Ajar Keperawatan Jiwa dan Psikososial, Bookchapter Jiwa. Jakarta Barat: PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta. Available at: <https://bookchapter.optimalbynfc.com/index.php/jiwa/article/view/60>.
- Pereira, S. et al. (2024) 'Positive Nursing Practice Environment: A Concept Analysis', nursing report, 14, pp. 3052–3068. Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11503395/pdf/nursrep-14-00222.pdf>.
- Price, O. et al. (2024) 'De-escalating aggression in acute inpatient mental health settings: a behaviour change theory-informed, secondary qualitative analysis of staff and patient perspectives', BMC Psychiatry, 24(548), pp. 1–15.
- Rahmawati and Sa'adah, N. (2022) 'Komunikasi Terapeutik dalam Tinjauan Konseling Analisis', Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 6(1), pp. 111–122.
- Resman Humolungo (2023) 'Penerapan Komunikasi Terapeutik pada Pasien Perilaku Kekerasan', Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 12 Nomor 1.
- Sitorus, P. (2024) 'Hubungan Komunikasi Teraupetik Perawat Dengan Tingkat Kepuasan Pasien', Nursing Applied Journal, 2(1). Available at: <file:///C:/Users/HP14s/Downloads/NAJ++Nursing+Applied+Journal+Vol.2,+No.1++JANUARI+2024+Hal+23-32.pdf>.
- Suryani, N.P. et al. (2023) 'Professional Boundaries in The Relationship Between Nurses and Patients in Healthcare Settings: A Scoping Review', Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan, 8(2), pp. 917–928. Available at: <https://doi.org/10.30604/jika.v8i2.2005>.
- Syifa Fauziah, Rini Anjani, S.F. (2023) 'Komunikasi terapeutik pada pasien depresi', Jurnal keperawatan Pernus, 1(1), pp. 10–15.
- Ulfah, L. et al. (2022) 'Komunikasi Terapeutik Pada Orang dengan Gangguan Mental Illness', Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), pp. 14351–14356. Available at: <file:///C:/Users/HP14s/Downloads/droza,+712.+Liza+Ulfah+Nuarida+Barus+14351-14356.pdf>.
- Varcarolis, E. M., & Halter, M.J. (2022) Foundations of Psychiatric-Mental Health Nursing: A Clinical Approach. 9th edn. St. Louis: MO: Elsevier.
- Vethabothagam, H.S., Article, O. and Nadu, T. (2024) 'A Study Of Non-Verbal Communication In Hospitals And Its Influence', ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 5(4), pp. 2059–2074. Available at: <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i4.2024.596>.

- Wantong Xue Master Degree Candidate, Catrina Heffernan Miller Felllow, DN, MSc, BSc, RNT, R. (2021) 'Therapeutic communication within the nurse–patient relationship: A concept analysis', *International journal of Nursing Practice*, 27(6). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ijn.12938>.
- Widiyanto, B. and Umar, E. (2024) *BUKU AJAR KOMUNIKASI TERAPEUTIK*. Jakarta Barat: PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta.

BAB IV

ASUHAN KEPERAWATAN PADA GANGGUAN JIWA UMUM

A. Pendahuluan

Secara global, gangguan jiwa telah menjadi salah satu penyebab utama beban penyakit. Laporan World Health Organization (2022) menyebutkan bahwa lebih dari 1 miliar orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Depresi dan gangguan ansietas sebagai penyumbang terbesar. Gangguan mental juga berkontribusi signifikan terhadap *Years lived with disability* (YLD) serta berhubungan dengan penurunan harapan hidup, khususnya pada gangguan mental berat seperti skizofrenia. Di Indonesia, permasalahan kesehatan jiwa juga menunjukkan tren yang memprihatinkan. Gangguan-gangguan tersebut tidak hanya bersifat kronis dan berisiko tinggi mengalami kekambuhan, tetapi juga sering menimbulkan disabilitas psikososial, stigma, serta beban ekonomi yang signifikan bagi individu dan keluarga.

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang memengaruhi cara seseorang memandang realitas, berpikir, dan berperilaku, sehingga dapat menghambat fungsi sosialnya. Gangguan mood seperti depresi dan bipolar berkaitan dengan ketidakseimbangan emosi, mulai dari kesedihan mendalam hingga perubahan suasana hati yang ekstrem. Gangguan ansietas adalah kondisi yang paling umum, ditandai dengan kecemasan berlebihan yang mengganggu kualitas hidup. Sementara itu, *Post-traumatic stress disorder* (PTSD) muncul akibat pengalaman traumatis yang berdampak jangka panjang pada kondisi psikologis. Gangguan kepribadian dan gangguan penggunaan zat berkaitan dengan pola perilaku yang kurang adaptif dan membutuhkan penanganan serta pendampingan berkelanjutan.

Dalam pelayanan kesehatan, penanganan gangguan jiwa memerlukan pendekatan yang menyeluruh, berkesinambungan, dan berbasis bukti. Perawat memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan klien, mulai dari melakukan pengkajian menyeluruh, menetapkan diagnosis, merencanakan dan melaksanakan tindakan, hingga mengevaluasi hasil perawatan. Selain itu, perawat juga membangun hubungan yang suportif, memberikan edukasi kepada klien dan keluarga, serta mendampingi proses pemulihan dan kembalinya klien ke kehidupan sosial.

Bab ini membahas tentang Asuhan Keperawatan pada Gangguan jiwa umum: Skizoprenia, Gangguan Mood, Ansietas, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), Gangguan kepribadian, dan Gangguan Penyalahgunaan Zat. Pembaca diharapkan mampu mengenali tanda dan gejala serta memahami penanganannya serta menerapkan proses keperawatan secara sistematis, mulai dari pengkajian hingga evaluasi, sehingga mampu memberikan perawatan yang profesional, humanis, dan berfokus pada pemulihan klien.

B. Asuhan Keperawatan pada Skizoprenia

1. Konsep Dasar Skizoprenia

Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang kompleks dan termasuk dalam kelompok gangguan psikotik. Kondisi ini memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku, serta membuatnya sulit memahami realitas secara tepat. Akibatnya, individu sering kesulitan membedakan mana yang nyata dan tidak, yang dapat terlihat dari munculnya halusinasi, waham, dan gangguan dalam pola pikir (Ernstmeyer, K., & Christman, 2022)

Skizofrenia terjadi akibat gangguan pada sistem kerja otak yang cukup kompleks. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan zat kimia otak, terutama dopamin. Kelebihan aktivitas dopamin pada bagian otak tertentu dapat memicu munculnya gejala seperti halusinasi dan waham, sedangkan kekurangan dopamin di area lain berhubungan dengan gejala seperti menarik diri, kurang motivasi, dan gangguan berpikir. Selain itu, zat kimia lain seperti glutamat dan serotonin juga turut berperan dalam mengganggu keseimbangan fungsi otak (Stahl, 2021)

Di samping itu, pada individu dengan skizofrenia juga ditemukan perubahan pada struktur dan fungsi otak, seperti adanya pembesaran rongga otak (ventrikel) dan penurunan fungsi pada bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi. Kondisi ini membuat individu mengalami kesulitan dalam mengatur pikiran dan respons emosinya. Faktor genetik serta pengaruh lingkungan seperti stres juga turut memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, skizofrenia tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari berbagai proses yang saling berkaitan di dalam tubuh dan lingkungan individu (Stuart, 2012). Dari sisi psikologis, pengalaman traumatis, pola asuh yang kurang mendukung, dan mekanisme koping yang tidak efektif dapat memperbesar risiko munculnya gangguan. Sementara itu, faktor sosial dan lingkungan seperti stres berkepanjangan, konflik keluarga, isolasi sosial, serta penggunaan zat psikoaktif dapat menjadi pemicu munculnya gejala pada individu yang sudah memiliki kerentanan sebelumnya. Interaksi ketiga faktor ini

menyebabkan skizofrenia berkembang secara kompleks dan memerlukan penanganan yang menyeluruh.

Tanda dan gejala skizofrenia umumnya muncul dalam berbagai bentuk yang memengaruhi pikiran, persepsi, emosi, dan perilaku individu. Secara klinis, gejala skizofrenia sering dikelompokkan menjadi gejala positif, negatif, dan kognitif. Gejala positif merupakan gejala yang muncul sebagai tambahan dari fungsi normal, seperti halusinasi (mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata), waham (keyakinan yang tidak sesuai dengan realitas), serta pembicaraan yang tidak terorganisir. Gejala negatif menggambarkan penurunan atau hilangnya fungsi normal individu. Gejala ini meliputi berkurangnya ekspresi emosi (afek datar), kurangnya motivasi (avolisi), menarik diri dari lingkungan sosial, serta penurunan kemampuan dalam berkomunikasi. Gejala negatif sering kali membuat individu tampak pasif dan kurang responsif terhadap lingkungan sekitarnya (Stuart, 2012). Di sisi lain, gejala kognitif juga sering ditemukan pada individu dengan skizofrenia. Gejala ini meliputi gangguan dalam perhatian, memori, serta kemampuan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan berfungsi secara mandiri (Townsend, M. C., & Morgan, 2021)

2. Penatalaksanaan Skizoprenia

Penanganan skizofrenia dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan membantu individu mengurangi gejala, mencegah kekambuhan, dan menjalani kehidupan yang lebih optimal. Pengobatan utama biasanya menggunakan obat antipsikotik yang bekerja menyeimbangkan zat kimia di otak, sehingga gejala seperti halusinasi dan waham dapat berkurang. Selain itu, dukungan melalui terapi psikososial seperti *cognitive behavioral therapy*, pelatihan keterampilan sosial, dan terapi keluarga juga sangat penting untuk membantu individu memahami kondisinya, mengelola gejala, serta membangun kembali kemampuan berinteraksi dengan orang lain (American Psychiatric Association, 2022)

Di samping itu, proses pemulihan juga membutuhkan rehabilitasi psikososial dan peran aktif keluarga. Program rehabilitasi membantu individu kembali mandiri dalam aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja dan bersosialisasi. Dukungan keluarga melalui edukasi dan pendampingan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan serta mencegah kekambuhan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan penuh dukungan, penanganan skizofrenia tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi juga pada upaya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Penatalaksanaan keperawatan pada pasien skizofrenia dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada kebutuhan individu. Perawat memiliki peran penting dalam membantu klien mengendalikan gejala, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, serta mendukung proses pemulihan. Proses ini diawali dengan membangun hubungan saling percaya melalui komunikasi yang empati, jujur, dan konsisten. Hubungan yang baik menjadi kunci utama, mengingat klien sering mengalami gangguan persepsi dan kesulitan mempercayai orang lain. Selain itu, perawat melakukan pengkajian secara menyeluruh meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual untuk menentukan kebutuhan perawatan yang tepat.

Dalam praktiknya, perawat membantu klien mengelola gejala seperti halusinasi dan waham dengan cara yang sederhana dan terarah, misalnya dengan mengenali gejala, mengalihkan perhatian, atau melakukan aktivitas yang terstruktur. Perawat juga melatih keterampilan komunikasi dan interaksi sosial agar klien tidak merasa terisolasi. Selain itu, kebutuhan dasar seperti kebersihan diri, makan, dan aktivitas sehari-hari turut diperhatikan karena sering mengalami penurunan. Edukasi mengenai pentingnya minum obat secara teratur juga diberikan untuk mencegah kekambuhan.

Tidak kalah penting, perawat melibatkan keluarga sebagai bagian dari dukungan utama bagi klien. Keluarga diberikan pemahaman tentang kondisi yang dialami, cara merawat di rumah, serta tanda-tanda kekambuhan yang perlu diwaspadai. Perawat juga mendorong klien mengikuti kegiatan rehabilitasi seperti terapi kelompok atau aktivitas yang dapat meningkatkan kemandirian. Dengan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan klien dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan mandiri.

3. Asuhan Keperawatan Pada Skizoprenia

Pengkajian keperawatan pada klien dengan skizofrenia merupakan langkah awal yang penting untuk memahami kondisi klien secara menyeluruh. Perawat mengumpulkan informasi dari berbagai aspek, meliputi kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, agar dapat mengenali kebutuhan serta masalah yang dialami klien. Pada aspek fisik, perawat memperhatikan kondisi kesehatan umum, pola tidur, nafsu makan, aktivitas sehari-hari, serta penggunaan obat dan kemungkinan efek sampingnya. Pendekatan ini membantu perawat melihat kondisi klien secara utuh, tidak hanya dari sisi gangguan jiwanya saja.

Dari sisi psikologis, pengkajian berfokus pada bagaimana klien berpikir, merasakan, dan memandang realitas. Perawat mengamati adanya gejala seperti halusinasi, waham, kesulitan berkonsentrasi, serta perubahan emosi dan perilaku. Selain itu, kemampuan klien dalam mengenali lingkungan, memahami situasi,

serta cara mereka menghadapi stres juga menjadi bagian penting yang dinilai. Dalam aspek sosial, perawat menggali hubungan klien dengan keluarga dan lingkungan, termasuk adanya dukungan atau justru isolasi sosial. Nilai dan keyakinan spiritual juga turut diperhatikan karena dapat menjadi sumber kekuatan dalam proses pemulihan.

Selain itu, perawat juga perlu mengidentifikasi adanya risiko yang mungkin muncul, seperti perilaku kekerasan, keinginan bunuh diri, atau penelantaran diri. Proses pengkajian dilakukan dengan membangun hubungan yang hangat dan saling percaya agar klien merasa aman dan terbuka. Dengan pemahaman yang menyeluruh ini, perawat dapat merencanakan asuhan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan klien, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal.

Diagnosa keperawatan pada klien dengan skizofrenia ditentukan dari pemahaman menyeluruh terhadap kondisi yang dialami klien, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Masalah yang sering muncul antara lain gangguan persepsi seperti halusinasi, di mana klien merasakan sesuatu yang tidak nyata, serta gangguan pola pikir seperti waham yang membuat klien meyakini hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, klien sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial hingga menarik diri dari lingkungan, disertai perasaan rendah diri dan kurang percaya diri. Tidak jarang juga ditemukan kesulitan dalam merawat diri, seperti menjaga kebersihan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada kondisi tertentu, klien dapat menunjukkan risiko perilaku kekerasan atau bahkan keinginan menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, mengenali berbagai masalah ini secara tepat sangat penting agar perawat dapat memberikan asuhan yang sesuai dan mendukung proses pemulihan klien secara optimal.

Rencana tindakan keperawatan pada klien dengan skizofrenia disusun sesuai dengan masalah yang dialami, dengan tujuan membantu klien mengendalikan gejala, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, dan mencapai kemandirian. Perawat memulai dengan membangun hubungan yang hangat dan saling percaya agar klien merasa aman. Selanjutnya, klien dibimbing untuk mengenali dan mengelola gejala seperti halusinasi, misalnya dengan mengidentifikasi kapan gejala muncul, mengalihkan perhatian, atau melakukan aktivitas yang bermanfaat. Pada klien dengan waham, perawat membantu secara perlahan mengarahkan pada realitas tanpa memaksakan atau menentang secara langsung. Selain itu, perawat juga melatih kemampuan berinteraksi, membantu pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebersihan diri dan makan, serta memberikan edukasi tentang pentingnya minum obat secara teratur dan mengenali tanda kekambuhan.

Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi klien selama proses perawatan. Keberhasilan dapat dilihat dari kemampuan klien dalam mengontrol gejala, berinteraksi lebih baik dengan lingkungan, serta meningkatnya kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Klien juga diharapkan lebih patuh dalam menjalani pengobatan dan mampu menghadapi stres dengan lebih baik. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai, maka rencana perawatan dapat disesuaikan kembali. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan membantu memastikan bahwa perawatan yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan klien dan mendukung proses pemulihan secara optimal.

C. Asuhan Keperawatan Gangguan Mood

1. Konsep Dasar Gangguan Mood

Gangguan mood merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh perubahan suasana perasaan yang berlangsung cukup lama dan memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, serta menjalani kehidupan sehari-hari. Perubahan ini tidak sekadar naik turunnya emosi yang wajar, tetapi sudah berada pada tingkat yang lebih mendalam dan menetap sehingga dapat mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, maupun hubungan dengan orang lain (Sekhon, S., & Gupta, 2023). Dalam praktik klinis, gangguan mood umumnya muncul dalam dua bentuk utama, yaitu suasana perasaan yang menurun seperti pada depresi, atau meningkat secara berlebihan seperti pada mania dan hipomania (American Psychiatric Association, 2022).

Gangguan mood pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan seseorang. Secara biologis, perubahan keseimbangan zat kimia di otak seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin dapat memengaruhi cara individu merasakan dan mengekspresikan emosi, sehingga suasana hati menjadi lebih mudah berubah atau menetap dalam kondisi tertentu seperti sedih berkepanjangan atau *euforia* berlebihan (Rappoport, 2024). Di sisi lain, faktor genetik juga memiliki peran, di mana individu dengan riwayat keluarga gangguan mood cenderung memiliki kerentanan yang lebih tinggi, seolah membawa "modal biologis" yang membuatnya lebih sensitif terhadap tekanan (Setyowati, H., Frijanto, A., & Agustina, 2024). Namun demikian, pengalaman hidup tetap menjadi kunci penting, karena stres yang terus-menerus, pengalaman traumatis, kehilangan orang yang dicintai, atau konflik batin yang tidak terselesaikan dapat memperberat beban psikologis seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi lingkungan seperti hubungan keluarga yang kurang harmonis, tekanan pekerjaan, serta tuntutan sosial yang tinggi juga dapat memperburuk keadaan

emosional (Nasution, H. N., & Firdausi, 2020). Tidak kalah penting, perubahan hormon dan kondisi kesehatan fisik turut memengaruhi kestabilan suasana hati, terlebih bila disertai pola hidup yang kurang sehat seperti kurang tidur atau penggunaan zat adiktif (Teodorescu et al., 2021). Dengan demikian, gangguan mood dapat dipahami sebagai hasil dari perjalanan hidup seseorang yang dipengaruhi oleh interaksi antara tubuh, pikiran, dan lingkungan, sehingga pendekatan perawatan perlu dilakukan secara menyeluruh dan penuh empati, dengan melihat individu sebagai satu kesatuan yang utuh.

Gangguan mood biasanya tampak melalui perubahan perasaan yang cukup mencolok dan berlangsung terus-menerus, sehingga memengaruhi cara seseorang menjalani aktivitas sehari-hari. Pada kondisi depresi, seseorang dapat merasa sangat sedih, kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya menyenangkan, mudah lelah, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, serta mengalami kesulitan berkonsentrasi dan perasaan tidak berharga. Sebaliknya, pada kondisi mania atau hipomania, suasana hati bisa meningkat secara berlebihan, individu tampak lebih berenergi, percaya diri tinggi, kebutuhan tidur berkurang, dan cenderung bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan risiko. Perubahan ini sering terjadi secara bergantian dan dapat mengganggu hubungan sosial, pekerjaan, serta kualitas hidup secara keseluruhan (Coryell, 2025).

2. Penatalaksanaan pada Gangguan Mood

Penatalaksanaan gangguan mood dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan terapi obat, dukungan psikologis, dan peran lingkungan sekitar. Pemberian obat seperti antidepresan, mood stabilizer, atau antipsikotik membantu menstabilkan suasana hati dan mengurangi gejala yang muncul. Secara umum, terapi farmakologis menjadi lini utama, seperti penggunaan antidepresan pada depresi serta mood stabilizer (misalnya lithium) dan antipsikotik pada gangguan bipolar, yang terbukti efektif dalam mengontrol gejala dan meningkatkan fungsi pasien (Cynthia Arum et al, 2026). Di sisi lain, terapi seperti *cognitive behavioral therapy* (CBT) membantu individu memahami serta mengelola pikiran dan perasaan yang tidak adaptif. Dukungan keluarga, edukasi, serta kepatuhan terhadap pengobatan juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Pada kondisi yang lebih berat, seperti adanya risiko membahayakan diri sendiri, perawatan intensif mungkin diperlukan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, penanganan gangguan mood tidak hanya berfokus pada meredakan gejala, tetapi juga membantu individu kembali menjalani hidup dengan lebih stabil dan bermakna (Ridho et al., 2024).

3. Asuhan Keperawatan pada Gangguan Mood

Asuhan keperawatan pada gangguan mood diawali dengan pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk memahami kondisi klien secara utuh. Pada tahap ini, perawat mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan status mental, dengan memperhatikan perubahan suasana hati seperti kesedihan yang mendalam, perasaan sangat gembira, atau mudah tersinggung. Selain itu, perawat juga menilai gejala lain yang menyertai, seperti gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan, serta kesulitan berkonsentrasi. Riwayat kesehatan, baik pribadi maupun keluarga, serta pengalaman hidup yang penuh tekanan juga menjadi bagian penting yang perlu digali karena dapat memengaruhi kondisi emosional klien. Pemeriksaan status mental yang mencakup penampilan umum, afek dan suasana perasaan, proses pikir, isi pikir, persepsi, serta fungsi kognitif untuk menilai adanya gejala depresi atau mania (Fortinash, K. M., & Worret, 2014). Melalui pengkajian yang dilakukan dengan empati dan ketelitian, perawat dapat memahami kebutuhan klien secara lebih mendalam sehingga asuhan yang diberikan menjadi lebih tepat dan bermakna.

Diagnosa keperawatan pada klien dengan gangguan mood disusun berdasarkan bagaimana individu merespons perubahan emosi, pikiran, dan perilaku yang dialaminya. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain perasaan tidak berharga atau harga diri rendah, ketidakmampuan menghadapi stres (koping tidak efektif), serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Pada kondisi depresi yang lebih berat, risiko bunuh diri menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan klien. Sementara itu, pada fase mania, klien dapat menunjukkan perilaku impulsif dan gangguan pola tidur akibat peningkatan energi yang berlebihan. Selain itu, dapat pula ditemukan gangguan persepsi atau perubahan pola makan. Oleh karena itu, penetapan diagnosa keperawatan perlu dilakukan secara cermat dan individual, agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien (Varcarolis, 2023).

Intervensi keperawatan pada klien dengan gangguan mood berfokus pada membantu individu mencapai kestabilan emosi dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Perawat memulai dengan membangun hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan, sehingga klien merasa aman untuk berbagi perasaan dan pengalaman yang dialaminya. Selanjutnya, klien dibimbing untuk mengenali dan mengelola emosinya melalui cara-cara yang lebih sehat, seperti teknik relaksasi dan strategi koping yang adaptif. Pada kondisi yang berisiko, seperti munculnya keinginan menyakiti diri, perhatian utama diarahkan pada menjaga keselamatan klien dengan pengawasan yang tepat serta dukungan dari

keluarga. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya minum obat secara teratur, menjaga pola tidur, dan menjalani aktivitas yang seimbang juga menjadi bagian penting dalam perawatan. Sementara itu, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan melihat perubahan kondisi klien, seperti kemampuan mengungkapkan perasaan, berkurangnya gejala, serta meningkatnya kemampuan beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Melalui proses ini, perawat dapat menilai sejauh mana intervensi yang diberikan efektif dan menyesuaikannya dengan kebutuhan klien agar proses pemulihan berjalan lebih optimal (Varcarolis, 2023)

D. Asuhan Keperawatan Ansietas

1. Konsep Dasar Ansietas

Ansietas adalah perasaan tidak nyaman yang muncul dalam bentuk kekhawatiran, ketakutan, atau kegelisahan yang sering kali tidak memiliki penyebab yang jelas. Kondisi ini merupakan respons alami seseorang ketika menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau tidak pasti. Dalam batas tertentu, ansietas dapat membantu individu menjadi lebih waspada dan siap menghadapi tantangan. Namun, jika dirasakan secara berlebihan, berlangsung lama, dan tidak terkendali, ansietas dapat mengganggu keseimbangan emosi, pola pikir, hingga aktivitas sehari-hari individu (Videbeck, 2020). Ansietas juga dipahami sebagai respons psikologis yang sering muncul pada individu dengan kondisi kesehatan tertentu, yang dapat memengaruhi keseimbangan fisik dan mental. Ansietas berkaitan dengan perasaan tidak berdaya, ketegangan, serta perubahan kondisi kesehatan yang dapat memperburuk keadaan individu jika tidak ditangani secara tepat (Nurhayati et al., 2024).

Ansietas tidak muncul begitu saja, melainkan berkembang dari perpaduan berbagai faktor yang saling memengaruhi dalam kehidupan seseorang. Ansietas diawali oleh persepsi individu terhadap ancaman yang diproses di korteks serebri, kemudian diteruskan ke sistem limbik, khususnya amigdala, yang berperan dalam respons emosional. Aktivasi amigdala akan merangsang hipotalamus untuk mengaktifkan sistem saraf simpatis dan aksis hipotalamus–pituitari–adrenal (HPA axis). Aktivasi HPA axis menyebabkan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, yang menimbulkan respons fisiologis berupa peningkatan denyut jantung, tekanan darah, frekuensi napas, serta ketegangan otot. Respons ini dikenal sebagai mekanisme *fight or flight* (Bandelow & Michaelis, 2022). Selain itu, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti penurunan GABA (inhibitor) dan serotonin serta peningkatan norepinefrin menyebabkan peningkatan kewaspadaan, rasa takut, dan hiperaktivitas sistem saraf. Kondisi ini jika berlangsung lama dapat mengganggu fungsi kognitif, emosi, dan perilaku

individu. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa ansietas kronis dapat menyebabkan perubahan neuroplastisitas otak, terutama pada amigdala dan hipokampus, yang memperkuat respons takut dan memperburuk kemampuan individu dalam mengelola stres (Bandelow & Michaelis, 2022).

Ansietas sering kali muncul melalui berbagai tanda yang dirasakan baik pada tubuh maupun pikiran seseorang. Tubuh bisa memberi sinyal seperti jantung yang berdebar lebih cepat, napas terasa pendek, tubuh berkeringat, gemetar, atau otot terasa tegang. Di saat yang sama, perasaan gelisah, takut, dan khawatir seolah datang tanpa alasan yang jelas. Pikiran pun menjadi sulit fokus karena dipenuhi bayangan atau kekhawatiran yang terus berulang. Dalam perilaku sehari-hari, seseorang mungkin tampak tidak tenang, sulit diam, cenderung menarik diri, atau menghindari situasi yang dirasa membuatnya tidak nyaman. Setiap orang dapat merasakan gejala ini dengan cara dan tingkat yang berbeda, tergantung pada bagaimana ia menghadapi tekanan yang sedang dialami (Stuart, 2016).

2. Penatalaksanaan Ansietas

Penanganan ansietas saat ini lebih menekankan pendekatan yang menyeluruh, dengan menggabungkan terapi psikologis, penggunaan obat bila diperlukan, serta perubahan pola hidup yang lebih sehat. Salah satu metode yang banyak dianjurkan adalah *cognitive behavioral therapy* (CBT), yaitu terapi yang membantu individu memahami cara pikir yang kurang tepat sekaligus melatih perubahan perilaku yang selama ini memperkuat rasa cemas. Melalui proses ini, individu perlahan belajar melihat situasi dengan lebih realistis dan meresponsnya secara lebih adaptif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa CBT menjadi pilihan utama karena terbukti efektif dan konsisten dalam mengurangi gejala ansietas serta membantu individu kembali menjalani fungsi sosial dan keseharian dengan lebih baik (Bhattacharya et al., 2023).

Di sisi lain, penggunaan obat juga menjadi bagian penting dalam penanganan ansietas, terutama ketika gejalanya sudah cukup mengganggu. Beberapa jenis obat seperti SSRI, SNRI, pregabalin, dan benzodiazepin bekerja dengan membantu menyeimbangkan zat kimia di otak yang berperan dalam munculnya rasa cemas. Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan perasaan cemas dapat berkurang secara bertahap. Meski demikian, pemilihan dan penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu, karena setiap orang dapat memberikan respons yang berbeda dan berpotensi mengalami efek samping tertentu (Fagan et al., 2023). Selain penggunaan obat, berbagai pendekatan tanpa farmakologis juga semakin banyak digunakan untuk membantu mengurangi ansietas. Praktik sederhana seperti mindfulness, latihan

relaksasi, dan aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan alternatif baru, seperti terapi berbasis *virtual reality*, yang memberikan pengalaman terapeutik dengan cara yang lebih menarik. Pendekatan-pendekatan ini terbukti cukup efektif, terutama pada individu dengan tingkat kecemasan ringan hingga sedang, karena membantu mereka mengelola stres dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan (Mishelle et al., 2025).

3. Asuhan Keperawatan Pada Ansietas

Pengkajian pada klien dengan ansietas perlu dilakukan secara utuh agar perawat dapat benar-benar memahami apa yang dirasakan individu, baik dari sisi fisik, emosional, maupun lingkungan sosialnya. Proses ini biasanya diawali dengan pendekatan yang hangat dan terbuka, sehingga klien merasa aman untuk menceritakan perasaan seperti takut, cemas, atau rasa tidak nyaman yang kadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di samping itu, perawat juga perlu membantu menggali hal-hal yang menjadi pemicu kecemasan, seperti pengalaman stres di masa lalu, kondisi kesehatan yang sedang dialami, atau perubahan hidup yang dirasakan cukup berat bagi klien (Stuart, 2016). Dalam proses pengkajian, perawat juga memperhatikan berbagai tanda fisik yang muncul, seperti jantung berdebar lebih cepat, napas terasa pendek, otot yang menegang, hingga kesulitan tidur, karena kecemasan sering kali ikut memengaruhi kondisi tubuh. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa indikator fisiologis seperti sinyal jantung dan respons elektrodermal dapat digunakan sebagai penanda objektif dalam mendeteksi ansietas, meskipun penggunaannya masih berkembang dalam praktik klinis (Zhou, 2024). Selain itu, cara berpikir klien juga menjadi bagian penting untuk dipahami, misalnya ketika pikiran dipenuhi rasa khawatir, sulit fokus, atau cenderung memandang situasi sebagai sesuatu yang mengancam. Dari sisi perilaku, perubahan seperti tampak gelisah, lebih suka menyendiri, atau menghindari situasi tertentu juga perlu diperhatikan, karena hal-hal tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi ansietas yang dialami klien (Samsugito et al., 2024).

Masalah keperawatan yang muncul tidak hanya terbatas pada rasa cemas itu sendiri, tetapi juga dapat berkembang ke berbagai aspek kehidupan individu. Ansietas menjadi diagnosa utama yang ditandai dengan perasaan khawatir, gelisah, dan ketidaknyamanan yang sulit dikendalikan, sering kali dipicu oleh situasi yang dirasakan sebagai ancaman atau tekanan. Ketika kecemasan ini tidak terkelola dengan baik, individu dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah, sehingga muncul kondisi koping yang kurang efektif (PPNI, 2017). Hal

ini terlihat dari cara individu merespons stres, seperti menghindari masalah, menarik diri, atau bergantung pada orang lain. Ansietas juga dapat memengaruhi kebutuhan dasar seseorang. Misalnya, pola tidur menjadi terganggu karena pikiran yang terus aktif dan sulit untuk tenang, sehingga individu merasa lelah dan kurang bertenaga. Nafsu makan pun bisa menurun, yang berdampak pada kondisi fisik secara keseluruhan. Pada beberapa kasus, muncul pula rasa takut yang lebih spesifik ketika individu mulai dapat mengidentifikasi sumber ancaman yang dirasakan. Bahkan, jika kondisi ini berlangsung cukup lama, individu dapat cenderung menjauh dari lingkungan sosial karena merasa tidak nyaman atau tidak mampu berinteraksi dengan baik. Dengan demikian, berbagai diagnosa keperawatan pada klien ansietas saling berkaitan dan menggambarkan bagaimana kecemasan dapat memengaruhi kondisi fisik, emosional, dan sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, perawat perlu melihat kondisi klien secara utuh agar dapat memberikan asuhan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan individu.

Penatalaksanaan keperawatan pada klien ansietas difokuskan pada upaya membantu individu mengenali, mengelola, dan secara bertahap mengurangi kecemasan yang dialaminya. Langkah awal yang penting adalah membangun hubungan terapeutik yang hangat dan penuh empati, sehingga klien merasa aman untuk mengekspresikan perasaan dan kekhawatirannya. Teknik relaksasi menjadi bagian penting dalam intervensi, seperti latihan napas dalam, relaksasi otot progresif, dan mindfulness. Teknik-teknik ini membantu menurunkan aktivasi sistem saraf simpatis sehingga tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran lebih tenang. Aktivitas fisik ringan dan rutin juga dianjurkan karena dapat membantu mengurangi ketegangan dan memperbaiki suasana hati (Mangolini, V. I., & Andrade, 2019).

Evaluasi dilakukan untuk melihat seberapa jauh upaya yang telah diberikan benar-benar membantu klien dalam menghadapi dan mengelola rasa cemasnya. Tanda keberhasilan dapat dirasakan langsung oleh klien, misalnya ketika perasaan cemas mulai berkurang, muncul rasa lebih tenang, serta kemampuan untuk mengenali dan mengendalikan pikiran negatif menjadi lebih baik. Selain itu, perubahan juga terlihat dari kondisi fisik yang semakin membaik, seperti detak jantung yang lebih teratur, tidur yang lebih nyenyak, dan tubuh yang terasa lebih rileks tanpa ketegangan berlebih.

E. Asuhan Keperawatan *Post Trauma Distress Syndrome* (PTSD)

1. Konsep Dasar *Post Trauma Distress Syndrome* (PTSD)

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) adalah kondisi gangguan kesehatan mental yang dapat dialami seseorang setelah menghadapi atau menyaksikan peristiwa yang sangat mengguncang dan mengancam keselamatan, seperti kematian, luka berat, atau kekerasan. Pengalaman tersebut tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi sering kali hadir kembali dalam bentuk ingatan yang mengganggu, mimpi buruk, atau perasaan seolah-olah kejadian itu terulang. Individu juga cenderung menghindari hal-hal yang mengingatkannya pada peristiwa tersebut, disertai perubahan suasana hati dan cara berpikir yang menjadi lebih negatif. Selain itu, mereka biasanya menjadi lebih waspada, mudah terkejut, dan sulit merasa tenang (Merians et al., 2023). Seiring berkembangnya penelitian, PTSD kini dipahami sebagai kondisi yang tidak sederhana dan dapat muncul dalam berbagai bentuk pada setiap individu. Gejala yang dirasakan, tingkat keparahan, hingga perjalanan gangguannya bisa berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, serta lingkungan sosial seseorang. Dengan kata lain, PTSD tidak semata-mata ditentukan oleh peristiwa traumatis yang dialami, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana seseorang memahami, merasakan, dan memberi makna terhadap pengalaman tersebut dalam dirinya (Brooks & Greenberg, 2024)

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) muncul sebagai dampak dari pengalaman traumatis yang sangat membekas, seperti kecelakaan, kekerasan, bencana, atau kehilangan orang terdekat, terutama ketika individu merasa takut, tidak berdaya, atau kehilangan kendali saat kejadian berlangsung. Namun, tidak semua orang yang mengalami trauma akan berkembang menjadi PTSD, karena kondisi ini juga dipengaruhi oleh kerentanan biologis, cara individu memaknai dan mengolah pengalaman tersebut, serta dukungan dari lingkungan sekitarnya. Ketika respons stres menjadi berlebihan, individu kesulitan memahami pengalaman secara adaptif, dan minim dukungan emosional, maka risiko terjadinya PTSD akan semakin meningkat (Jowf et al., 2023)

Patofisiologi *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) terjadi melalui proses yang saling berkaitan antara tubuh dan pikiran setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Saat trauma terjadi, tubuh secara otomatis mengaktifkan sistem stres dengan melepaskan hormon seperti kortisol untuk membantu menghadapi ancaman. Namun, pada individu dengan PTSD, respons ini tidak kembali normal, sehingga tubuh seolah-olah terus berada dalam kondisi waspada meskipun situasi sudah aman. Di dalam otak, bagian yang mengatur rasa takut menjadi lebih aktif, sementara area yang berfungsi mengendalikan emosi justru

melemah, sehingga individu lebih mudah merasa cemas dan kesulitan menenangkan diri. Selain itu, terjadi perubahan pada struktur dan fungsi otak. *Amigdala*, yang berperan dalam mengatur respons takut, menjadi hiperaktif sehingga individu lebih mudah merasa cemas dan terancam. Sebaliknya, korteks prefrontal yang berfungsi mengendalikan emosi mengalami penurunan aktivitas, sehingga kemampuan individu untuk mengontrol respons emosional menjadi terganggu. Hipokampus, yang berperan dalam memproses memori, juga mengalami gangguan, sehingga ingatan traumatis sulit diintegrasikan dengan baik dan sering muncul kembali secara tidak terkendali dalam bentuk kilas balik atau mimpi buruk (Davis & Hamner, 2024).

2. Penatalaksanaan Post Trauma Distress Syndrome (PTSD)

Penatalaksanaan pada klien dengan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan pendekatan psikologis, farmakologis, serta dukungan sosial, karena kondisi ini melibatkan aspek biologis, emosional, dan lingkungan secara bersamaan. Berdasarkan penelitian dan pedoman klinis terbaru, terapi psikologis menjadi pilihan utama dalam penanganan PTSD, terutama terapi yang berfokus pada trauma seperti *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), *Cognitive Processing Therapy* (CPT), dan *Prolonged Exposure Therapy*. Pendekatan ini membantu klien secara perlahan menghadapi kembali pengalaman traumatisnya dalam suasana yang aman, sehingga individu dapat mengubah cara berpikir yang maladaptif dan mengurangi respons emosional yang berlebihan (Schnurr, 2024). Penanganan PTSD tidak hanya berfokus pada terapi medis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial dan pendekatan keperawatan yang bersifat terapeutik. Lingkungan yang penuh penerimaan, hubungan yang hangat, serta komunikasi yang empatik dapat membuat individu merasa lebih aman dan dihargai, sehingga membantu mempercepat proses pemulihan. Dalam praktik keperawatan, berbagai intervensi seperti pengelolaan kecemasan, latihan relaksasi, pemberian edukasi kesehatan mental, dan penguatan kemampuan coping adaptif menjadi langkah penting untuk membantu klien menghadapi gejala secara bertahap. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan, diharapkan klien dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan bermakna.

3. Asuhan Keperawatan pada Post Trauma Distress Syndrome (PTSD)

Pengkajian pada klien dengan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) merupakan langkah awal yang penting untuk memahami kondisi individu secara menyeluruh, baik dari aspek pengalaman traumatis, respons psikologis, maupun fungsi sosialnya. Proses ini biasanya diawali dengan membangun hubungan saling percaya agar klien merasa aman dalam menceritakan pengalaman yang

dialami. Perawat kemudian menggali riwayat kejadian traumatis, termasuk jenis peristiwa, waktu kejadian, serta bagaimana klien merasakan dan merespons peristiwa tersebut. Selain itu, pengkajian juga mencakup identifikasi gejala utama seperti munculnya kembali ingatan traumatis, perilaku menghindar, perubahan suasana hati, serta peningkatan kewaspadaan yang berlebihan, yang merupakan karakteristik utama PTSD (Schincariol et al., 2024). Lebih lanjut, perawat perlu menilai kondisi emosional dan kognitif klien, seperti perasaan cemas, takut, bersalah, atau pikiran negatif yang menetap, serta kemampuan klien dalam mengontrol emosi dan konsentrasi. Pengkajian terhadap pola tidur, adanya mimpi buruk, serta respons fisik seperti mudah terkejut atau tegang juga menjadi bagian penting karena mencerminkan aktivasi sistem stres yang berlebihan. Di samping itu, aspek fungsi sosial perlu diperhatikan, termasuk hubungan dengan keluarga, dukungan sosial, serta kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari, karena PTSD sering kali berdampak pada penurunan fungsi kehidupan (Lawrence D, Ridders W, Bartlett J, 2024)

Pada klien dengan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), diagnosa keperawatan yang muncul umumnya berkaitan dengan respons emosional, kognitif, dan perilaku yang terganggu akibat pengalaman traumatis. Salah satu masalah yang sering ditemukan adalah ansietas, di mana klien menunjukkan perasaan cemas berlebihan, mudah terkejut, dan sulit merasa tenang karena tubuh terus berada dalam kondisi waspada. Selain itu, gangguan pola tidur juga kerap terjadi, ditandai dengan kesulitan tidur atau mimpi buruk yang berulang, sehingga memengaruhi kualitas istirahat dan energi sehari-hari. Klien juga dapat mengalami gangguan proses pikir, seperti munculnya ingatan traumatis yang tidak diinginkan atau kesulitan berkonsentrasi, serta perubahan cara pandang yang menjadi lebih negatif terhadap diri sendiri maupun lingkungan.

Di samping itu, beberapa klien menunjukkan koping individu yang tidak efektif, karena kesulitan dalam mengelola emosi dan menghadapi pengalaman traumatis secara adaptif. Perasaan tidak berdaya, menarik diri dari lingkungan, hingga munculnya harga diri rendah juga dapat ditemukan, terutama ketika klien merasa dirinya berbeda atau tidak mampu kembali seperti sebelumnya. Pada kondisi tertentu, bahkan dapat muncul risiko perilaku kekerasan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sebagai bentuk luapan emosi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, identifikasi diagnosa keperawatan yang tepat sangat penting agar intervensi yang diberikan dapat membantu klien secara bertahap membangun kembali rasa aman, meningkatkan kemampuan koping, dan menjalani kehidupan dengan lebih stabil (Merians, A. N., 2023)

Rencana tindakan keperawatan pada klien dengan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) difokuskan pada upaya membantu klien merasa aman, mampu mengelola kecemasan, serta secara bertahap memproses pengalaman traumatis yang dialaminya. Pendekatan yang dilakukan perlu dimulai dari membangun hubungan terapeutik yang hangat dan penuh empati, sehingga klien merasa dipercaya dan tidak dihakimi saat mengungkapkan perasaannya. Perawat juga berperan dalam membantu klien mengenali tanda-tanda kecemasan yang muncul, kemudian melatih teknik sederhana seperti relaksasi napas dalam, distraksi, atau grounding untuk menurunkan intensitas emosi. Selain itu, edukasi mengenai kondisi PTSD penting diberikan agar klien memahami bahwa respons yang dialaminya merupakan hal yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan dapat ditangani. Dalam prosesnya, klien didorong untuk mengembangkan cara koping yang lebih adaptif, serta secara perlahan menghadapi ingatan traumatis dengan cara yang aman dan terkontrol sesuai kesiapan individu.

Di samping intervensi terhadap individu, keterlibatan keluarga dan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam rencana tindakan. Dukungan emosional dari orang terdekat dapat membantu klien merasa lebih diterima dan tidak sendiri dalam menghadapi kondisi yang dialami. Perawat dapat memfasilitasi edukasi kepada keluarga agar mampu memberikan respons yang tepat, seperti mendengarkan tanpa menghakimi dan menghindari pemaksaan untuk segera “melupakan” trauma. Pendekatan yang konsisten dan berkesinambungan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi proses pemulihan.

Evaluasi keperawatan dilakukan dengan melihat perubahan yang dirasakan dan ditunjukkan oleh klien setelah intervensi diberikan. Keberhasilan tindakan dapat terlihat dari berkurangnya tingkat kecemasan, klien mulai mampu mengendalikan respons emosional, serta berkurangnya frekuensi munculnya ingatan traumatis atau mimpi buruk. Selain itu, perbaikan pola tidur, meningkatnya kemampuan konsentrasi, serta keterlibatan kembali dalam aktivitas sehari-hari menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan kondisi klien. Klien juga diharapkan menunjukkan kemampuan koping yang lebih adaptif dan mampu mengungkapkan perasaan secara lebih terbuka. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan klien dan memberikan dampak yang bermakna dalam proses pemulihan (Merians, A. N., 2023)

F. Asuhan Keperawatan Pada Gangguan Kepribadian

1. Konsep Dasar Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian merupakan suatu kondisi gangguan mental yang ditandai dengan pola pengalaman batin dan perilaku yang menetap serta menyimpang dari nilai dan norma budaya yang berlaku pada individu. Pola tersebut tidak hanya bersifat sementara, tetapi menetap, kaku, dan menyeluruh, sehingga memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu (American Psychiatric Association, 2013).

Dalam praktik keperawatan jiwa, gangguan kepribadian dapat dikenali melalui adanya perubahan dalam cara individu memandang diri sendiri dan orang lain (*kognisi*), ketidakstabilan atau ketidaksesuaian respon emosional (*afek*), kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal, serta lemahnya kontrol terhadap impuls. Pola-pola tersebut umumnya mulai tampak sejak masa remaja atau dewasa awal dan cenderung menetap sepanjang kehidupan apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Kondisi ini sering kali menimbulkan distress yang bermakna bagi individu maupun lingkungan sekitarnya, serta dapat mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan peran individu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai gangguan kepribadian sangat penting bagi perawat jiwa dalam melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, serta merencanakan intervensi yang tepat dan berkesinambungan.

Tanda dan gejala gangguan kepribadian umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang perlahan dan menjadi bagian dari pola hidup seseorang. Individu sering menunjukkan cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan orang, misalnya memandang diri sendiri atau orang lain secara kurang realistis, cenderung curiga, atau menilai situasi dengan cara yang kurang tepat. Pola pikir seperti ini kemudian memengaruhi bagaimana individu memahami pengalaman hidupnya dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar (Zimmerman, 2024). Dari sisi emosional, individu dengan gangguan kepribadian kerap mengalami kesulitan dalam mengelola perasaan. Emosi yang muncul bisa terasa sangat intens, mudah berubah, atau justru tampak datar dan sulit diekspresikan. Dalam beberapa situasi, respons emosional yang muncul tidak selalu sesuai dengan kondisi yang dihadapi, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan interpersonal. Hubungan dengan orang lain juga sering menjadi tantangan. Sebagian individu cenderung menarik diri dan menghindari interaksi sosial, sementara yang lain justru menunjukkan ketergantungan yang tinggi atau terlibat dalam hubungan yang penuh konflik. Pola hubungan yang kurang stabil ini tidak jarang menimbulkan ketegangan, baik

bagi individu itu sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya (Fadilah et al., 2024)

Gangguan kepribadian berkembang melalui proses yang panjang dan melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Dari sisi biologis, terdapat keterlibatan fungsi otak, khususnya pada area yang mengatur emosi dan kontrol impuls, serta ketidakseimbangan neurotransmitter yang memengaruhi stabilitas emosi dan perilaku. Pengalaman masa kanak-kanak juga berperan penting dalam membentuk dasar kepribadian. Pola asuh yang kurang konsisten, pengalaman trauma, atau hubungan yang tidak aman dapat memengaruhi cara individu memandang diri sendiri dan orang lain. Seiring waktu, hal ini berkembang menjadi pola pikir dan perilaku yang kurang adaptif. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak mendukung dan paparan stres berkepanjangan dapat memperkuat pola perilaku yang kaku. Individu kemudian cenderung menggunakan mekanisme koping yang kurang efektif, sehingga kesulitan dalam mengelola emosi dan menjalin hubungan interpersonal. Kondisi ini akhirnya menetap dan membentuk pola kepribadian yang maladaptif (Day & Grenyer, 2025).

2. Penatalaksanaan Gangguan Kepribadian

Penatalaksanaan gangguan kepribadian pada dasarnya bertujuan membantu individu memahami dirinya secara lebih utuh, termasuk cara berpikir, merasakan, dan berperilaku yang selama ini terbentuk. Proses ini tidak instan, melainkan membutuhkan waktu, kesabaran, dan pendekatan yang konsisten agar individu dapat mengembangkan cara-cara yang lebih sehat dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Pendekatan utama yang digunakan adalah psikoterapi. Melalui terapi seperti *cognitive behavioral therapy* (CBT), individu diajak untuk mengenali pola pikir yang kurang membantu dan belajar menggantinya dengan cara pandang yang lebih realistis. Sementara itu, *dialectical behavior therapy* (DBT) membantu individu dalam mengelola emosi yang intens, mengurangi perilaku impulsif, serta meningkatkan kemampuan mengendalikan diri dalam situasi yang menekan (Santi Puspitasari, Cucu Rokayah, 2025). Dalam praktik keperawatan jiwa, perawat memiliki peran penting dalam mendampingi klien mengembangkan keterampilan koping yang lebih adaptif. Klien dibantu untuk belajar mengenali stres, mengekspresikan perasaan secara lebih sehat, serta membangun hubungan interpersonal yang lebih stabil. Pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat banyak individu dengan gangguan kepribadian mengalami kesulitan dalam menjalin relasi yang sehat. Selain terapi psikologis, pemberian obat dapat dipertimbangkan sebagai terapi pendukung, terutama untuk mengatasi gejala tertentu seperti kecemasan, depresi, atau ketidakstabilan

emosi. Meskipun demikian, farmakoterapi bukanlah terapi utama, melainkan pelengkap yang membantu individu lebih siap mengikuti proses terapi (Fadilah et al., 2024). Secara keseluruhan, penatalaksanaan gangguan kepribadian memerlukan kerja sama yang baik antara klien, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitar. Dengan hubungan terapeutik yang hangat dan dukungan yang berkelanjutan, individu memiliki kesempatan untuk berkembang, membangun pola hidup yang lebih sehat, dan meningkatkan kualitas hidupnya secara bertahap.

3. Asuhan Keperawatan Pada Gangguan Kepribadian.

Pengkajian pada klien dengan gangguan kepribadian bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi lebih kepada upaya memahami individu secara menyeluruh. Perawat perlu melihat klien sebagai pribadi yang memiliki pengalaman hidup unik, yang membentuk cara berpikir, merasakan, dan berperilaku hingga saat ini. Langkah awal biasanya dimulai dengan menelusuri riwayat kehidupan klien, termasuk pengalaman masa kecil, pola hubungan dalam keluarga, serta peristiwa penting yang mungkin meninggalkan kesan mendalam. Pengalaman-pengalaman tersebut sering kali menjadi dasar terbentuknya pola kepribadian yang menetap. Selanjutnya, perawat mengamati bagaimana klien memandang dirinya sendiri dan orang lain. Tidak jarang, klien menunjukkan cara berpikir yang cenderung kaku, kurang realistis, atau dipenuhi kecurigaan. Cara pandang ini dapat memengaruhi bagaimana klien mengambil keputusan dan merespons situasi di sekitarnya. Dari sisi emosional, penting untuk memahami bagaimana klien mengenali dan mengekspresikan perasaannya. Ada klien yang emosinya mudah berubah dan terasa sangat intens, namun ada pula yang tampak datar atau kesulitan mengungkapkan apa yang dirasakannya. Kondisi ini sering menjadi sumber kesulitan dalam hubungan sosial. Hubungan interpersonal juga menjadi bagian penting dalam pengkajian. Perawat perlu melihat bagaimana klien menjalin hubungan dengan orang lain apakah cenderung menghindari, bergantung, atau sering terlibat dalam konflik. Pola hubungan ini biasanya berulang dan menjadi ciri khas dalam kehidupan klien. Selain itu, perilaku sehari-hari klien juga perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan kontrol diri. Beberapa klien mungkin menunjukkan kecenderungan bertindak impulsif atau kesulitan menahan dorongan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada dirinya sendiri maupun orang lain.

Pada klien dengan gangguan kepribadian, diagnosa keperawatan yang muncul umumnya berkaitan dengan pola emosi, hubungan interpersonal, serta kemampuan individu dalam mengontrol perilaku. Diagnosa ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berkembang dari pola kepribadian yang

menetap. Salah satu diagnosa yang sering ditemukan adalah gangguan interaksi sosial. Klien kerap mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, baik karena kecenderungan menarik diri, kecurigaan berlebihan, maupun pola hubungan yang tidak stabil. Kondisi ini membuat individu sulit menjalin kedekatan emosional dengan orang lain dan sering mengalami konflik dalam hubungan interpersonal. Selain itu, koping individu tidak efektif juga menjadi masalah yang umum. Klien sering menggunakan cara-cara yang kurang adaptif dalam menghadapi stres, seperti menghindar, menyangkal, atau melampiaskan emosi secara tidak tepat. Pola koping ini biasanya telah terbentuk sejak lama dan sulit diubah tanpa pendampingan yang berkelanjutan. Diagnosa lain yang sering muncul adalah harga diri rendah kronis, terutama pada individu yang memiliki pengalaman penolakan atau trauma di masa lalu. Klien mungkin merasa tidak berharga, tidak percaya diri, atau memiliki gambaran diri yang negatif, yang kemudian memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada beberapa kasus, terutama pada gangguan kepribadian tipe tertentu, dapat ditemukan risiko perilaku kekerasan atau perilaku impulsif. Klien mungkin kesulitan mengendalikan dorongan, sehingga berpotensi melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, ketidakstabilan emosi juga sering menjadi fokus perhatian dalam diagnosa keperawatan. Perubahan emosi yang cepat, intens, dan tidak sesuai situasi dapat mengganggu fungsi sehari-hari serta memperburuk hubungan sosial klien (Kadarisma et al., 2024)

Intervensi keperawatan pada klien dengan gangguan kepribadian berfokus pada pendampingan yang konsisten dan penuh empati. Perawat perlu membangun hubungan yang hangat agar klien merasa aman dan mau terbuka. Dari sini, klien dibantu untuk lebih mengenali diri sendiri, termasuk memahami emosi, pola pikir, dan perilaku yang sering muncul dalam kehidupannya. Selanjutnya, klien dilatih mengelola emosi dan mengembangkan cara menghadapi stres yang lebih sehat, seperti teknik relaksasi atau komunikasi yang lebih terbuka. Perawat juga membantu klien belajar menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain, mengurangi konflik, serta meningkatkan keterampilan sosial (Videbeck, 2020). Edukasi kepada klien dan keluarga menjadi bagian penting, agar mereka memahami kondisi yang dialami dan dapat memberikan dukungan yang tepat. Bila diperlukan, perawat juga bekerja sama dengan tim medis dalam pemberian terapi obat untuk membantu mengurangi gejala tertentu.

Evaluasi dilakukan dengan melihat perubahan yang terjadi pada klien. Klien mulai mampu mengenali emosinya, mengontrol respons dengan lebih baik, serta

menunjukkan perbaikan dalam hubungan dengan orang lain. Selain itu, klien juga mulai menggunakan cara-cara yang lebih adaptif dalam menghadapi masalah.

G. Asuhan Keperawatan Penyalahgunaan Zat

1. Konsep Dasar Penyalahgunaan Zat

Penyalahgunaan zat dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang menggunakan zat bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan yang sulit dikendalikan, meskipun ia menyadari dampak buruknya. Penggunaan ini perlahan memengaruhi cara berpikir, emosi, dan perilaku, hingga akhirnya mengganggu kesehatan, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan (Grant et al., 2017).

Penyalahgunaan zat melibatkan berbagai jenis bahan yang dapat memengaruhi kerja otak dan perilaku seseorang. Ada zat yang membuat tubuh terasa lebih tenang seperti alkohol dan obat penenang, ada yang justru meningkatkan energi dan kewaspadaan seperti amfetamin dan nikotin, serta ada pula yang mengubah persepsi hingga seseorang melihat atau merasakan sesuatu yang tidak nyata, seperti pada penggunaan halusinogen. Di sisi lain, obat golongan opioid sering digunakan untuk mengurangi nyeri, tetapi dapat menimbulkan rasa nyaman berlebihan yang membuat seseorang ingin menggunakannya kembali. Sementara itu, zat inhalan yang mudah ditemukan di lingkungan sehari-hari juga kerap disalahgunakan, terutama karena aksesnya yang mudah, meskipun risikonya sangat berbahaya bagi otak dan tubuh. Walaupun efek tiap zat berbeda, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu berpotensi menimbulkan ketergantungan dan secara perlahan mengganggu kesehatan, emosi, serta kehidupan sosial individu jika digunakan secara tidak tepat (American Psychiatric Association, 2022)

Perubahan pada klien yang mengalami penyalahgunaan zat biasanya terlihat secara bertahap, dimulai dari hal-hal kecil hingga akhirnya memengaruhi banyak aspek kehidupan. Dari segi fisik, tubuh sering memberi sinyal melalui pola tidur yang tidak teratur, nafsu makan yang berubah, serta kondisi seperti mata merah, gemetar, atau tubuh yang mudah berkeringat. Pada kondisi tertentu, terutama saat tubuh mulai "kehilangan" zat yang biasa digunakan, klien dapat tampak sangat gelisah, mual, bahkan mengalami kejang. Secara emosional, klien sering tampak berbeda dari biasanya. Mereka bisa menjadi lebih mudah tersinggung, cemas, atau merasa sedih berkepanjangan. Konsentrasi pun menurun, sehingga sulit fokus atau mengambil keputusan dengan baik. Pada beberapa kasus, persepsi terhadap realitas juga dapat terganggu, misalnya munculnya halusinasi. Perubahan juga terlihat dalam perilaku sehari-hari. Klien

mungkin mulai menjauh dari keluarga, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, atau mengabaikan tanggung jawabnya. Tidak jarang muncul perilaku menutup diri, berbohong, atau melakukan tindakan berisiko demi mempertahankan penggunaan zat. Secara keseluruhan, tanda dan gejala ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan zat tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga memengaruhi emosi, pola pikir, dan hubungan sosial seseorang secara menyeluruh (American Psychiatric Association, 2022).

2. Penatalaksanaan Penyalahgunaan Zat

Penatalaksanaan penyalahgunaan zat dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan bio-psiko-sosial, karena kondisi ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada emosi, perilaku, dan lingkungan sosial individu. Pada tahap awal, fokus utama adalah detoksifikasi, yaitu proses mengeluarkan zat dari dalam tubuh sekaligus mengatasi gejala putus zat (withdrawal). Pada fase ini, klien sering mengalami ketidaknyamanan fisik dan emosional, sehingga membutuhkan pemantauan ketat serta terapi farmakologis sesuai jenis zat yang digunakan, seperti penggunaan metadon untuk opioid atau benzodiazepin untuk mengatasi gejala putus alkohol. Tujuan dari tahap ini adalah menjaga kondisi klien tetap stabil dan mencegah komplikasi yang lebih serius (Varcarolis, 2023). Setelah kondisi fisik lebih stabil, penatalaksanaan dilanjutkan dengan rehabilitasi, yang berfokus pada perubahan perilaku dan pemulihan fungsi kehidupan.

Pendekatan psikososial seperti terapi kognitif perilaku (CBT), terapi motivasional, dan konseling individu maupun kelompok sangat membantu klien dalam memahami pola penggunaan zat serta mengembangkan strategi koping yang lebih adaptif. Pada tahap ini, klien juga dibantu untuk mengenali pemicu (trigger) yang dapat meningkatkan keinginan menggunakan zat kembali. Selain itu, terapi farmakologis jangka panjang dapat diberikan untuk mencegah kekambuhan (relapse). Misalnya, naltrekson digunakan untuk mengurangi keinginan menggunakan opioid atau alkohol, sedangkan disulfiram membantu mencegah konsumsi alkohol dengan menimbulkan efek tidak nyaman jika alkohol dikonsumsi. Terapi ini biasanya dikombinasikan dengan pendekatan psikologis agar hasilnya lebih optimal.

3. Asuhan Keperawatan Pada Penyalahgunaan Zat

Pengkajian pada klien dengan penyalahgunaan zat bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi lebih pada upaya memahami kondisi klien secara utuh. Banyak klien datang dengan perasaan tidak nyaman, seperti malu, takut, atau bahkan belum sepenuhnya menerima kondisi yang dialaminya. Oleh karena itu, perawat perlu membangun hubungan yang hangat, penuh empati, dan tidak menghakimi agar klien merasa aman untuk membuka diri (Townsend, M. C., & Morgan, 2021). Dalam prosesnya, perawat perlu menggali kondisi fisik klien, seperti jenis zat yang digunakan, frekuensi penggunaan, serta dampak yang

sudah dirasakan tubuh. Tidak kalah penting, perubahan pada kondisi emosional juga perlu diperhatikan, misalnya munculnya kecemasan, mudah marah, atau perasaan sedih yang berkepanjangan. Sering kali, penggunaan zat menjadi cara klien untuk menghindari tekanan atau masalah yang sedang dihadapi.

Di sisi lain, kehidupan sosial klien juga sering mengalami perubahan. Hubungan dengan keluarga dapat menjadi renggang, aktivitas sehari-hari terganggu, bahkan peran dalam pekerjaan atau lingkungan tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Perawat juga perlu memahami bagaimana klien memandang hidupnya saat ini, termasuk harapan dan nilai-nilai yang masih dimilikinya sebagai bagian dari proses pemulihan (Varcarolis, 2023)

Dengan melihat klien sebagai individu yang utuh bukan hanya dari masalah zat yang digunakan. Perawat dapat memberikan perawatan yang lebih tepat, bermakna, dan membantu klien secara perlahan menemukan kembali arah hidupnya. Pada klien dengan penyalahgunaan zat, diagnosa keperawatan tidak hanya berfokus pada penggunaan zat, tetapi juga dampaknya terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial. Diagnosa ditentukan berdasarkan respons klien terhadap masalah yang dialaminya. Masalah yang sering muncul antara lain gangguan kontrol impuls, di mana klien sulit menahan keinginan menggunakan zat meskipun mengetahui dampaknya. Selain itu, koping individu tidak efektif juga sering terjadi, karena klien menggunakan zat sebagai cara menghadapi stres atau tekanan emosional. Klien juga berisiko mengalami cedera akibat penurunan kesadaran dan koordinasi saat berada di bawah pengaruh zat. Dari aspek sosial, sering ditemukan isolasi sosial dan harga diri rendah akibat konflik dan perasaan malu atau bersalah. Pendampingan pada klien dengan penyalahgunaan zat berfokus pada membantu mereka pulih secara bertahap, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membangun hubungan yang hangat dan penuh empati, sehingga klien merasa diterima dan lebih terbuka untuk bercerita. Perawat kemudian memantau kondisi fisik klien, terutama untuk melihat adanya gejala putus zat atau perubahan kondisi tubuh. Di saat yang sama, klien diberikan pemahaman tentang dampak penggunaan zat agar mereka mulai menyadari pentingnya perubahan.

Dalam prosesnya, klien juga dibantu menemukan cara yang lebih sehat untuk menghadapi stres, seperti belajar teknik relaksasi atau cara menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat penting agar klien merasa tidak sendirian dalam menjalani proses pemulihan. Perkembangan klien dinilai secara bertahap. Klien mulai menunjukkan pemahaman tentang dampak penggunaan zat dan perlahan mampu mengurangi keinginan untuk menggunakannya kembali. Kondisi fisik menjadi lebih stabil, dan klien mulai mencoba cara-cara baru yang lebih sehat dalam menghadapi masalah.

Selain itu, hubungan dengan orang lain mulai membaik, dan klien menunjukkan tanda-tanda meningkatnya rasa percaya diri serta harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari berhentinya penggunaan zat, tetapi juga dari perubahan kecil yang menunjukkan arah pemulihan yang positif.

H. Penutup

Asuhan keperawatan pada berbagai gangguan jiwa seperti skizofrenia, gangguan mood, ansietas, PTSD, gangguan kepribadian, hingga penyalahgunaan zat pada dasarnya bukan hanya tentang menangani gejala yang tampak. Lebih dari itu, ini adalah proses memahami seseorang secara utuh dengan segala pengalaman, luka, dan harapan yang dimilikinya.

Setiap klien memiliki cerita yang berbeda, sehingga pendekatan yang diberikan pun perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Di sinilah peran perawat menjadi sangat berarti, bukan hanya sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai pendamping yang hadir, mendengarkan, dan memberikan rasa aman tanpa menghakimi.

Pendekatan yang menyeluruh, yang memperhatikan kondisi fisik, emosional, hubungan sosial, hingga nilai-nilai kehidupan klien, menjadi kunci dalam proses pemulihan. Dukungan dari keluarga serta kerja sama dengan tim kesehatan juga sangat membantu agar klien dapat menjalani proses ini dengan lebih kuat dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, asuhan keperawatan jiwa adalah tentang membantu seseorang menemukan kembali harapan dalam hidupnya. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah bagian dari proses yang berarti, dan dengan dukungan yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Referensi

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. <https://doi.org/https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders ((5th ed.,).
- Bandelow, B., & Michaelis, S. (2022). Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. 5969. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2015.17.3/bbandelow>
- Bhattacharya, S., Goicoechea, C., Heshmati, S., Carpenter, J. K., & Hofmann, S. G. (2023). Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety - Related Disorders: A Meta - Analysis of Recent Literature. *Current Psychiatry Reports*, 25(1), 19–30. <https://doi.org/10.1007/s11920-022-01402-8>
- Brooks, S. K., & Greenberg, N. (2024). Recurrence of post-traumatic stress disorder: systematic review of definitions, prevalence and predictors. *BMC Psychiatry*, 1–37. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-05460-x>
- Coryell, W. (2025). Gangguan bipolar. MSD Manual.
- Cyntia Arum et al. (2026). Dampak Terapi Lithium Terhadap Perkembangan Neurokognitif Remaja Dengan Gangguan Bipolar: Suatu Tinjauan Sistematis. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(p-ISSN 2774-5147; e-ISSN 2774-5155).
- Davis, L. L., & Hamner, M. B. (2024). Post-traumatic stress disorder: the role of the amygdala and potential therapeutic interventions – a review. *Frontiers in Psyciatric*, June, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1356563>
- Day, A. G. N. J. S., & Grenyer, C. M. H. B. F. S. (2025). Gender bias in assessing narcissistic personality: Exploring the utility of the ICD- - 11 dimensional model. August 2024, 248–264. <https://doi.org/10.1111/bjc.12503>
- Ernstmeyer, K., & Christman, E. (Eds. (2022). *Nursing: Mental health and community concepts*. Open RN.
- Fadilah, R., Zahara, D., Febriani, M., & Murni, S. N. (2024). 2024 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Gangguan Kepribadian 2024 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(12), 734–739.
- Fagan, H. A., Baldwin, D. S., Fagan, H. A., Baldwin, D. S., & Treatment, P. (2023). Expert Review of Neurotherapeutics Pharmacological Treatment of Generalised Anxiety Disorder: Current Practice and Future Directions Pharmacological Treatment of Generalised Anxiety Disorder: Current Practice and. Expert Review of

- Fortinash, K. M., & Worret, P. A. H. (2014). *Psychiatric mental health nursing* ((5th ed)). Mosby Elsevier.
- Grant, J. E., Chamberlain, S. R., & Ph, D. (2017). Europe PMC Funders Group Expanding the Definition of Addiction: DSM-5 vs. ICD-11. 21(4), 300–303. <https://doi.org/10.1017/S1092852916000183>.Expanding
- Jowf, G. I. Al, Ahmed, Z. T., Reijnders, R. A., Nijs, L. De, & Eijssen, L. M. T. (2023). To Predict, Prevent, and Manage Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD): A Review of Pathophysiology, Treatment , and Biomarkers. *Jurnal International Molecular Sains*. <https://doi.org/10.3390/%0Aijms24065238>
- Kadarisma, S., Inna, B., Hardyningrat, D., Kirana, D. C., Nugraha, N., Yahya, N. A., Dinda, S., Islahi, N., Nurhaliza, S., Justin, L., Elizar, A., Studi, P., Dokter, P., Kedokteran, F., & Mataram, U. (2024). Gangguan kepribadian tipe c. 5, 11936–11948.
- Lawrence D, Rikkers W, Bartlett J, et al. (2024). Development of the post-traumatic stress disorder assessment scale for emergency services. *Arch Environ Occup Health*, 79(7-8), :235-246. <https://doi.org/10.1080/19338244.2024.2430968>
- Mangolini, V. I., & Andrade, L. H. (2019). Treatment of anxiety disorders in clinical practice. *Clinic*, 74,e1316.
- Merians, A. N., et al. (2023). (2023). Post-traumatic stress disorder. *Medical Clinics of North America*, 107(1), 85–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mcna.2022.04.003>
- Merians, A. N., Spiller, T., Harpaz-rotem, I., Krystal, J. H., & Pietrzak, R. H. (2023). *P o s t - t r a u m a t i c S t r e s s D i s o r d e r*. Elsevier, 107, 7125. <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2022.04.003>
- Mishelle, W., Drinkwater, R., Kelson, J., & Ashad, M. (2025). International Journal of Medical Informatics Self-guided virtual reality therapy for anxiety: A systematic review. *International Journal of Medical Informatics*, 200(January), 105902. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2025.105902>
- Nasution, H. N., & Firdausi, H. (2020). Pendekatan diagnosis dan tatalaksana gangguan mood pada usia lanjut. *Jurnal Kedokteran*.
- Nurhayati, N., Alfara, W., Suratmin, R., Simeulu, P., & Taufik, T. (2024). Nursing Caring Behavior Based on Jean Watson' s Theory is Related to Anxiety Levels in Pre-Operative Patients Perilaku Caring Perawat Berdasarkan Teori Jean Watson

- berhubungan dengan Tingkat Ansietas Pada Pasien Pra Operasi. 3(November), 132–139. <https://doi.org/10.58774/jourkep.v3i2.65>
- PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik (I Cetakan). PPNI.
- Rappoport, A. (2024). A Dynorphin Theory of Depression and Bipolar Disorder. 1–31.
- Ridho, M., Eljatin, A., & Lubis, N. H. (2024). Penatalaksanaan Gangguan Afektif Bipolar Episode Kini Depresif Berat tanpa Gejala Psikotik melalui Pendekatan Kedokteran Keluarga. 3(1), 13–19. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v3i1.3085>
- Samsugito, I., Nopriyanto, D., & Riyani, S. (2024). Case Study: Nursing Care For Anxiety In Psychosomatic Patients With Complaints Of Palpitations And Chest Pain Using A Hypnotherapy Approach. *Mulawarman Nursing Indonesia Journal*, 02(01), 8–16.
- Santi Puspitasari, Cucu Rokayah, W. R. N. (2025). PENGARUH DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY PADA PERILAKU AGRESIF: TINJAUAN SISTEMATIS DENGAN NARATIVE REVIEW. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 7(April), 759–766. <https://doi.org/http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>
- Schincariol, A., Orrù, G., & Otgaar, H. (2024). Posttraumatic stress disorder (PTSD) prevalence: an umbrella review. *Psychological Medicine*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0033291724002319>
- Schnurr, et al. (2024). The Management of Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder: Synopsis of the 2023. *Ann Intern Med.*, 177(3), 363–374. <https://doi.org/doi:10.7326/M23-2757>
- Sekhon, S., & Gupta, V. (2023). Mood disorder. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/>
- Setyowati, H., Frijanto, A., & Agustina, C. F. (2024). Gangguan depresif berulang dengan gejala psikotik. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(8), 755–764.
- Stahl, S. M. (2021). *Stahl's essential psychopharmacology: Neuroscientific basis and practical applications*. Cambridge University Press.
- Stuart, G. (2016). *Principles and practice of psychiatric nursing* (B. A. Keliat & J. Pasaribu (eds.); 10th ed). Elsevier.
- Stuart, G. W. (2012). *Principles and practice of psychiatric nursing*. Elsevier.
- Teodorescu, D., Cheng, T., Fyshe, A., & Mohammad, S. M. (2021). *Language and Mental Health*:
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2021). *Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice*. F.A. Davis.

- Varcarolis. (2023). *Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: A Communication Approach to Evidence-Based Care* (4th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Videbeck. (2020). Psychiatric-mental health nursing. In *Nursing Clinics of North America* (Eight Edit). Wolters Kluwer. <https://doi.org/10.3928/0279-3695-19870801-16>
- Zhou, E. (2024). Investigating the Generalizability of Physiological Characteristics of Anxiety.
- Zimmerman, M. (2024). Personality disorders overview. MSD Manual.

BAB V

INTERVENSI KEPERAWATAN PSIKOSOSIAL BERBASIS BUKTI (PSIKOEDUKASI, CBT DASAR, TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK, MANAJEMEN STRES, RELAKSASI, DAN COPING SKILLS)

A. Pendahuluan

Kesehatan jiwa kini bukan lagi sekadar isu di ruang praktik psikiatri, melainkan bagian tak terpisahkan dari kualitas hidup kita sehari-hari. Dalam perjalanan hidup manusia yang dinamis, setiap individu pasti akan bersinggungan dengan berbagai tantangan psikologis dan sosial yang mampu menggoyahkan keseimbangan mentalnya. Di sinilah peran keperawatan jiwa hadir, bukan hanya untuk mengobati gejala, tetapi untuk merangkul sisi kemanusiaan pasien agar mereka mampu kembali berdaya di tengah masyarakat. Keperawatan jiwa kontemporer telah bergeser dari sekadar model medis menuju pendekatan psikososial yang lebih holistik, di mana pemulihan dipandang sebagai sebuah perjalanan panjang yang melibatkan pikiran, perasaan, dan interaksi sosial.

Tantangan kesehatan mental di era globalisasi saat ini semakin kompleks, mulai dari meningkatnya angka kecemasan di kalangan remaja hingga isolasi sosial pada kelompok lansia. Data terbaru menunjukkan bahwa intervensi non-farmakologi atau terapi psikososial memegang peranan krusial dalam mempercepat masa penyembuhan dan mencegah kekambuhan. Perawat jiwa, sebagai garda terdepan, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan asuhan klinis yang tidak hanya berdasarkan empati, tetapi juga harus berlandaskan pada bukti ilmiah yang kuat atau *Evidence-Based Practice* (EBP). Melalui asuhan yang terukur, setiap tindakan yang diberikan kepada pasien memiliki dasar yang tervalidasi secara klinis untuk memberikan hasil terbaik (Townsend & Morgan, 2017).

Intervensi psikososial berbasis bukti, seperti psikoedukasi, terapi kognitif perilaku, hingga manajemen stres, merupakan perangkat utama yang membantu pasien membangun ketahanan mental. Pendekatan ini percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk bangkit kembali jika diberikan dukungan yang tepat pada waktu yang tepat. Sejalan dengan perkembangan ilmu keperawatan, penting bagi kita untuk menyelaraskan teknik komunikasi dan terapi dengan tahap

perkembangan manusia, mulai dari masa anak-anak hingga usia senja. Hal ini selaras dengan pandangan para ahli bahwa kesehatan mental yang optimal adalah hasil dari harmonisasi antara mekanisme koping yang sehat dengan lingkungan sosial yang mendukung (Stuart, 2014).

B. Pentingnya Intervensi Psikososial Berbasis Bukti dalam Keperawatan

Dalam dunia kesehatan yang terus berkembang, istilah *Evidence-Based Practice* atau praktik berbasis bukti menjadi standar yang mutlak. Secara operasional, hal ini merupakan komitmen profesional untuk memberikan perawatan yang tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau intuisi semata, melainkan berpijak pada hasil penelitian yang telah terbukti efektivitasnya secara ilmiah. Intervensi psikososial berbasis bukti memastikan bahwa setiap percakapan terapeutik, sesi terapi kelompok, maupun teknik relaksasi yang diberikan kepada pasien memiliki landasan kuat untuk memicu pemulihan. Pendekatan ini memberikan rasa aman dan kepastian hukum, baik bagi tenaga kesehatan yang memberikan tindakan maupun bagi pasien yang menerimanya.

Penerapan intervensi berbasis bukti dalam ranah psikososial menjadi sangat krusial karena setiap individu memiliki keunikan dalam merespons stresor kehidupan. Dengan menggunakan teknik yang sudah tervalidasi, perawat dapat lebih spesifik dalam menentukan tindakan yang paling relevan untuk masalah tertentu. Sebagai contoh, penggunaan Terapi Kognitif Perilaku atau *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) telah terbukti secara luas mampu menurunkan tingkat depresi dan kecemasan secara lebih signifikan dibandingkan hanya melalui pendekatan suportif biasa. Standar praktik yang tervalidasi ini membantu meminimalkan risiko tindakan yang tidak efektif dan memastikan bahwa setiap asuhan diarahkan untuk memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan mental pasien (Halter & Varcarolis, 2014).

Selain efektivitas klinis, penggunaan intervensi berbasis bukti juga berperan besar dalam membangun kepercayaan pasien terhadap proses penyembuhan. Ketika terdapat penjelasan bahwa langkah-langkah yang dijalani, seperti latihan keterampilan koping atau psikoedukasi adalah metode yang diakui secara global, pasien cenderung menjadi lebih kooperatif dan optimis. Di sisi lain, bagi tenaga profesional, pendekatan ini mendorong terciptanya budaya belajar yang berkelanjutan. Tenaga keperawatan ditantang untuk selalu memperbarui pengetahuan agar asuhan yang diberikan tetap selaras dengan temuan-temuan ilmiah terbaru di bidang neurosains dan perilaku manusia (Videbeck & Miller, 2023).

Pada akhirnya, mengintegrasikan bukti ilmiah ke dalam praktik keperawatan psikososial adalah perwujudan nyata dari profesionalisme dan empati. Fokus utama

bukan sekadar memberikan kenyamanan sesaat, melainkan membekali pasien dengan alat yang teruji untuk bertahan dan bangkit kembali dalam jangka panjang. Dengan merujuk pada standar asuhan yang diakui secara internasional, profesi keperawatan jiwa dapat memberikan kontribusi yang lebih terukur dan bermakna dalam sistem kesehatan secara menyeluruh.

C. Konsep Psikoedukasi untuk Memberdayakan Pasien dan Keluarga

Psikoedukasi adalah cara cerdas untuk mengubah rasa takut menjadi kekuatan melalui pengetahuan. Sering kali, kecemasan muncul karena seseorang tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi pada pikiran atau perilakunya sendiri. Berbeda dengan penyuluhan kesehatan biasa, psikoedukasi hadir sebagai ruang diskusi yang terstruktur untuk memberikan gambaran jelas mengenai kondisi kesehatan mental dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tujuannya sederhana yaitu agar pasien dan keluarga tidak lagi merasa bingung, melainkan memiliki kendali penuh atas proses pemulihan. Pengetahuan yang baik terbukti mampu membuat seseorang lebih disiplin dalam menjalani pengobatan dan jauh lebih tangguh saat menghadapi masa-masa sulit (Halter & Varcarolis, 2014).

Keluarga sering kali menjadi garda terdepan sekaligus pihak yang paling merasakan dampak emosional saat ada anggota keluarga yang mengalami masalah kejiwaan. Melalui psikoedukasi, keluarga diajak untuk memahami bahwa perubahan perilaku pasien adalah bagian dari dinamika gangguan kesehatan, bukan sesuatu yang sengaja dilakukan untuk memancing kemarahan atau konflik. Dengan terciptanya suasana rumah yang lebih tenang dan penuh pengertian, pasien akan merasa lebih aman untuk berproses. Dukungan keluarga yang positif seperti ini secara klinis terbukti mampu mencegah kambuhnya gejala dan mempercepat kembalinya pasien ke aktivitas normal sehari-hari (Stanhope & Lancaster, 2020).

Dalam praktiknya, metode ini bukanlah ceramah satu arah yang membosankan, melainkan sebuah dialog untuk mencari solusi bersama. Tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator yang membantu menjelaskan hal-hal teknis, seperti cara kerja obat atau strategi menciptakan lingkungan rumah yang nyaman, ke dalam istilah sederhana sehari-hari. Kejujuran dan keterbukaan informasi menjadi kunci utama untuk meruntuhkan rasa malu atau stigma yang selama ini melekat pada masalah kesehatan jiwa. Dengan edukasi yang tepat, pasien tidak lagi dipandang sebagai objek pengobatan, melainkan rekan kerja yang hebat dalam mengelola perjalanan menuju kesembuhannya sendiri (Townsend & Morgan, 2017).

Melalui langkah-langkah psikoedukasi yang konsisten, proses pemulihan tidak hanya berhenti pada hilangnya keluhan, tetapi berlanjut pada kembalinya kepercayaan diri untuk bergaul kembali di masyarakat. Pengetahuan yang

ditanamkan menjadi fondasi yang stabil agar pasien bisa menjalani kehidupan yang bermakna tanpa harus merasa rendah diri. Sebagai bagian dari metode yang teruji secara ilmiah, psikoedukasi tetap menjadi salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan mental dalam jangka panjang, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang-orang tercinta di sekelilingnya.

D. Prinsip Dasar Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dalam Mengubah Pola Pikir

Terapi Kognitif Perilaku, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), sering kali disebut sebagai "peta jalan" untuk memahami hubungan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasakan. Prinsip utamanya sangat sederhana namun kuat: emosi seseorang bukan disebabkan oleh apa yang terjadi padanya, melainkan oleh cara orang tersebut memandang kejadian itu. Bayangkan pikiran sebagai kacamata, jika kacamata yang digunakan berwarna gelap, maka dunia akan terlihat suram. Melalui pendekatan ini, individu diajak untuk mengenali bahwa pikiran-pikiran negatif yang sering muncul secara otomatis sebenarnya bisa diubah agar perasaan dan tindakan menjadi lebih positif dan sehat (Halter & Varcarolis, 2014).

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang terperangkap dalam pikirannya sendiri, seperti terlalu cepat mengambil kesimpulan buruk atau selalu menyalahkan diri sendiri. Hal ini sering kali menjadi beban mental yang berat. Dalam proses terapi, langkah awal yang dilakukan adalah melatih kepekaan untuk menangkap pikiran-pikiran negatif tersebut tepat saat mereka muncul. Tujuannya bukan untuk memaksakan diri agar selalu berpikiran positif secara berlebihan, melainkan untuk belajar bersikap objektif dan melihat masalah berdasarkan fakta yang ada, bukan berdasarkan ketakutan semata (Beck, 2011).

Metode ini sangat populer karena menekankan pada kerja sama yang aktif. Pasien tidak hanya duduk diam mendengarkan penjelasan, tetapi dibekali dengan berbagai latihan praktis yang bisa dicoba langsung di rumah. Misalnya, belajar cara menantang pikiran yang membuat cemas atau mencoba melakukan aktivitas baru yang selama ini dihindari karena rasa takut. Karena fokusnya adalah pada penyelesaian masalah yang dihadapi saat ini, hasil dari terapi ini biasanya bisa dirasakan dengan lebih cepat. Latihan yang terus-menerus akan membantu membangun "otot mental" yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan (Wheeler, 2022).

Hal yang paling menarik dari metode ini adalah kemampuannya untuk mengubah seseorang menjadi "pendamping" bagi dirinya sendiri. Setelah memahami rahasia di balik cara kerja pikiran, seseorang akan memiliki kemampuan alami untuk mendeteksi rasa cemas atau sedih lebih awal dan tahu cara

mengatasinya secara mandiri. Itulah sebabnya pendekatan ini dianggap sebagai standar emas dalam perawatan kesehatan jiwa, bukan hanya membantu meredakan masalah yang ada sekarang, tetapi juga membekali setiap orang dengan keterampilan untuk tetap tangguh dalam jangka panjang.

E. Membangun Kemandirian melalui Terapi Aktivitas Kelompok (TAK)

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tumbuh dan pulih melalui interaksi dengan sesamanya. Dalam pelayanan kesehatan jiwa, Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) menjadi sebuah ruang simulasi sosial yang aman bagi individu untuk belajar kembali cara berinteraksi, berbagi perasaan, dan memecahkan masalah bersama. Melalui kelompok ini, rasa terasing yang sering menyertai masalah kesehatan jiwa dapat perlahan terkikis. Fokus utamanya bukan sekadar mengisi waktu luang, melainkan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri. Di dalam kelompok, setiap anggota memiliki kesempatan untuk saling memberi dukungan, yang memberikan perasaan berharga bahwa setiap individu memiliki peran penting bagi orang lain (Tukatman dkk., 2023).

TAK bekerja dengan cara memberikan struktur pada kegiatan harian yang mungkin sebelumnya terasa kurang teratur. Terdapat berbagai jenis kelompok yang bisa diikuti, mulai dari kelompok yang melatih pengenalan realitas hingga kelompok yang mengasah keterampilan sosialisasi. Melalui bimbingan tenaga profesional sebagai fasilitator, individu diajak untuk berlatih berkomunikasi secara jujur, mendengarkan orang lain, dan memberikan pendapat yang membangun. Proses ini sangat efektif untuk melatih kembali fungsi berpikir dan kemampuan gerak yang mungkin sempat menurun. Keberhasilan kecil yang dirasakan saat berhasil menyelesaikan tugas bersama anggota lain menjadi modal besar bagi individu untuk kembali berdaya di lingkungan masyarakat (Pongdatu dkk., 2023).

Salah satu kekuatan unik dari terapi kelompok adalah adanya kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain secara langsung atau yang sering disebut sebagai pembelajaran interpersonal. Anggota kelompok dapat melihat bagaimana peserta lain menghadapi masalah serupa dan mencoba menerapkan strategi tersebut dalam hidup sendiri. Suasana yang hangat dan jauh dari kesan menghakimi membuat individu merasa lebih berani untuk mengeksplorasi potensi diri yang selama ini terpendam. Pengalaman positif yang didapatkan selama sesi kelompok ini menjadi bekal mental yang kuat untuk menghadapi berbagai situasi sosial di dunia luar yang terkadang penuh tantangan (Pangestu & Widodo, 2017).

Pada akhirnya, kemandirian yang terbentuk melalui terapi kelompok ini bersifat jangka panjang. Individu tidak hanya terbantu secara emosional, tetapi juga

memiliki keterampilan baru untuk menjalin hubungan sosial yang lebih sehat. Kemampuan untuk bekerja sama, menghargai perbedaan pendapat, dan mengelola emosi dalam lingkungan kelompok adalah kompetensi dasar yang sangat dibutuhkan untuk kembali hidup produktif. Sebagai bagian dari metode yang teruji secara ilmiah, terapi aktivitas kelompok terus terbukti menjadi salah satu cara paling manusiawi dalam mempercepat proses pemulihan bagi siapa saja yang sedang berjuang menata kembali hidupnya.

F. Tahapan Pelaksanaan Terapi Kelompok yang Efektif di Lapangan

Menjalankan sesi terapi kelompok bukan sekadar mengumpulkan orang dalam satu ruangan, melainkan sebuah seni mengelola dinamika manusia agar tercipta perubahan yang positif. Agar intervensi ini memberikan hasil maksimal, terdapat tahapan terstruktur yang harus dilalui dengan cermat. Semuanya dimulai dari fase persiapan, di mana pemilihan anggota kelompok dilakukan berdasarkan kebutuhan yang serupa, misalnya kelompok khusus untuk melatih sosialisasi atau kelompok untuk mengelola kecemasan. Perencanaan yang matang mengenai waktu, tempat, dan topik pembicaraan menjadi fondasi utama agar sesi berjalan lancar dan tujuan kemandirian individu dapat tercapai secara efektif (Luthfiyasha dkk., 2025).

Setelah persiapan selesai, sesi memasuki fase orientasi. Pada tahap awal ini, suasana yang hangat dan penuh penerimaan sangat penting untuk dibangun agar setiap anggota merasa aman untuk mulai terbuka. Fasilitator bertugas menjelaskan aturan main, seperti menjaga kerahasiaan cerita teman sekelompok dan pentingnya saling menghargai pendapat. Rasa saling percaya yang terbentuk di fase ini menjadi kunci utama bagi keberhasilan tahap selanjutnya. Tanpa adanya rasa aman, anggota kelompok akan cenderung menarik diri dan ragu untuk berbagi pengalaman yang selama ini dipendam sendiri (Tanan dkk., 2025).

Inti dari perjalanan ini ada pada fase kerja, di mana setiap anggota mulai aktif berinteraksi, berlatih keterampilan baru, dan saling memberikan dukungan. Di sinilah peran perawat sebagai pemandu sangat diuji untuk memastikan diskusi tetap fokus namun tetap memberikan ruang bagi setiap orang untuk berekspresi. Konflik kecil terkadang muncul, namun jika dikelola dengan bijak, hal tersebut justru menjadi sarana belajar yang sangat baik tentang cara menyelesaikan masalah secara sehat. Keberhasilan dalam melewati tantangan di fase kerja ini sering kali menjadi titik balik bagi individu untuk merasa lebih berdaya dan mampu menghadapi realitas sosial di dunia luar (Nabila dkk., 2025).

Perjalanan sesi ditutup dengan fase terminasi, sebuah tahap untuk merangkum semua pembelajaran dan kemajuan yang telah dicapai selama proses kelompok berlangsung. Perpisahan terkadang memicu rasa sedih, namun fase ini justru

menjadi momen penting untuk merayakan kemandirian baru yang telah terbentuk. Fasilitator membantu anggota kelompok untuk memikirkan cara menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penutupan yang bermakna, setiap individu diharapkan melangkah keluar dari kelompok dengan rasa optimis dan kesiapan mental yang lebih matang untuk menjalani peran di tengah masyarakat (Luthfiyasha dkk., 2025).

G. Manajemen Stres melalui Berbagai Teknik Relaksasi Mandiri

Stres merupakan respons alami tubuh saat menghadapi tuntutan atau ancaman, namun jika dibiarkan menumpuk, hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Salah satu cara paling efektif untuk meredakan dampak stres adalah melalui teknik relaksasi mandiri. Teknik ini bekerja dengan cara mengaktifkan respons relaksasi tubuh, yang secara fisiologis akan menurunkan detak jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan. Keunggulan utama dari metode mandiri ini adalah fleksibilitasnya, teknik-teknik ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa memerlukan alat khusus, sehingga individu memiliki kendali penuh atas ketenangan batinnya sendiri (Sujarwo & Puspita, 2025).

Beberapa teknik relaksasi yang sering dipraktikkan dan telah teruji secara klinis meliputi:

1. Relaksasi Napas Dalam

Fokus pada pengaturan pola napas yang lambat dan dalam untuk meningkatkan asupan oksigen ke otak dan menenangkan sistem saraf pusat.

2. Relaksasi Otot Progresif

Teknik yang melibatkan proses menegangkan dan melemaskan kelompok otot tertentu secara berurutan untuk melepaskan ketegangan fisik yang menumpuk akibat kecemasan.

3. Imajinasi Terbimbing (Guided Imagery)

Menggunakan kekuatan pikiran untuk membayangkan tempat atau suasana yang damai dan menyenangkan, sehingga merangsang tubuh untuk merasa lebih rileks dan tenang.

Penerapan teknik relaksasi secara rutin tidak hanya memberikan ketenangan sesaat, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas tidur dan konsentrasi. Saat tubuh berada dalam kondisi rileks, kemampuan otak untuk berpikir jernih dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi akan meningkat secara signifikan. Hal ini menjadikannya bagian tak terpisahkan dari strategi koping yang sehat. Keberhasilan teknik ini sangat bergantung pada konsistensi individu dalam berlatih, sehingga respons tenang tersebut dapat muncul secara otomatis saat menghadapi situasi yang penuh tekanan (Nurchayani & Fauzan, 2016).

Penting bagi setiap individu untuk mengenali teknik relaksasi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pribadinya. Dengan menguasai berbagai metode manajemen stres ini, seseorang tidak lagi merasa tidak berdaya saat menghadapi beban hidup. Sebaliknya, pengetahuan ini menjadi alat pertahanan diri yang kuat untuk menjaga kesehatan jiwa secara berkelanjutan. Integrasi antara kesehatan fisik dan ketenangan pikiran melalui relaksasi adalah langkah nyata menuju hidup yang lebih berkualitas dan seimbang.

H. Pengembangan Strategi Koping Adaptif untuk Menghadapi Masalah

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari tantangan yang menuntut kemampuan untuk beradaptasi. Strategi koping merupakan kumpulan cara, baik secara mental maupun perilaku, yang digunakan seseorang untuk mengelola tuntutan hidup yang dianggap menekan atau melampaui sumber daya yang dimiliki. Penting untuk membedakan antara koping yang bersifat sementara namun merusak, dengan koping adaptif yang membantu penyelesaian masalah secara jangka panjang. Strategi koping adaptif tidak hanya bertujuan untuk meredakan emosi sesaat, tetapi juga untuk membangun ketahanan diri agar individu tetap mampu berfungsi dengan baik meskipun berada di bawah tekanan yang berat (Ananda dkk., 2025).

Secara garis besar, strategi koping yang sehat dibagi menjadi dua pendekatan utama. Pendekatan pertama berfokus pada penyelesaian masalah, di mana individu secara aktif mencari informasi, membuat rencana tindakan, dan mempelajari keterampilan baru untuk mengubah situasi yang menekan. Pendekatan kedua berfokus pada pengelolaan emosi, seperti melakukan teknik relaksasi, meditasi, atau mencari dukungan sosial untuk menenangkan pikiran sebelum mengambil keputusan. Keseimbangan antara kedua pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk tetap tenang saat menghadapi badai kehidupan dan tetap mampu berpikir logis untuk mencari jalan keluar yang paling efektif (Ismail, 2025).

Membangun strategi koping adaptif merupakan sebuah proses belajar yang berkelanjutan. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah melatih komunikasi asertif agar individu dapat mengekspresikan kebutuhan mereka tanpa rasa takut atau agresivitas. Selain itu, kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda atau rebing kognitif juga menjadi bagian penting dari koping yang sehat. Dengan bimbingan tenaga profesional, individu diajak untuk mengenali kekuatan internal yang dimiliki dan memanfaatkannya sebagai tameng pelindung saat menghadapi stresor lingkungan. Kemandirian dalam menentukan cara menghadapi masalah adalah kunci utama untuk mencapai kesejahteraan psikososial yang stabil (Rosmaharani dkk., 2025).

Keberhasilan dalam menerapkan strategi koping adaptif sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan dan literasi kesehatan mental yang baik. Ketika individu merasa memiliki dukungan dari orang-orang terdekat dan memahami cara kerja emosinya, kecenderungan untuk menggunakan cara-cara yang merugikan diri sendiri akan berkurang secara signifikan. Melalui latihan yang konsisten, strategi koping ini akan berkembang menjadi karakter yang tangguh, yang tidak hanya menyembuhkan luka batin saat ini, tetapi juga menjadi modal berharga untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas dan penuh harapan di masa depan.

I. Implementasi Intervensi Psikososial bagi Pasien di Berbagai Rentang Usia

Setiap tahapan usia membawa cerita dan tantangan mental yang berbeda, sehingga pendekatan yang diberikan pun tidak bisa disamakan begitu saja. Pada anak-anak dan remaja, intervensi psikososial lebih banyak berfokus pada membangun fondasi kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Mengingat dunia mereka adalah dunia bermain dan eksplorasi, bantuan yang diberikan sering kali melibatkan aktivitas kreatif yang menyenangkan namun bermakna. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengenali emosi sejak dini dan belajar cara berkomunikasi yang sehat dengan teman sebaya maupun keluarga (Habibi, 2022).

Memasuki usia dewasa, fokus bantuan biasanya bergeser pada manajemen beban hidup yang lebih kompleks, seperti tekanan pekerjaan atau tanggung jawab keluarga. Pada fase ini, dukungan diarahkan untuk mengasah kemampuan dalam mengambil keputusan dan mengelola stres harian agar produktivitas tetap terjaga. Teknik-teknik seperti diskusi kelompok atau pelatihan kemandirian menjadi sangat relevan untuk membantu mereka tetap tangguh di tengah tuntutan peran yang besar. Pemberdayaan individu menjadi kunci utama agar orang dewasa mampu menemukan kembali keseimbangan antara karier dan kebahagiaan pribadi (Azizah & Puspitaningrum, 2025).

Kebutuhan akan pendampingan psikososial kembali berubah saat seseorang memasuki usia senja atau lansia. Pada masa ini, dukungan lebih banyak difokuskan pada upaya menjaga kualitas hidup dan memberikan rasa berharga di tengah perubahan fisik maupun sosial. Intervensi yang diberikan biasanya bertujuan untuk mencegah rasa kesepian dan menjaga fungsi kognitif agar tetap aktif. Melalui aktivitas yang melibatkan interaksi sosial dan stimulasi ingatan, lansia dibantu untuk tetap merasa terhubung dengan lingkungan sekitarnya dan menjalani masa tua dengan lebih bermakna serta penuh kedamaian (Zahro dkk., 2025).

Memahami keunikan dari setiap rentang usia ini memungkinkan pelayanan kesehatan jiwa menjadi lebih tepat sasaran dan manusiawi. Keberhasilan asuhan psikososial sangat bergantung pada kemampuan pemberi layanan untuk

mendengarkan dan menyesuaikan diri dengan bahasa serta kebutuhan spesifik dari setiap generasi. Dengan pendekatan yang personal dan penuh empati, setiap individu berapa pun usianya memiliki kesempatan yang sama untuk bangkit kembali dan menjalani hidup dengan kesehatan mental yang lebih baik dan stabil.

J. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Asuhan Keperawatan Psikososial

Memperbaiki kesehatan mental bukanlah sebuah proses instan yang selesai dalam semalam, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Oleh karena itu, penting sekali untuk selalu melakukan pemantauan atau monitoring guna memastikan bahwa setiap langkah bantuan yang diberikan sudah berada di jalur yang benar. Monitoring ini bukan sekadar mengecek hasil akhir, melainkan memperhatikan perubahan-perubahan kecil namun berarti dalam keseharian, seperti cara seseorang mulai berani menyapa tetangga atau bagaimana ia tetap tenang saat menghadapi hari yang melelahkan. Dengan pengamatan yang tulus, setiap kemajuan bisa diapresiasi dan setiap hambatan bisa segera dicarikan solusinya (Kurniawan dkk., 2020).

Untuk mengetahui apakah proses bantuan ini berjalan sukses, ada tiga tanda utama yang biasanya menjadi perhatian:

1. Peningkatan Kemandirian

Sejauh mana seseorang mulai mampu mengurus keperluan dirinya sendiri dan menjalani rutinitas harian dengan rasa percaya diri tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain.

2. Kestabilan Emosi

Berkurangnya rasa cemas atau sedih yang terlalu mendalam, serta munculnya kemampuan untuk tetap berpikir jernih dan tenang meskipun sedang menghadapi masalah yang cukup berat.

3. Kualitas Interaksi Sosial

Adanya keinginan yang tulus untuk kembali mengobrol, berbagi cerita, dan menjalin hubungan yang baik dengan keluarga maupun teman tanpa ada lagi rasa curiga atau takut yang berlebihan (Suryaningsih dkk., 2024).

Selain melihat tanda-tanda tersebut, evaluasi juga sangat mementingkan kenyamanan bagi orang yang dibantu. Sangat penting untuk mendengar pendapat mereka tentang apakah metode yang diberikan, seperti latihan napas atau diskusi kelompok, benar-benar membuat hati merasa lebih ringan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tidak hanya merasa gejalanya berkurang, tetapi juga mulai memiliki semangat dan harapan baru untuk menata masa depan. Catatan mengenai setiap kemajuan ini akan menjadi panduan berharga untuk

menentukan langkah selanjutnya dalam perjalanan menuju pemulihan total (Aini, 2019).

Pada akhirnya, tahap evaluasi adalah momen yang indah untuk merayakan setiap kemenangan kecil yang berhasil diraih. Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat dan kasih sayang dari lingkungan sekitar, kesehatan jiwa yang stabil bukanlah sekadar mimpi. Dengan sistem pantauan yang baik, proses pemulihan akan terasa lebih terarah dan manusiawi. Setiap keberhasilan yang tercatat merupakan bukti nyata bahwa setiap orang berhak dan bisa bangkit kembali untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan bermakna.

K. Penutup

Kesehatan jiwa adalah harta yang sangat berharga agar setiap orang bisa menikmati hidup dengan lebih bermakna. Perjalanan untuk memulihkan batin memang memerlukan waktu dan kesabaran, namun setiap langkah kecil yang diambil adalah sebuah kemenangan besar untuk diri sendiri. Dengan memahami cara menghadapi masalah, berlatih menenangkan pikiran, serta berani mencari dukungan, setiap tantangan mental yang hadir bukan lagi menjadi akhir dari segalanya, melainkan proses untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh (Putri & Laeli, 2024).

Kunci utama agar perasaan tetap stabil dalam jangka panjang adalah adanya kerja sama antara bantuan profesional dan kemauan diri sendiri untuk berubah. Dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat berfungsi sebagai pelindung yang memberikan rasa aman dan penerimaan tanpa syarat. Keberhasilan melewati masa-masa sulit membuktikan bahwa kedamaian hati bisa diraih kembali, asalkan ada keberanian untuk terus mencoba dan beradaptasi dengan keadaan. Setiap orang, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan ketenangan batin dan kesempatan untuk kembali hidup bahagia di tengah lingkungan sosialnya (Delice Vebrida Pobas dkk., 2025; Suwardiman, 2023)

Sebagai kesimpulan, menjaga kesehatan mental adalah investasi terbaik seumur hidup. Berbagai cara yang telah dibahas mulai dari mengatur pola pikir, melakukan relaksasi, hingga aktif dalam kegiatan kelompok, diharapkan bisa menjadi bekal yang bermanfaat saat menghadapi ketidakpastian hidup. Dengan terus mempraktikkan kebiasaan yang sehat bagi jiwa, masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan akan selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang memilih untuk melangkah menuju perubahan yang lebih baik.

Referensi

- Aini, D. K. (2019). Penerapan Cognitive Behaviour Therapy dalam Mengembangkan Kepribadian Remaja di Panti Asuhan . Jurnal Ilmu Dakwah, 39(1), 70–90.
- Ananda, N. P. L., Supartha, I. G. N. A., Putri, D. M. F. S., & Apriani, D. G. Y. (2025). HUBUNGAN KEMAMPUAN KOPING DENGAN KESEHATAN MENTAL PADA REMAJA DI SMK SANJIWANI GIANJAR. Jurnal Nawacita Usad, 1(1).
- Azizah, A. N., & Puspitaningrum, N. E. S. (2025). Penerapan Dukungan Sosial Untuk Meningkatkan Resiliensi Pada Klien Psikoterapi Di Lembaga Psikologi X. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(4), 1360–1368.
- Beck, J. S. (2011). Cognitive Behavior therapy. The Guilford Press.
- Delice Vebrida Pobas, Reashly Mokola, Christina Nayoan, & Noorce Ch. Berek. (2025). Peningkatan Literasi Kesehatan Mental Remaja melalui Penyuluhan Interaktif di STIKes Maranatha Kupang. Compromise Journal Community Proffesional Service Journal, 3(3), 01–10. <https://doi.org/10.57213/compromisejournal.v3i3.806>
- Habibi, M. M. (2022). Penanganan Kecemasan pada Anak Usia Dini Melalui Terapi Bermain. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7(1), 156–162.
- Halter, M. J, & Varcarolis, E. M. (2014). Varcarolis' foundations of psychiatric mental health nursing: a clinical approach. Elsevier.
- Ismail, I. (2025). Tingkat Stres, Sumber Stres, dan Strategi Koping Mahasiswa: Sebuah Analisis Profil di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa, 5(2).
- Kurniawan, D., Kumalasari, G., & Fahrany, F. (2020). KEPERAWATAN JIWA KELUARGA: Terapi Psikoedukasi Keluarga ODGJ. Literasi Nusantara.
- Luthfiyasha, F. F., Oktaviana, W., & Su'ib, A. (2025). PENGARUH TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK STIMULASI PERSEPSI SENSORI DAN EXPRESS FEELING TERHADAP PENURUNAN TINGKAT HALUSINASI PENDENGARAN. JURNAL NERS: Research & Learning in Nursing Science, 9, 3321–3326.
- Nabila, Damayanti, R., Agustriyani, F., & Ardinata. (2025). Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kemampuan Bersosialisasi Pada Siswa Kelas x Di SMA Negeri 1 Gading Rejo. Health Research Journal of Indonesia, 3(6), 327–334. <https://doi.org/10.63004/hrji.v3i6.546>
- Nurchayani, I., & Fauzan, L. (2016). EFEKTIVITAS TEKNIK RELAKSASI DALAM KONSELING KELOMPOK BEHAVIORAL UNTUK MENURUNKAN STRES BELAJAR

- SISWA SMA. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 1(1), 1–6.
<https://doi.org/10.17977/um001v1i12016p001>
- Pangestu, D. W., & Widodo, A. (2017). Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Sosial Terhadap Kemampuan Komunikasi Verbal Klien Menarik Diri. *Berita Ilmu Keperawatan*.
- Pongdatu, M., Suzanna, Yati, M., Armayani, Antari, I., Florensa, Mulyanti, Dekawaty, A., & Fauziah, S. (2023). Asuhan Keperawatan Jiwa (Suzanna, E. H. Mujahid, & L. Rangki, Ed.). Eureka Media Aksara.
- Putri, A. E., & Laeli, S. (2024). Membangun Resiliensi Sepanjang Rentang Kehidupan: Strategi Menghadapi Tantangan dan Tekanan. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6846–6854.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13871>
- Rosmaharani, S., Rodiyah, & Noviana, I. (2025). Peningkatan Status Kesehatan Jiwa Keluarga Yang Memiliki Anak Retardasi Mental Melalui Psikoedukasi Keluarga. *JURNAL KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH*, 10(4).
- Stanhope, Marcia., & Lancaster, Jeanette. (2020). *Public health nursing: population-centered health care in the community*. Elsevier.
- Stuart, G. Wiscarz. (2014). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. Elsevier Health Sciences.
- Sujarwo, S., & Puspita, D. (2025). Penerapan Teknik Relaksasi dan Manajemen Stres Untuk Mengurangi Stres pada Masyarakat Desa Limbang Jaya II. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 4(1), 17–23.
<https://doi.org/10.29303/jpimi.v4i1.6100>
- Suryaningsih, C., Arna, Y. D., Nurullita, D., Nasus, E., Sitohang, T. R., Mustika, I. W., Heryana, N. R., Abdurrachim, R., Pesak, E., Suranata, F. M., Abqariah, Rusmali, Kristiana, A., Saswati, N., Harkomah, I., & Rossyana. (2024). *BUNGA RAMPAI: PSIKOSOSIAL DALAM BUDAYA KEPERAWATAN* (Alifariki, La Ode). PT Media Pustaka Indo.
- Suwardiman, D. (2023). Peran Penting Keluarga dalam Peran Penting Keluarga dalam Menjaga dan Merawat Individu yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Faletehan Health Journal*, 10(2), 216–221.
- Tanan, R., Kutanggas, J. R., Tukayo, H., & Gobai, A. (2025). TRANSISI DARI PENGENDALIAN GEJALA MENUJU PEMULIHAN HARGA DIRI PADA PASIEN

PASCA PSIKOTIK DENGAN RIWAYAT KEKERASAN VERBAL. *Journal of Telenursing (JOTING)* , 7(6), 729–738.

Townsend, Mar., & Morgan, Karyn. (2017). *Psychiatric Mental Health Nursing*.

Tukatman, Pranata, A. D., Kutuuk, H. M., Yati, M., Emilia, N. L., Sari, M. T., Suri, M., Saswati, N., Tololiu, T. A., Suhardono, Agustine, U., Daryanto, Syukri, M., Laoh, J. M., Erlin, F., Lombogia, M., Rangki, L., & Rahmawati. (2023). *Keperawatan Jiwa* (L. Rangki & Rahmawati, Ed.). Pustaka Aksara.

Videbeck, S. L., & Miller, C. J. (2023). *Psychiatric-mental health nursing*. Wolters Kluwer.

Wheeler, K. (2022). *henurse psychotherapist and a framework for practice*. In K. Wheeler (Ed.), *Psychotherapy for the advanced practice psychiatric nurse: A how-to guide for evidence-based practice*.

Zahro, Y. F., Ikhwan, M. N., Nikmah, N., Mahdani, H. R., Qolbina, S. El, Valentino, T., Setyani, A. N., Anisa, R. S., Nuryanti, F. I., & Hikmah, S. (2025). Reminiscence sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Lansia di Panti Jompo. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 3(3), 233–246.

BAB VI

KRISIS PSIKOLOGIS DAN KEGAWATDARURATAN PSIKIATRI

A. Pendahuluan

Krisis merupakan hal yang ada di hidup sehari-hari. Hampir semua orang pernah mengalaminya pada suatu waktu dalam hidupnya. Menurut definisinya, krisis dapat diartikan sebagai suatu persepsi atau pengalaman terhadap suatu peristiwa yang sangat berat dan sulit, dan melampaui kapasitas sumber daya dan mekanisme koping individu. Individu yang mengalami krisis akan mengalami reaksi krisis yang terjadi segera setelah peristiwa mencekam tersebut. Reaksi ini dapat berupa perasaan terkejut, sedih, marah, putus asa, cemas, dan gelisah. Melihat naturnya yang menjadikan kemampuan koping tidak lagi efektif, individu yang mengalami krisis ataupun trauma seringkali akan menghadapi kesulitan dalam mengambil tindakan yang efektif untuk mengatasi masalahnya. Sebaliknya, individu justru akan berperilaku secara maladaptif.

B. Krisis Psikologis

Krisis kesehatan mental adalah keadaan darurat perilaku atau kejiwaan di mana seseorang mengalami tekanan emosional atau psikologis yang luar biasa yang mengganggu fungsi sehari-hari atau menimbulkan risiko bagi diri sendiri atau orang lain. Krisis kesehatan mental memerlukan intervensi segera dan mencakup pikiran untuk bunuh diri, psikosis, melukai diri sendiri, atau agitasi ekstrem. Tidak seperti stres emosional umum, krisis mengganggu pemikiran, perilaku, dan keselamatan, sehingga memerlukan perawatan mendesak.

Krisis psikologis adalah keadaan darurat emosional sementara, dimana seseorang mengalami tekanan hebat akibat peristiwa traumatis atau stres berat, yang menyebabkan ketidakseimbangan mental, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan menggunakan mekanisme koping biasa. Ini bukanlah penyakit mental, melainkan reaksi normal terhadap situasi abnormal yang mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Krisis psikologis memerlukan penanganan segera untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih parah seperti gangguan mental atau tindakan membahayakan diri sendiri.

C. Kegawatdaruratan Psikiatri

Kegawatdaruratan psikiatri (*psychiatric emergency*) adalah kondisi mental akut yang membutuhkan penanganan segera untuk mencegah bahaya bagi pasien dan/atau orang lain. Ini bisa disebabkan oleh gangguan pikiran, perilaku, suasana hati, atau hubungan sosial yang memerlukan intervensi medis atau psikologis yang cepat. Kedaruratan psikiatri merupakan keadaan yang tak terduga dengan potensi katastrofik, dengan demikian diharapkan praktisi kesehatan mental harus siap untuk mengatasi krisis seperti keinginan bunuh diri, agitasi dan agresi, serta keadaan *confusional state*.

Banyak penyakit medis umum yang memberikan gejala gangguan perilaku dan dapat menyebabkan perubahan dalam berpikir dan mood. Berbagai gejala tersebut menyebabkan peningkatan keterlibatan psikiatri dalam pelayanan kedaruratan. Saat ini juga telah banyak pasien dengan alasan medis yang datang dengan ciri-ciri kepribadian dan mekanisme koping yang maladaptif yang dapat mempersulit penatalaksanaan medisnya. Dalam semua situasi ini, peran psikiater sebagai konsultan dan penghubung dapat menjadi sangat penting dalam memfasilitasi perawatan yang tepat. Psikiater hendaknya mampu dalam mengelola pasien yang mengalami kegawatdaruratan, mengelola masalah sistem rumah sakit, informasi tentang penyakit medis dan psikiatri, terampil dalam konflik resolusi, etis dan legal tentang tanggung jawab untuk keamanan pasien, dan mampu melayani sebagai pemimpin tim yang bisa terjun langsung dalam krisis (Riba, et al., 2010).

Secara keseluruhan, kedaruratan psikiatri merupakan bidang yang masih terus berkembang. Klinisi diharapkan memiliki kemampuan atau keahlian pada *consultation-liaison psychiatry*, manajemen krisis, *brief psychotherapy*, *risk assessment* dan pengetahuan yang luas mengenai pengobatan, sistem pelayanan rumah sakit dan kesehatan, serta psikiatri secara umum. (Riba et al., 2010).

Berdasarkan konsensus yang dikembangkan oleh *American Psychiatric Association* (APA) menyebutkan bahwa kedaruratan psikiatri adalah gangguan yang bersifat akut, baik pada pikiran, perilaku, atau hubungan sosial yang membutuhkan intervensi segera yang didefinisikan oleh pasien, keluarga pasien, atau masyarakat. (Trent, 2013).

Tujuan pelayanan kedaruratan psikiatri adalah untuk: 1) memberikan perawatan tepat waktu atas kedaruratan psikiatri, 2) adanya akses perawatan yang bersifat lokal dan berbasis masyarakat, 3) menyingkirkan etiologi perilaku pasien yang mungkin mengancam nyawa atau meningkatkan morbiditas medis, dan 4) berjalannya kesinambungan perawatan. (Allen et al., 2002; Sadock and Kaplan, 2009)

Proses evaluasi di kedaruratan psikiatri antara lain: 1) wawancara kedaruratan psikiatri, 2) pemeriksaan fisik, dan 3) pemeriksaan penunjang. Hal hal yang sebaiknya

dievaluasi pada pasien yang dirujuk ke bagian psikiatri adalah risiko bunuh diri, risiko kekerasan (*violence*), dan penilaian psikososial. Hal-hal yang harus diperhatikan di seting kedaruratan yaitu, 1) agitasi dan agresi, 2) withdrawal (lepas zat), 3) intoksikasi zat, 4) kekerasan domestik, 5) kekerasan pada anak, 6) kekerasan pada lansia, dan 7) perkosaan. (Heriani, et al., 2010; Trent, 2013; Sadock and Kaplan, 2009).

Perawatan di kedaruratan psikiatri biasanya berfokus pada manajemen perilaku dan gejala. Proses pengobatan dilakukan bersamaan dengan proses evaluasi (jika pemberian terapi telah memungkinkan). Wawancara awal tidak hanya berfungsi untuk memperoleh informasi diagnostik yang penting, tetapi juga untuk terapi. Dalam melakukan proses evaluasi, bila fasilitas tidak memadai, dapat dilakukan perujukan pada fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki fasilitas yang cukup untuk penatalaksanannya. (Sadock and Kaplan, 2009; Trent, 2013)

Modalitas terapi yang digunakan untuk seting kedaruratan psikiatri antara lain: 1) farmakoterapi, 2) seclusion (isolasi) dan *restraint* (fiksasi fisik), dan 3) psikoterapi. (Knox dan Holloman, 2011; Riba et al., 2010; Sadock and Kaplan, 2009). Kedaruratan psikiatri memerlukan penatalaksanaan dalam waktu yang tepat dan keahlian interpersonal. Suatu krisis merupakan kesempatan untuk membantu dan jika memungkinkan melakukan perubahan, sehingga suatu pelayanan krisis tidak hanya sederhana mengumpulkan data dan mengirim pasien ke tempat lain, namun diperlukan suatu proses interpersonal yang terjadi antara pasien dan staf di kedaruratan. (Allen et al., 2002).

D. Agitasi

Agitasi adalah perasaan gelisah, tegang, marah, atau jengkel yang ekstrem, sering kali disertai perilaku fisik tak bertujuan seperti mondar-mandir atau meremas tangan. Kondisi ini bisa berupa gejala gangguan mental/stres emosional (psikologis) atau hasutan politik untuk memicu perlawanan massa (sosial). Agitasi adalah keadaan gelisah atau mudah tersinggung yang ekstrem. Seseorang yang mengalami agitasi mungkin merasa cemas, bingung, atau tegang. Agitasi dapat bermanifestasi dalam berbagai perilaku seperti mondar mandir, berbicara cepat, berteriak, atau bahkan melakukan kekerasan.

Adapun beberapa penyebab agitasi yang perlu diketahui, baik secara psikologis maupun medis. Penyebab akibat faktor psikologis yaitu: Stres seperti pekerjaan yang menumpuk atau lingkungan kerja yang tak sehat. Selain itu, stres karena jadwal sekolah yang padat juga dapat menimbulkan agitasi pada remaja. Sedang merasakan *burnout*, yaitu kondisi stres kronis dimana seseorang merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional. Hal ini dapat disebabkan oleh situasi

seperti pekerjaan atau rutinitas yang membosankan. Tekanan dari teman sebaya. Sedang berduka akibat kesedihan tertentu, seperti meninggalnya orang terdekat.

Sementara itu, ada beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan agitasi meliputi: Siklus menstruasi yang terganggu, bagi mereka yang memiliki gangguan *dysphoric* pramenstruasi (PMDD). Mengidap gangguan kecemasan atau suasana hati, seperti depresi atau gangguan bipolar. Kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon, seperti hipotiroidisme. Ketergantungan atau sedang mengalami sakaw (putus asupan) dari alkohol. Penggunaan obat-obatan terlarang yang menyebabkan perubahan suasana hati dan perilaku. Mengidap gangguan perkembangan tertentu, seperti autisme. Pada kasus yang jarang agitasi juga dapat terjadi akibat gangguan neurologis, seperti mengidap tumor otak.

E. Delirium

Delirium adalah gangguan kesadaran, fungsi kognitif, dan perhatian yang terjadi secara akut (tiba-tiba) dan berfluktuasi. Kondisi ini menyebabkan kebingungan parah, disorientasi, serta penurunan kesadaran terhadap lingkungan, sering kali disebabkan oleh penyakit fisik, infeksi, atau efek samping obat, dan umumnya dapat disembuhkan. Delirium adalah kebingungan atau linglung parah yang menyebabkan penderitanya sulit fokus dan berpikir. Pasien delirium juga kerap gelisah dan sulit mengenal orang di sekitarnya, waktu, tanggal, atau lokasi di tempat ia berada. Delirium umumnya terjadi karena adanya gangguan pada otak. Delirium adalah kondisi medis serius yang dapat disebabkan oleh penyakit fisik atau gangguan mental berat. Penderita delirium umumnya tampak seperti sedang mengigau atau melamun mirip dengan orang yang mengalami demensia.

Meski gejalanya mirip, delirium dan demensia merupakan kondisi yang berbeda. Delirium bersifat sementara, bisa diobati, dan tidak selalu menimbulkan gangguan memori. Sementara itu, demensia diawali dengan gejala ringan kemudian memburuk seiring waktu dan umumnya menimbulkan gangguan mengingat. Kebanyakan kasus demensia juga tidak dapat disembuhkan, tapi penanganan bisa dilakukan untuk mencegahnya makin parah.

Delirium terjadi ketika terdapat gangguan pada fungsi otak untuk berpikir dan mengatur serta menyimpan berbagai informasi. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai kondisi berikut: Stroke, Kadar gula darah rendah (hipoglikemia), Cedera kepala berat, termasuk diffuse axonal injury, Gangguan elektrolit, seperti hypomagnesemia, Keracunan alkohol atau berhenti minum alkohol secara tiba-tiba (alcohol withdrawal), Penyalahgunaan NAPZA dan kondisi putus obat (withdrawal syndrome), Penyakit infeksi yang parah, seperti sepsis, meningitis, ensefalitis, pneumonia, infeksi saluran kemih, atau COVID-19, terutama yang terjadi

pada lansia, Serangan asma yang berat, Keracunan, misalnya karena mengonsumsi kecubung, keracunan sianida atau karbon monoksida, Kanker atau tumor pada otak, Efek samping obat bius akibat operasi atau prosedur medis lain, Penyakit yang parah, seperti gagal ginjal, gangguan keseimbangan elektrolit, ensefalopati hepatic, atau ketoasidosis diabetik (KAD), Dehidrasi berat atau malnutrisi berat, Kelebihan dosis obat-obatan, seperti obat tidur, antihistamin, kortikosteroid, obat antikejang, obat penyakit Parkinson, dan obat penstabil mood, Gangguan otak akibat kekurangan vitamin B1 parah (sindrom Wernicke-Korsakoff).

Delirium lebih sering terjadi pada orang dengan kondisi berikut: Sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, terutama di ICU, Menerima obat bius total untuk tindakan operasi, Berusia di atas 65 tahun, Menderita penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada otak, misalnya demensia, stroke, atau penyakit Parkinson, Menderita penyakit yang dapat menyebabkan nyeri berat, seperti kanker, Mengalami penyakit metabolik, seperti diabetes, yang tidak terkontrol baik.

Delirium ditandai dengan perubahan kondisi mental yang dapat berlangsung selama beberapa jam atau hari. Perubahan ini bisa hilang dan timbul sepanjang hari, tetapi terkadang bisa lebih sering muncul pada malam hari. Gejala utama yang dapat terjadi pada delirium adalah: kesadaran terhadap lingkungan sekitar berkurang, kemampuan berpikir yang buruk (gangguan kognitif), gangguan emosional, perubahan perilaku.

F. Intoksikasi/Putus Zat

Intoksikasi adalah istilah medis untuk keracunan. Ini adalah kondisi sementara, namun berbahaya, yang terjadi ketika zat asing (racun) masuk ke dalam tubuh dan mengganggu fungsi sel, organ, atau sistem saraf pusat. Keracunan atau intoksikasi adalah suatu kejadian apabila substansi yang berasal dari alam ataupun buatan yang pada dosis tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan hidup yang bisa menyebabkan cedera atau kematian. Racun dapat memasuki jaringan hidup melalui beberapa cara yaitu termakan, terhirup, disuntikkan. Dengan berbagai macam penyebab dari keracunan misalnya keracunan botolium, keracunan jamur, keracunan keracunan jengkol, keracunan ikan laut, dan keracunan bahan kimia yang menimbulkan gejala-gejala seperti mual, muntah, wajah kemerahan (Raini, 2012). Keracunan atau intoksikasi menurut WHO adalah kondisi yang mengikuti masuknya suatu zat psikoaktif yang menyebabkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, afek, perilaku, fungsi, dan respon psikofisiologis. Gejala intoksikasi sangat bervariasi dan bergantung pada beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut meliputi jenis zat yang masuk, jumlah atau dosisnya, jalur paparan, serta respons individu terhadap

racun. Tidak semua orang akan menunjukkan gejala yang sama, bahkan dengan paparan zat yang identik.

G. Self Harm

Self-harm adalah tindakan menyakiti atau melukai diri sendiri secara sengaja, sering kali dilakukan untuk mengatasi tekanan emosional yang berat, kecemasan, depresi, atau perasaan negatif yang tertahankan. Ini merupakan perilaku berbahaya yang menjadi pelampiasan emosi, bukan tujuan untuk mengakhiri hidup (bunuh diri), meskipun dalam beberapa kasus bisa berisiko fatal. Self harm adalah tindakan menyakiti atau melukai diri sendiri secara sengaja untuk melepaskan tekanan emosional yang terasa terlalu berat dan tidak mampu diungkapkan. Perilaku ini membahayakan fisik maupun mental sehingga perlu mendapatkan penanganan segera. Self harm di kalangan remaja kadang disebut dengan istilah "nge-barcode." Istilah ini menggambarkan tindakan melukai tubuh dengan benda tajam hingga meninggalkan bekas menyerupai garis-garis di kulit. Perilaku ini kerap dianggap sebagai pelampiasan emosi, padahal berisiko membahayakan diri sendiri.

Perilaku self harm bisa muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa contoh yang sering terjadi antara lain melukai tubuh dengan benda tajam, menggigit memukul tubuh hingga memar, membakar diri dengan benda panas, atau membenturkan kepala. Ada pula yang menarik rambut sampai rontok atau menelan zat berbahaya, misalnya obat nyamuk cair. Self harm umumnya bukan bertujuan untuk mengakhiri hidup. Meski demikian, tindakan ini bisa berujung pada percobaan bunuh diri di kemudian hari jika tidak segera ditangani.

Tindakan self harm sering kali disembunyikan sehingga sulit dikenali oleh orang sekitar. Namun, ada beberapa tanda fisik dan perubahan perilaku yang dapat menjadi petunjuk bahwa seseorang mungkin melakukan self harm, seperti: Terdapat sejumlah luka yang berulang, seperti luka gores, luka bakar, luka memar, atau luka sayat, di bagian tubuh tertentu, seperti lengan, pergelangan tangan, atau paha, Terdapat area kulit kepala dengan rambut yang tampak menipis atau malah botak akibat sering menarik rambut sendiri (trikotilomania), Menyembunyikan luka dan menghindari pembicaraan saat ditanya penyebabnya, Menunjukkan gejala depresi, seperti sering merasa sedih atau malah marah, putus asa, atau merasa tidak berharga, Menarik diri dari keluarga atau teman, dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian, Memiliki kebiasaan menyalahkan diri sendiri dan menunjukkan perasaan bersalah secara berlebihan atas hal-hal kecil, Menunjukkan perilaku impulsif, seperti memukul benda keras, Kesulitan mengungkapkan perasaan atau menolak bicara tentang apa yang sedang dirasakan, Mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh untuk menyembunyikan luka.

Self harm biasanya muncul sebagai cara untuk melampiaskan amarah, mengurangi rasa frustrasi atau kesedihan yang mendalam, serta mengekspresikan perasaan bersalah, putus asa, atau benci terhadap diri sendiri. Tindakan ini sering kali menjadi pelarian dari tekanan emosional yang sulit dihadapi atau diungkapkan.

Bagi sebagian orang, self harm juga dilakukan untuk mengalihkan rasa sakit batin ke rasa sakit fisik. Rasa sakit di tubuh dianggap lebih mudah dikendalikan dibandingkan luka emosional yang dirasakan, sehingga menyakiti diri menjadi cara untuk "mengalihkan" penderitaan batin.

Beberapa orang melakukan self harm karena merasa kehilangan kendali atas hidupnya dan ingin menguasai kembali sesuatu, setidaknya tubuhnya sendiri. Ada pula yang melakukannya karena ingin kembali merasakan sesuatu setelah mengalami mati rasa secara emosional atau emotional numbness.

Ada berbagai faktor yang dapat memicu seseorang melakukan self harm, antara lain: Mengalami pelecehan atau trauma di masa lalu, Menderita gangguan mental, seperti depresi, gangguan kecemasan, post-traumatic stress disorder (PTSD), atau gangguan kepribadian, Kesulitan mengelola emosi dan stress, Tekanan dari lingkungan, seperti tuntutan keluarga, masalah di sekolah, atau konflik sosial, Perasaan sendirian, tidak dipahami, atau tidak dihargai oleh orang sekitar, Penyalahgunaan NAPZA atau kecanduan alkohol.

H. Stabilisasi Awal

Stabilisasi awal pada krisis psikologis bertujuan menenangkan individu yang kewalahan, memastikan keamanan fisik/emosional, dan mengurangi distress akut melalui Psychological First Aid (PFA). Teknik ini melibatkan pendekatan "Look, Listen, Link," relaksasi sederhana, pemenuhan kebutuhan dasar, serta menghubungkan korban dengan dukungan sosial untuk mencegah dampak trauma jangka Panjang.

I. Rujukan

SDGs dengan 17 target diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, khususnya pada target ketiga perlu untuk dicapai untuk menjadikan Indonesia bisa menjadi lebih baik, seperti pada paparan saya diatas. Nawacita dengan sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

J. Penutup

SDGs dengan 17 target diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, khususnya pada target ketiga perlu untuk dicapai untuk menjadikan Indonesia bisa menjadi

lebih baik, seperti pada paparan saya diatas. Nawacita dengan sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

Referensi

- Alfianto, A. G., & Jayanti, N. D. (2020). Kegawatdaruratan Psikiatri Metode Restraint Safety. Jurnal Kreativitas.
- Allen, H., et al. (2002). Emergency Psychiatry (Review of Psychiatry Series, Vol 21).
- Anderson, K., Goldsmith, L. P., Lomani, J., Ali, Z., Clarke, G. (n.d.). Manajemen Kegawatdaruratan Psikiatri.
- Cahyono, Wahyu. (2015). Psychological First Aid "Sebuah Kesiapsiagaan Dari Kita Untuk Kita." Depok: Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Davidson, G.C., Neale, J.M. & Kring, A.M. (2010). Psikologi Abnormal. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kemkes RI. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.
- Riba, Michelle B., Parikh, Sagar V., & Greden, John F. (2019). Mental Health in the Workplace. USA: Integrating Psychiatry and Primary Care.
- Rokayah, C., & Indarna, A. A. (2023). Gambaran Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Psikiatri di Instalasi Gawat Darurat.
- Yuliani, et al. (2023). Kurikulum Pelatihan Keperawatan Kegawatdaruratan Psikiatri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa.

BAB VII

PEMULIHAN, REHABILITASI, DAN KEPERAWATAN JIWA KOMUNITAS

A. Pendahuluan

Pemulihan keperawatan jiwa (recovery) adalah proses transformasi, bukan sekadar hilangnya gejala, yang memungkinkan individu dengan gangguan jiwa hidup bermakna, mandiri, dan produktif di komunitas. Fokus utama meliputi pemberdayaan diri, dukungan sosial (keluarga/lingkungan), pengobatan berkelanjutan, serta rehabilitasi psikososial untuk mencapai potensi penuh.

B. Pemulihan

Pemulihan merupakan suatu proses maupun cara yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa berat agar mampu menjalani kehidupan dengan penuh harapan dan tujuan hidup yang konstruktif. Pemulihan juga diartikan sebagai suatu proses yang dinamis dimana perawatan yang akan dijalani oleh penderita disesuaikan dengan kebutuhan dan keunikan karakteristik penderita.

C. Rehabilitasi

Serangkaian tindakan sosial, edukasi, dan perilaku yang bertujuan memulihkan fungsi fisik, mental, dan sosial pasien gangguan jiwa (ODGJ) agar mandiri dan produktif. Program ini berfokus pada peningkatan keterampilan hidup, sosial, dan vokasional (bekerja) guna meningkatkan kualitas hidup dan mempermudah reintegrasi ke masyarakat.

Rehabilitasi adalah proses membantu individu kembali pada tingkat fungsi yang tertinggi dari tingkat kemampuan fungsionalnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi yaitu 1) Keparahan penyakit : Keparahan penyakit dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu durasi sakit yang didukung oleh jenis diagnosa yang diderita. Durasi sakit adalah durasi sakit yang diderita pasien sejak pertama didiagnosa sakit gangguan kejiwaan oleh petugas kesehatan sampai dengan saat ini. 2) Usia : peserta yang memiliki usia lebih muda memiliki keluaran yang lebih baik (mendapatkan pekerjaan) apabila dibandingkan dengan peserta rehabilitasi yang memiliki usia lebih tua. 3) Jenis Kelamin : jenis kelamin yang dimiliki pasien gangguan jiwa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keluaran dari

rehabilitasi sosial vokasional yang dijalani untuk mendapatkan pekerjaan 4) Pendidikan : seseorang dengan pendidikan yang cukup maka berpengaruh terhadap kemampuan menerima atau menyerap informasi. Pendidikan yang tinggi atau baik maka dapat membantu penyerapan informasi yang didapat pasien dengan gangguan jiwa ketika menjalani masa rehabilitasi sosial vokasional sehingga dapat menghasilkan keluaran yang optimal. 5) Dukungan keluarga, dukungan tenaga kesehatan dan dukungan sesama pasien.

D. Keperawatan Jiwa Komunitas

Keperawatan jiwa komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional yang komprehensif, holistik, dan berbasis masyarakat. Fokusnya adalah meningkatkan derajat kesehatan jiwa, pencegahan masalah, serta pemulihan klien di lingkungannya (rumah/puskesmas). Pelayanan ini, dikenal sebagai CMHN, mencakup pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk individu dan kelompok rentan.

Community Mental Health Nursing adalah pelayanan kesehatan jiwa komunitas dengan tujuan pasien yang tidak tertangani di masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. CMHN adalah pelayanan keperawatan yang komprehensif, holistik, dan paripurna, berfokus pada masyarakat yang sehat jiwa, rentang terhadap stres dan dalam tahap pemulihan serta pencegahan kekambuhan.

CMHN merupakan salah satu strategi berupa program peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada petugas kesehatan melalui pelatihan dalam rangka upaya membantu Masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan jiwa. Pelatihan yang dilakukan terdiri dari tiga tahapan yaitu Basic, Intermediate dan Advance Nursing Training.

Ruang lingkup keperawatan kesehatan jiwa masyarakat terdiri atas berbagai rentang masalah kesehatan jiwa antara kondisi sehat dan sakit, pada usia anak sampai usia lanjut, perawatan di rumah sakit atau masyarakat, serta kondisi kesehatan jiwa di rumah ataupun di tempat khusus. Area keperawatan kesehatan jiwa masyarakat ini mencakup seluruh kasus yang terjadi pada usia anak, dewasa, usia lanjut, baik pada kasus individu, kelompok, maupun keluarga.

Upaya kesehatan jiwa masyarakat meliputi seluruh level dan Tindakan keperawatan kesehatan jiwa. Merupakan pelayanan paripurna, mulai dari pelayanan kesehatan jiwa spesialis, integratif, dan pelayanan yang berfokus masyarakat. Selain itu, memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya di masyarakat sehingga terwujud Masyarakat yang mandiri dalam memelihara kesehatannya.

E. Recovery Oriented Care

Recovery-oriented care (perawatan berorientasi pemulihan) dalam kesehatan mental adalah pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan individu untuk membangun kehidupan yang bermakna, harapan, dan otonomi, melampaui sekadar menghilangkan gejala. Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai mitra aktif, bukan objek pasif, yang memegang kendali atas perjalanan pemulihan pribadi mereka.

Dalam pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, setiap individu dianggap sebagai ahli dalam kehidupan mereka sendiri dan mengakui bahwa pemulihan melibatkan kolaborasi multidisiplin antara individu, pengasuh mereka, dan tim perawatan kesehatan yang lebih luas untuk mengembangkan pendekatan yang masuk akal bagi individu tersebut.

Setiap individu diperlakukan dengan sopan, hormat, dan jujur; kepekaan dan rasa hormat diberikan kepada setiap individu, khususnya mengenai nilai-nilai, kepercayaan, dan budaya mereka. Selain itu, diskriminasi ditentang di mana pun hal itu dirasakan, baik di tingkat individu maupun komunitas.

Tersedia beberapa kesempatan untuk evaluasi berkelanjutan di berbagai tingkatan. Pertama, pada tingkat individu, sehingga mereka dapat melacak kemajuan mereka. Kedua, layanan mempertimbangkan pengalaman perawatan individu dan menggunakannya untuk meningkatkan aktivitas selanjutnya. Terakhir, sistem kesehatan mental melaporkan hasil utama yang menunjukkan pemulihan. Hasil ini dapat bervariasi dan dapat mencakup pekerjaan, kualitas hidup, pendidikan, perumahan, hubungan interpersonal, dan kesehatan serta kesejahteraan yang lebih luas.

Perawatan yang berfokus pada pemulihan dapat membantu praktisi kesehatan dalam mengurangi potensi agresi individu serta memberdayakan individu untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Hal ini mencakup perawatan yang berwawasan trauma, pengakuan terhadap pengalaman hidup individu dan dampaknya terhadap individu, serta prinsip-prinsip pemulihan klinis dan pribadi. Para profesional kesehatan, khususnya perawat, yang mempraktikkan perawatan yang berfokus pada pemulihan, secara aktif dan dinamis melibatkan individu dalam semua tahapan pengambilan keputusan dan perencanaan perawatan.

F. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga adalah faktor krusial dalam rehabilitasi kesehatan mental, berfungsi sebagai poros utama pemulihan untuk mencegah kekambuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dukungan ini mencakup aspek emosional (empati, penerimaan), instrumental (bantuan pengobatan, logistik), informasional (edukasi), dan penghargaan (motivasi). Kehadiran keluarga yang suportif

menciptakan lingkungan aman, mengurangi stres, dan meningkatkan harga diri individu yang sedang dalam pemulihan.

Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan, dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan.

Dukungan keluarga adalah salah satu bentuk interaksi yang didalamnya terdapat hubungan yang saling memberi dan menerima bantuan yang bersifat nyata yang dilakukan oleh keluarga (suami, istri, saudara, mertua, orang tua). Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap penderitaan yang sakit. Bentuk dukungan keluarga terhadap anggota keluarga adalah secara material atau moral. Adanya dukungan keluarga akan berdampak pada peningkatan rasa percaya diri pada penderita dalam menghadapi proses pengobatan penyakitnya.

G. Stigma

Stigma adalah ciri negatif, tanda, atau stereotip buruk yang melekat pada seseorang atau kelompok akibat pandangan lingkungan sosial. Ini merupakan keyakinan negatif yang menyebabkan seseorang dipandang rendah, tidak diterima, atau didiskriminasi, sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman atau prasangka.

Stigma adalah ketidaksetujuan seseorang maupun sekelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu yang membedakan atau keberadaan mereka menjadi tidak diinginkan di lingkungan masyarakat. Stigma juga merupakan keyakinan negatif yang dimiliki seseorang untuk mendasari ketidakadilan yang dimiliki sekelompok orang tentang sesuatu. Stigma yaitu sebagai bentuk penyimpangan terhadap penilaian kepada suatu kelompok masyarakat terhadap individu yang salah dalam berinteraksi sosial.

Bentuk stigma bisa berupa stigma publik (sikap negatif masyarakat) atau self-stigma (internalisasi stigma negatif pada diri sendiri). Dampak stigma yaitu menimbulkan rasa malu, hilangnya harapan, diskriminasi, hingga mengucilkan individu dari interaksi sosial.

H. Kepatuhan Terapi

Kepatuhan terapi pengobatan jiwa adalah perilaku konsisten pasien dalam mengikuti aturan pengobatan, termasuk minum obat sesuai dosis dan waktu, serta menjalani terapi lain yang dianjurkan tenaga kesehatan. Kepatuhan ini krusial untuk keberhasilan terapi, mengurangi gejala, mencegah kekambuhan berulang, dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

I. Follow Up

Follow up dalam keperawatan jiwa adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pendampingan berkelanjutan terhadap pasien (baik rawat inap maupun jalan) pasca-intervensi untuk memastikan kepatuhan pengobatan, mencegah relaps (kambuh), dan memantau perkembangan mental. Kegiatan ini penting untuk mengevaluasi efektivitas rencana perawatan, tanda-tanda kambuh, dan transisi pasien kembali ke lingkungan sosial.

J. Kolaborasi Lintas Sektor

Kolaborasi lintas sektor dalam rehabilitasi kesehatan mental adalah penyatuan keahlian, sumber daya, dan upaya dari berbagai pihak seperti dinas kesehatan, sosial, pendidikan, perhubungan, serta komunitas untuk memberikan layanan komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan mendukung pemulihan, reintegrasi sosial, dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Melibatkan pemerintah (puskesmas, dinas sosial, Satpol PP, desa), lembaga pendidikan, komunitas lokal, kepolisian, dan masyarakat umum. Fokus meliputi pendampingan sosial pasca-perawatan, pemantauan keberlanjutan pengobatan, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma. Tujuan utama yaitu mewujudkan layanan yang terintegrasi (menghubungkan layanan medis dan sosial) agar pasien merasa diterima kembali dalam lingkungan sosial dan mandiri.

Referensi

- Hungerford C, Fox C. (2014) Persepsi Konsumen terhadap Layanan Kesehatan Mental yang Berorientasi pada Pemulihan: Analisis Studi Kasus di Australia. *Nurs Health Sci* . doi: 10.1111/nhs.12088.
- Lim E, Wynaden D, Heslop K. (2019) Mengubah praktik menggunakan perawatan berfokus pemulihan di lingkungan kesehatan mental akut untuk mengurangi agresi: Sebuah studi kualitatif. *Int J Ment Health Nurs*. doi: 10.1111/inm.12524.
- Lim E, Wynaden D, Heslop K. (2017) Perawatan yang berfokus pada pemulihan: Bagaimana hal itu dapat dimanfaatkan untuk mengurangi agresi di lingkungan kesehatan mental akut. *Int J Ment Health Nurs*. doi: 10.1111/inm.12378.
- McKenna B, Furness T, Dhital D, dkk. (2014) Perawatan berorientasi pemulihan di lingkungan perawatan kesehatan mental rawat inap akut: sebuah studi eksplorasi. *Issues Ment Health Nurse*. doi: 10.3109/01612840.2014.890684.
- McKenna B, Furness T, Dhital D, dkk. (2014) Perawatan berorientasi pemulihan di lingkungan kesehatan mental yang aman: "berjuang untuk kehidupan yang baik". *J Forensic Nurs*. doi: 10.1097/JFN.0000000000000027.

PROFIL PENULIS



Dr. Nasrun Pakaya, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Gorontalo, 18 November 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan S2 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2020. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nasrun.ners@ung.ac.id



Marita Kumala Dewi, S.Kep., Ns., MAN) Lahir di Gunungkidul, 12 Maret 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, STIKES Bethesda Yakkum tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Philippine Women's University dan lulus pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sebagai staf karyawan dengan lulusan Diploma 3 Keperawatan Saat ini penulis mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta. Penulis memiliki kepakaran dibidang keperawatan jiwa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, dan fasilitator pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: marita@stikesbethesda.ac.id
Motto: "Everything can be learned"



Kurniawati, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Sungguminasa 18 Januari 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Stikes Nani Hasanuddin tahun 2008-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 sebagai Perawat di Dinas kesehatan Kabupaten Gowa dan bertugas di Puskesmas Tonrorita sampai tahun 1999 dan di Puskesmas Parangloe 1999-2022. Saat ini penulis bekerja di STIKes Amanah Makassar sebagai Dosen DPK mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: kurnirusdi@gmail.com



Awaliyah Muslimah Suwetty, S.Kep., Ns., M.Kep. adalah seorang dosen keperawatan di STIKes Maranatha Kupang yang menaruh hati besar pada dunia kesehatan jiwa. Perjalanannya di bidang keperawatan dimulai sejak pendidikan DIII di Poltekkes Kemenkes Kupang, dilanjutkan hingga profesi Ners di Universitas Gadjah Mada, dan Magister Keperawatan di Universitas Brawijaya.

Bagi penulis, keperawatan bukan sekadar profesi, tetapi panggilan untuk hadir, mendengar, dan memahami setiap cerita di balik kondisi seseorang. Ketertarikannya pada keperawatan jiwa tumbuh dari keinginan sederhana membantu orang merasa lebih tenang, dipahami, dan tidak sendirian. Sebagai dosen, penulis aktif mengajar, meneliti, menulis, serta terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui setiap perannya, penulis berharap dapat berkontribusi dalam menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang lebih manusiawi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Email Penulis: lyasuwetty85@gmail.com



Yanti Apriyanti, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep. J. Lahir di Bandung, 29 April 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 2003 dan Program Ners tahun 2004, Akta Mengajar V pada Universitas Negeri Jakarta Pada tahun 2006, Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Keperawatan pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2023 dan Melanjutkan Pendidikan Spesialis Keperawatan Jiwa Pada Tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 sebagai Pengajar di Akper Manggala Husada Jakarta, Perawat DI RSUP Fatmawati Jakarta tahun 2010, Saat ini penulis bekerja di

Poltekkes Kemenkes Bandung mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yantiarif48@gmail.com

Motto: "Do good and make a difference "



Osep Yasier Almunsiri, S.Kep., Ners., M.Kep. Lahir di Tasikmalaya, 24 September 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023 sebagai Dosen Tetap di Horizon University Indonesia. Saat ini penulis meniti karier sebagai abdi negara sejak diterima PNS dosen pada tahun 2024 dan bekerja di Poltekkes Kemenkes Banten mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: osepyasier240996@gmail.com

Motto: *"Educate. Inspire. Empower"*



Mihrawaty S. Antu, S.Kep.,Ns.,M.Kep. Lahir di Gorontalo, 14 Maret 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 sebagai Dosen Tetap di Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini penulis bekerja di Universitas Negeri Gorontalo mengampu mata kuliah Keperawatan Psikiatri. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mihrawaty@ung.ac.id

Motto: *"Gratitude is the best attitude"*.

Sinopsis

Buku referensi Keperawatan Jiwa dan Psikososial: Asuhan Klinis Komprehensif Sepanjang Rentang Kehidupan membahas secara menyeluruh konsep, prinsip, dan praktik asuhan keperawatan jiwa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada berbagai tahap kehidupan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan, serta memiliki keterkaitan erat dengan aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, budaya, dan lingkungan.

Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep dasar kesehatan jiwa, keperawatan jiwa, masalah psikososial, komunikasi terapeutik, pengkajian status mental, proses asuhan keperawatan jiwa, serta berbagai intervensi keperawatan yang dapat diterapkan dalam praktik klinis. Selain itu, buku ini juga menguraikan masalah kesehatan jiwa dan psikososial yang dapat terjadi sepanjang rentang kehidupan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.

Buku ini juga membahas berbagai kondisi yang sering dijumpai dalam pelayanan keperawatan jiwa, seperti kecemasan, stres, depresi, gangguan konsep diri, isolasi sosial, perilaku kekerasan, gangguan persepsi sensori, kehilangan dan berduka, trauma psikologis, penyalahgunaan zat, serta masalah adaptasi akibat perubahan kehidupan. Melalui pendekatan yang komprehensif, pembaca diajak untuk memahami pentingnya pemberian asuhan yang holistik, humanis, empatik, dan berorientasi pada pemulihan pasien.

Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kesehatan jiwa dan psikososial. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional perawat dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang aman, bermartabat, berbasis kebutuhan pasien, serta sesuai dengan perkembangan ilmu keperawatan modern.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami bahwa pelayanan keperawatan jiwa tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan mental, tetapi juga mencakup upaya promosi kesehatan jiwa, pencegahan masalah psikososial, deteksi dini, pendampingan keluarga, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, buku referensi ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Buku referensi Keperawatan Jiwa dan Psikososial: Asuhan Klinis Komprehensif Sepanjang Rentang Kehidupan membahas secara menyeluruh konsep, prinsip, dan praktik asuhan keperawatan jiwa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada berbagai tahap kehidupan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan, serta memiliki keterkaitan erat dengan aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, budaya, dan lingkungan.

Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep dasar kesehatan jiwa, keperawatan jiwa, masalah psikososial, komunikasi terapeutik, pengkajian status mental, proses asuhan keperawatan jiwa, serta berbagai intervensi keperawatan yang dapat diterapkan dalam praktik klinis. Selain itu, buku ini juga menguraikan masalah kesehatan jiwa dan psikososial yang dapat terjadi sepanjang rentang kehidupan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.

Buku ini juga membahas berbagai kondisi yang sering dijumpai dalam pelayanan keperawatan jiwa, seperti kecemasan, stres, depresi, gangguan konsep diri, isolasi sosial, perilaku kekerasan, gangguan persepsi sensori, kehilangan dan berduka, trauma psikologis, penyalahgunaan zat, serta masalah adaptasi akibat perubahan kehidupan. Melalui pendekatan yang komprehensif, pembaca diajak untuk memahami pentingnya pemberian asuhan yang holistik, humanis, empatik, dan berorientasi pada pemulihan pasien.

Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kesehatan jiwa dan psikososial. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional perawat dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang aman, bermartabat, berbasis kebutuhan pasien, serta sesuai dengan perkembangan ilmu keperawatan modern.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami bahwa pelayanan keperawatan jiwa tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan mental, tetapi juga mencakup upaya promosi kesehatan jiwa, pencegahan masalah psikososial, deteksi dini, pendampingan keluarga, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, buku referensi ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-01-5 (PDF)



9

786347

756015